



IDENTIFICACION

402454

DIA/MES/AÑO

29/09/2015

APELLIDO

CUCHASKY

NOMBRE

MARGARITA

SEXO

Femenino

ESTADO CIVIL

Soltero/a

FECHA DE NACIMIENTO

12/03/1943

NACIONALIDAD

Argentina

DOCUMENTOS

DNI

DOMICILIO

MOZART 610

TELEFONO

46827559

ID506485

LOCALIDAD

CABA

OBRA SOCIAL

PAMI

150163 040301 /00 LC: 6214110

PERSONA A NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA

N: 1063 H. Kosciuk cell: 1558104763

RESUMEN DE DIAGNOSTICOS

FECHA DE INGRESO	SERVICIO	INTERNACION	CODIGO	FECHA DE EGRESO	FIRMA ACLARADA DEL PROFESIONAL
29/09/2015	GUARDIA	DIAGNOSTICO			
		Síndrome coronario Agudo. Toracodinia en estudio a descartar NAC. → PANCREATITIS			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			Agustín Pablo Seijo MD U.B.A. M.N. 142256
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			

11

C. C.

C. C.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

H. Clínica N°

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Resolución 0356/MSGC/09 - Ley N° 153 - Decretos N° 208/01 y N° 2316/03

D M A

29 9 15

HOSPITAL: GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"

Datos del paciente

A Nombre y apellido: MARGARITA CUCHASKY
Documento de Identidad: DNI ID506485

LEER CON ATENCIÓN

Este formulario contiene la información que suministra al médico sobre el estado de salud del paciente (el diagnóstico presunto o de certeza), el tratamiento que se aconseja o indica y los beneficios buscados; los riesgos que presenta este tratamiento, algún otro tratamiento o ningún tratamiento; finalmente la aceptación de la propuesta y su autorización para llevarlo a cabo o su rechazo. El presente formulario será firmado por el paciente, si no pudiera, el pariente más cercano o persona autorizada. En el reverso se encuentran las instrucciones para completar los espacios.

B Diagnóstico:
TORACODINIA PANCREATITIS

C Tratamiento y/o práctica propuestos:
PHP
ANALGESIA
ATB OXIGENO

D Beneficios buscados:
MEJORIA DEL CUADRO

E Riesgos típicos del tratamiento o práctica propuestos:
EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES COLATERALES

F Alternativas al tratamiento o práctica propuestos:
NO

G Manifestación de aceptación o rechazo: HE COMPRENDIDO LA EXPLICACION Y ACEPTO-
RECHAZO EL TRATAMIENTO (tachar lo que no corresponde).

Firma y Aclaración: *Nicolas H. Kosciuk* NICOLAS H. KOSCIUK DNI 28731776

H Observaciones y preguntas:

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A.
MN 138435

I Firmas : (aclarando nombre y apellido):

Paciente o Familiar

Testigo-DNI

[Firma]
MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A.
MN 138435
N° de Matricula

Jefe de Servicio
N° de Matricula



INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS ESPACIOS DE ESTE FORMULARIO

La confección del presente formulario quedará cumplida con las firmas de los intervinientes

Para el médico tratante:

- 1 Deberá escribir con letra clara todos los espacios, consignando en B diagnóstico los datos patológicos relevantes disponibles relacionados con su diagnóstico y tratamiento.
Si Utiliza abreviaturas, deberá aclararlas; las enmiendas o raspaduras, deberán ser salvadas.
- 2 Indicará el procedimiento diagnóstico o terapéutico de elección.
- 3 Deberá ofrecer las alternativas diagnósticas o terapéuticas, a las afecciones que padece el paciente.
- 4 Describirá los riesgos típicos del procedimiento propuesto y las consecuencias seguras. Se autoriza a agregar anexo con las posibles complicaciones u otros riesgos, en cuyo caso se hará constar su inclusión en el punto E).
- 5 Contestará todas las preguntas que el paciente formule, en caso de no haber ninguna, escribirá NINGUNA.
- 6 Dejará asentado en la Historia Clínica que se firmó el Consentimiento Informado, y que se adjunta.
- 7 En caso de no confeccionarse el Consentimiento Informado por negativa del paciente, lo dejará asentado en la Historia Clínica (según indican los Decretos Nro. 208/2001 y Nro. 2316/2033).

Para el paciente o autorizante:

- 1 Tiene el derecho a preguntar todas las características de la afección y de los tratamientos que se consideran en esta ocasión. De no haber pedidos de aclaración, se considera que entiende completamente de que se trata.
Si ha comprendido toda la explicación de la práctica, los riesgos y sus tratamientos, se deberá tachar lo que no corresponda (ACEPTO o RECHAZO), firmando y aclarando firma.
- 3 Deberá firmar y aclarar su nombre, presentando su documento al médico, ante la manifestación de no poseerlo se le tomará impresión dígito pulgar.

Para el Jefe de Servicio:

- 1 Deberá observar que se cumpla con el procedimiento indicado para este formulario.
- 2 Constatará que el formulario haya sido adjuntado a la Historia Clínica correspondiente.

OBSERVACIONES FINALES (exclusivo para el Jefe de Servicio)

Fecha:

Jefe de Servicio:

Se firman dos ejemplares: uno para la Historia Clínica y otro para archivo del Hospital

—

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

5

Identificación	HC N° 402454	CAMA BB SHOCK
Apellido y nombre	CUCHASKY, MARGARITA	
Sexo	Femenino	Edad 72 años
Obra Social	PAMI	Documento Tipo y Nro
Fecha de nacimiento	03/12/1943	Nacionalidad
Domicilio	MOZART 610	Teléfono
Estado Civil	Sin datos	DNI ID506485
Día de ingreso al hospital	29/09/2015	Argentina

MOTIVO DE INGRESO
síndrome coronario agudo

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente de 72 años de edad es traída por ambulancia del SAME por presentar dolor precordial típico de 1 hora de evolución cuando es evaluada por SAME en domicilio.

Al examen físico

TA 140/90 Fc 90 FR 20 sat 98% afebril vigil globalmente orientada sin foco neurológico, bien perfundida sin edemas sin falla de bomba aguda. BMV con hipoventilación bibasal, abdomen blando depresible indoloro. rha+.

Se ingresa a shockroom se coloca vía periférica, se indica 500mg de Aas, se toman muestras para laboratorio con enzimas cardíacas. Se

realiza ECG con Ritmo regular sinusal Fc 70, Pr 0.16 Qrs angosto sin supraST, buena progresión de R en precordiales.

HGT 190.

Rx torax mala técnica impresiona infiltrado con broncograma en base derecha.
continúa control por guardia entrante.

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL

TVP anticoagulada

Osteoporosis

Deterioro cognitivo?

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:

Síndrome coronario Agudo.

Toracodinia en estudio a descartar NAC.

TRATAMIENTO:

DR.YURQUINA, CESAR (UTI) MN 120.270

IDPACIENTE: 506485/IDG: 6323 29/09/2015 07:36:21 a.m.

Agustín Pablo Seijo
MD U.B.A.
M.N. 142256

C. 7. 10.

C. 7. 10.

Apellido: KUCHASKY

Nombre: MARGARITA

Núm. Petición: 1552948

SALA DE GUARDIA

Origen: GUARDIA

Fecha Petición: 29/09/2015

Historia Clínica: 4214110

72

GUARDIA QCA. CLÍNICA

GLUCOSA	108	mg/dl	[70 - 110]
UREA	19	mg/dl	[10 - 50]
CREATININA	0.6	mg/dl	[0.5 - 0.9]
CK	77	UI/l	[24 - 190]

GUARDIA HEMATOLOGÍA

HEMATOCRITO	* 35	%	[36 - 53]
LEUCOCITOS	6.60	x10e9/L	[4.50 - 11]

GUARDIA COAGULOGRAMA

R.T.N	* 3.99		[0.9 - 1.2]
KPTT	* 38	seg	[21 - 34]

GUARDIA IONOGRAMA

SODIO	140	mEq/l	[135 - 145]
POTASIO	4.0	mEq/l	[3.5 - 5.2]
CLORO	98	mEq/l	[90 - 110]

70
- HEPARINA
- FAL
- AMULSA

17.

20)

21)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

3

Nombre y Apellido	CUCHASKY, MARGARITA	HC N°	402454
Fecha:	29/09/2015	Cama:	BB SHOCK
		Días Int.	

DIAGNOSTICO:

Síndrome coronario Agudo.

Toracodinia en estudio a descartar NAC.

14:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA

EVOLUCION: PTE LUCIDA O EN T Y E HD ESTRABLE AUSENCIOA DE SIGNOS DE FALLA DE BOMBA MOVILIZA 4 MIEMBROS Y SE ENCUENTRA CON GLASGOW 15/15. PERSISTENCIA DE DOLOR POR DEBAJO DE LAS COSTILLAS, SE INTERPRETA Y LO SEÑALA COMO EN BARRA. RESTO DEL EXAMEN FISICO SIN VARIANTES.

SE REALIZA ECOGRAFIA, VESICULA SIN LITIASIS,, CON ABUNDANTE METEORISMO Y CON REFERENCIA A ALA CABEA DEL PANCREAS COM AGRANDADA RESULTADO DE L ATROPONINA NEGATIVO SI PRESENTA AMILASEMAI A DE 3198 CON F ALCALINA DE 108, TGO 1925 GPT 127, RIN 4.05 Y KPTT 35.

SOLICITO TAC DE ABDOMEN E IC CON CIRUGIA. REPITO COAGULOGRAMA.

SOLICITO SU DERIVACION A UTI.

SELLO: DR. LUIS ALBERTO ANGULO ROSAS (MEDICO CLINICO MN 86599)

IDPTE506485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 02:26:33 p.m.

LUIS A. ANGULO ROSAS
M.N. 86599 - M.P. 39104
MEDICO

22

22

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO**DEPARTAMENTO DE URGENCIAS**

Nombre y Apellido	CUCHASKY, MARGARITA	HC N°	402454
Fecha:	29/09/2015	Cama:	BB SHOCK Días Int.

DIAGNOSTICO:

Síndrome coronario Agudo.

Toracodinia en estudio a descartar NAC.

PANCREATITIS AGUDA

17:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA

EVOLUCION: PACIENTE DE 72 AÑOS CON ANTECEDENTES DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN MIEMBRO DERECHO EN SEGUIMIENTO DESDE 2012, CON ECODOPPLER DE MIEMBRO INFERIOR EN 2013, 2014 Y 2015 TRAIDOS POR LA PACIENTE Y QUE SE ADJUNTAN EN ESTA HISTORIA CLINICA, CON EVIDENCIA DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN MIEMBRO INFERIOR, ANTICOAGULADA CON WARFARINAS(SINTRON) 2MG /DIA DESDE 2012 EN CONTROL POR HEMATOLOGIA CON GRILLA. ECG RITMO SINUSAL SIN ALTERACIONES DEL ST. RX TORAX IC MENOR A 0.5, BOTON AORTICO DESENLROLLADO. ANGULOS COSTODIAFRAGMATICOS Y COSTOFRENICO LIBRES.

TAC DE ABDOMEN SIN CONTRASTE. COMPATIBLES CON AUMENTO DE TAMAÑO DEL PANCREAS, DILATACION DEL CONDUCTO DE WIRSUNG, DILATACION DEL COLEDOCO, COMPROMISO DE LA GRASA PERIPANCREATICA.

LABORATORIO SE RECIBE TROPONINA NEGATIVA . LDH 395

CRITERIOS DE RANSON AL INGRESO PARA PANCREATITIS NO BILIAR EDAD MAYOR A 55 AÑOS, GB13500, LDH MAYOR 350, GOT MAYOR A 120. 4 CRITERIOS DE 5 AL INGRESO.

SE SOLICITA DERIVACION POR SAME A UTI.

SELLO: DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

IDPTE506485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 06:21:56 p.m.



MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A
MN 138435

23

11

23

23

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

9

Nombre y Apellido	CUCHASKY, MARGARITA	HC N°	402454
Fecha:	29/09/2015	Cama:	BB SHOCK
		Días Int.	

DIAGNOSTICO:

Síndrome coronario Agudo.

Toracodinia en estudio a descartar NAC.

PANCREATITIS AGUDA

18:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA

EVOLUCION: SE LLAMA A SAME PARA PEDIR DERIVACION A UTI, (PACIENTE PAMI 150143040501/00) RECHAZO OP 302 DR. EBOLI.

SELLO: DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

IDPTE506485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 06:49:38 p.m.

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A.
MN 138435

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

10

Nombre y Apellido	CUCHASKY, MARGARITA	HC N°	402454
Fecha:	29/09/2015	Cama:	BB SHOCK
		Días Int.	

DIAGNOSTICO:

Síndrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.

14:20 ESPECIALIDAD: CIRUGIA

EVOLUCION: PACIENTE INTERNADA EN SHOCK ROOM POR CUADRO PRESUNTIVO DE DOLOR TORACICO A DESCARTAR NEUMANIA AGUDA DE LA COMUNIDAD VS. SINDROME CORONARIO AGUDO. AL EXAMEN FISICO PRESENTA ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, LEVEMENTE DOLOROSO A NIVEL DE CENTRO ABDOMEN. SIN REACCION PERITONEAL AL MOMENTO DEL EXAMEN. SNG CON DEBITO NEGATIVO. AMILASEMIA 3198 CON FAL 108, LDH NO SE SOLICITO, GLUCEMIA 109, TGO 192, EDAD 72 AÑOS. SE SOLICITA LDH. AL MOMENTO SE INTERPRETA COMO PANCREATITIS AGUDA ALITIASICA (ECO NEGATIVA PARA LITIASIS). SE SUGIERE INVESTIGAR HIPERTRIGLICERIDEMIA.

SELLO: DR. ARMANDO VILLARROEL MEDICO CIRUJANO MP 107.187

IDPTE50648SIDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 02:56:25 p.m.



Dr. J. Armando Villarroel
Médico Univ. Bs. As.
Especialista en Cirugía General
M.N. 107.817 / M.P. 331.778



HTAL PIÑERO 029/09/15 GUARDIA

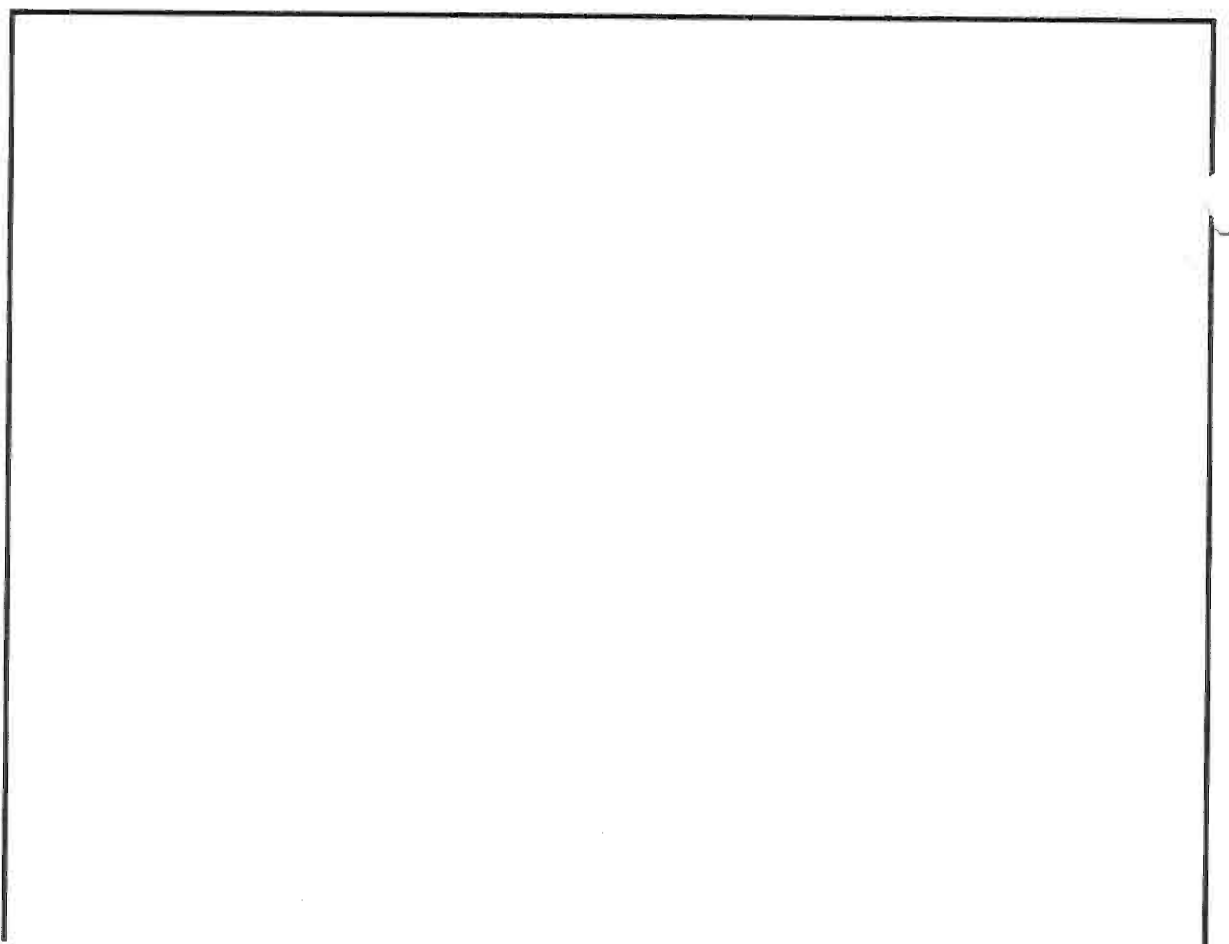
CUCHASKI, MARGARITA 72 AÑOS

PAMI 150143040501/00

SE ENTREGA DOCUMENTACION PARA TRASLADO A SANATORIO NUEVO PALERMO

1. TRES ECODOPPLER DE MIEMBROS INFERIORES TRAIOS POR LA PACIENTE
2. RUTINAS DE LABORATORIO 3 FOJAS
3. ECG
4. ECOGRAFIA ABDOMINAL
5. TAC DE ABDOMEN 2 HOJAS

MARGARITA CUCHASKI
BA
138435



"Consentimiento Informado para uso de documentación médica en el marco de la Ley 2808"Efector: **HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO**Nombre y Apellido del Paciente: **MARGARITA CUCHASKY**Exhibe documento acreditativo de identidad? **SI**Tipo: **DNI** N°: **ID506485**

Ente de Cobertura de Salud al que manifiesta afiliación:

N° de afiliado

Acompaña fotocopia de credencial: **SI - NO** (Tachar lo que no corresponda)

Quien suscribe MARGARITA CUCHASKY en su carácter de afiliado a PAMI, manifiesta por medio de la presente su expresa conformidad con el uso de antecedentes médicos que obraran en el Efector, estudios realizados y toda otra documentación relacionada con las prestaciones realizadas a los únicos fines de obtener el reintegro de los gastos por parte del ente de cobertura de salud que corresponda

SI - NO (Tachar lo que no corresponda) **MANIFIESTO MI CONFORMIDAD**

FIRMA

ACLARACION

FECHA

NOTA: Si es que suscribe es el representante legal completar

Nombre y Apellido del que suscribe

Tipo de representación (madre, padre, tutor, curador, etc.)

En caso de tratarse de tutores/curadores especificar carátula del expediente judicial donde se dirimió la tutela/curatela y juzgado actuante:

31

32



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
INFORME ESTADÍSTICO DE HOSPITALIZACIÓN

Hist. Clínica Nº:
Nº de Informe:

Establecimiento: **HOSPITAL PIÑERO**

Cód. establecimiento: **1261**

Apellido y nombre del paciente:		
Documento:	Sexo	
Fecha de nacimiento:	Edad al ingreso:	Doc. De la madre:
Residencia habitual		
Calle:		
Localidad:		
Partido:		
Provincia:	País: Argentina	
Pertenece o está asociado a:		Situación laboral:
Ocupación habitual:	Nivel de instrucción:	

Hospitalizado por:			
Fecha de ingreso	Servicio		Cama
	GUARDIA		
Fecha de egreso:	Hora de egreso:	Días de estada:	Tipo de egreso
			Alta medica 1 ☐ Defuncion 3 ☐ Otros 5 ☐
			Traslado 2 ☒ Retiro Voluntario: 4 ☐
Procedimientos quirúrgicos u obstétricos		Fecha de operación:	Días de preoperatorio:
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL AL EGRESO			CÓDIGO
Pancreatitis aguda			K85
OTROS DIAGNÓSTICOS			CÓDIGO
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS:			CÓDIGOS
OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROLONGAN LA INTERNACIÓN:			Fecha de inicio
			Días por otras circunst:

CAUSA EXTERNA DE TRAUMATISMO, ENVENENAMIENTO Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

Producido por		Lugar donde ocurrió	
1. ☐ Accidente	3. ☐ Agresiones	1. ☐ Domicilio	3. ☐ Lugar de Trabajo
2. ☐ Lesiones autoinflingidas	4. ☐ Se ignora	2. ☐ Via Publica	4. ☐ Otros

Describir las circunstancias o situación en que aconteció el hecho, por ejemplo: caída de un andamio, herido por arma de fuego, intoxicación por agroquímicos, etc.:

CODIGO:

Paciente de 72 años de edad es traída por ambulancia del SAME por presentar dolor precordial típico de 1 hora de evolución cuando es evaluada por SAME en domicilio.

Al examen físico

TA 140/90 Fc 90 FR 20 sat 98% afebril vigil globalmente orientada sin foco neurológico, bien perfundida sin edemas sin falla de bomba aguda.

Fecha de terminac. embarazo:	Peso al nacer en	Condición al nacer	Terminación	Sexo			
	Nac. vivo	Def. fetal	Vaginal	Cesárea	Masc.	Fem.	Indeter.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the

2.

3. The second part of the paper is devoted to the study of the

4. The third part of the paper is devoted to the study of the

5.

6. The fourth part of the paper is devoted to the study of the

7. The fifth part of the paper is devoted to the study of the

8. The sixth part of the paper is devoted to the study of the

9. The seventh part of the paper is devoted to the study of the

10. The eighth part of the paper is devoted to the study of the

11. The ninth part of the paper is devoted to the study of the

12. The tenth part of the paper is devoted to the study of the

13. The eleventh part of the paper is devoted to the study of the

14. The twelfth part of the paper is devoted to the study of the

15. The thirteenth part of the paper is devoted to the study of the

16. The fourteenth part of the paper is devoted to the study of the

17. The fifteenth part of the paper is devoted to the study of the

18. The sixteenth part of the paper is devoted to the study of the

19. The seventeenth part of the paper is devoted to the study of the



G.C.B.A.

HOSPITAL PARMENIO PIÑERO

HOJA DE EPICRISIS

14

Paciente CUCHASKY, MARGARITA

HC N°

402454

Servicio de Egreso DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Cama BB SHOCK

Fecha de Ingreso

29/09/2015

Fecha de Egreso

29/09/2015

Días

0

PACIENTE: CUCHASKY, MARGARITA HC N°: 402454 CAMA: BB SHOCK

FECHA DE INGRESO: 29/09/2015 FECHA DE EGRESO: 29/09/2015 DIAS DE INTERNACION: 0

MOTIVO DE INTERNACION:

síndrome coronario agudo

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente de 72 años de edad es traída por ambulancia del SAME por presentar dolor precordial típico de 1 hora de evolución cuando es evaluada por SAME en domicilio.

Al examen físico

TA 140/90 Fc 90 FR 20 sat 98% afebril vigil globalmente orientada sin foco neurológico, bien perfundida sin edemas sin falla de bomba aguda. BMV con hipoventilación bibasal. abdomen blando depresible indoloro. rha+.

Se ingresa a shockroom se coloca vía periférica, se indica 500mg de Aas, se toman muestras para laboratorio con enzimas cardíacas. Se

realiza ECG con Ritmo regular sinusal Fc 70, Pr 0.16 Qrs angosto sin supraST, buena progresión de R en precordiales. HGT 190.

Rx torax mala técnica impresiona infiltrado con broncograma en base derecha. continúa control por guardia entrante.

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL:

TVP anticoagulada

Osteoporosis

Deterioro cognitivo?

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:

Síndrome coronario Agudo.

Toracodinia en estudio a descartar NAC.

PANCREATITIS AGUDA


MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.S.A.
MN 138435

FIRMA:

DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

EGRESO COMO: TRASLADADO A OTRA INSTITUCIÓN

DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

EPICRISIS IMPRESA EL DÍA: 30/09/2015 09:09:11 a.m.IDPTE:506485IDHCG:6323

1000

1000



U401

IDENTIFICACION

41143
604824

416191

DIA/MES/AÑO

20/1/2020

APELLIDO

KUCHASKY

NOMBRE

MARGARITA LEONOR

15

SEXO

Femenino

ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO

12/5/1943

NACIONALIDAD

Argentina

DOCUMENTOS

DNI

DOMICILIO

TELEFONO

4682-7559

4214110

LOCALIDAD

CABA

OBRA SOCIAL

PAMI

PERSONA A NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA

UE SIN DEJAR DATOS

4

1524020854

Nuevas (Hijo).

RESUMEN DE DIAGNOSTICOS

FECHA DE INGRESO	SERVICIO	INTERNACION	CODIGO	FECHA DE EGRESO	FIRMA ACLARADA DEL PROFESIONAL
20/1/2020	GUARDIA	DIAGNOSTICO			
		DETERIORO COGNITIVO CRONICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			

		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
INFORME ESTADÍSTICO DE HOSPITALIZACIÓN

Hist. Clínica N°: 402454
N° de Informe:

Establecimiento: HOSPITAL PIÑERO

Cód. establecimiento: 1261

Apellido y nombre del paciente: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	
Documento: 4214110	Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 12/05/1943	Edad al ingreso: 76
Doc. De la madre:	
Residencia habitual	
Calle: MOZART 510	
Localidad: CABA	
Partido:	
Provincia:	País: Argentina
Pertenece o está asociado a: PAMI	Situación laboral:
Ocupación habitual:	Nivel de instrucción:

Hospitalizado por: síndrome confusional				
Fecha de ingreso	Servicio	Cama		
2020-01-22	GUARDIA	18		
Fecha de egreso:	Hora de egreso:	Días de estada:	Tipo de egreso	
2020-04-28		97	Alta médica: 1 ☐	Defunción: 3 ☒
			Traslado: 2 ☐	Retiro Voluntario: 4 ☐

Procedimientos quirúrgicos u obstétricos:	Fecha de operación:	Días de preoperatorio:
---	---------------------	------------------------

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL AL EGRESO	CÓDIGO
Otras infecciones locales piel y tejido subcutáneo	L08
OTROS DIAGNÓSTICOS	CÓDIGO

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS:	CÓDIGOS
---	---------

OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROLONGAN LA INTERNACIÓN:	Fecha de inicio:	Días por otras circunst:
	☐ ☐ ☐ ☐	

CAUSA EXTERNA DE TRAUMATISMO, ENVENENAMIENTO Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

Producido por	Lugar donde ocurrió		
1. ☐ Accidente	1. ☐ Domicilio	3. ☐ Lugar de Trabajo	
2. ☐ Lesiones autoinflingidas	4. ☐ Se ignora	2. ☐ Vía Pública	4. ☐ Otros
Describir las circunstancias o situación en que aconteció el hecho, por ejemplo: caída de un andamio, herido por arma de fuego, intoxicación por agroquímicos, etc.:			
CODIGO: ☐ ☐ ☐			

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP anticoagulada con síntron, deterioro cognitivo, gastritis crónica, esquizofrenia. Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Ingresa a guardia externa el 20/01, traída desde su domicilio acompañada por familiar por presentar un síndrome confusional hipoactivo.

Familiar refiere no poder hacerse cargo del cuidado de su madre, por lo que se encuentra en búsqueda de un geriátrico, por PAMI para un tercer

Fecha de terminac. embarazo:	Peso al nacer en gramos:	Condición al nacer	Término de nacimiento	Sexo
		Nac. vivo	Vaginal	Fem.



		HOSPITAL PARMENIO PIÑERO HOJA DE EPICRISIS		(17)
Paciente KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		HC N°		402454
Servicio de Egreso		UNIDAD 1 DE CLINICA MEDICA		
Cama	18	Fecha de Ingreso	Fecha de Egreso	Días
		22/01/2020	28/04/2020	97

PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 402454 CAMA: 18

FECHA DE INGRESO: 22/01/2020 FECHA DE EGRESO: 28/04/2020 DIAS DE INTERNACION: 97

ANTECEDENTES:

demencial, esquizofrenia, VGI previo a internacion: anciana geriátrica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

DIAGNÓSTICO AL INGRESO:

síndrome confusional

INTERCURRENCIAS:

*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.

*16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajustado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina. Finaliza en el día de la fecha PTZ, continua con vancomicina.

DIAGNOSTICO DE EGRESO (1):

L08-Otras infecciones locales piel y tejido subcutáneo

COMENTARIOS:

Paciente que presentaba mal estado general, VGI previa: geriátrica, en estado de abandono, con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades. Internación prolongada de causa social, con interurrencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes, la última de ellas por una infección de piel y partes blanda, bacterémica por SAMR, con mala evolución pese a tratamiento específico con antibioticoterapia.

Siendo las 00:30 del día 28 de abril de 2020, se constata óbito de la paciente.

Se intento comunicación telefónica con número de contacto(familiar-hijo) que no se hizo efectivo, se dejó mensaje en buzón de llamadas.

Se completaron formularios pertinentes, se traslado cuerpo a la morgue.

EGRESO COMO: ÓBITO

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

EVOLUCIÓN IMPRESA EL DÍA: 28/04/2020 09:07:52 a.m.IDPTE:S06485IDCM1:7135


AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

The first part of the paper discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also outlines the methodology used in the study and the data sources. The second part of the paper presents the results of the study and discusses the implications of the findings. The third part of the paper concludes the study and provides recommendations for future research.

The study was conducted using a quantitative research design. Data was collected from a sample of 100 participants. The data was analyzed using statistical software. The results of the study show that there is a significant relationship between the variables studied. The findings have important implications for the field of study.

The study was limited by several factors. First, the sample size was relatively small. Second, the study was conducted in a specific context. Third, the study did not include a control group. Despite these limitations, the study provides valuable insights into the topic.

The study was funded by the National Science Foundation. The authors would like to thank the reviewers for their helpful comments. The authors also would like to thank the participants for their participation in the study.



Buenos Aires
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA SIDA

Decr. Reglam. 1244/91, el profesional actuante debe

para la identificación de infección

que solicite laboratorio para la identificación de infección

informado a la

completar el siguiente formulario cada vez que solicite consentimiento informado a la

por HIV

Adjuntar el presente consentimiento

Historia Clínica del paciente.

HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

PARMENIO PIÑERO

Unidad: C.MEDICA UNIDAD 4 Cama: 4

Fecha: 22/1/2020

Declaro que he sido informado sobre la necesidad de someterme a las pruebas diagnósticas para la

detección de HIV (Virus del SIDA), que se me ha asegurado la confidencialidad de los resultados, así

como el asesoramiento pertinente. Por lo expuesto, consiento expresamente a que se me efectúe

dicha prueba diagnóstica.

(SI) (NO)

Embarazo: NO Teléfono: 46827559

Domicilio: MOZART 610 Documento (Tipo y N°): DNI 4214110

Historia Clínica N°: 402454

Firma del paciente

Aclaración

Viernes 28 de Febrero de 2020

SR DIRECTOR: Vengo a reclamar porque me es imposible conseguir la historia clínica de mi madre (unidad 4, cama 4, está internada actualmente). El pedido es porque según los médicos la demencia ha hecho desaparecer todas las enfermedades y todo es inventado. "No se puede saber si invento o no" dicen. Pues veamos y listo.

Concretamente el Dr Copani me dijo que vaya a Dirección Médica, nunca pude encontrar eso. En admisión y egreso me dicen que pueden tomar el pedido pero la historia clínica no les va a llegar hasta allá. Entonces me tienen boludeando de acá para allá.

Le doy un ejemplo, mi mamá se queja desde hace varios días que le duele el ano. El doctor dice que inventa, pero eso era que ya pasaba en casa, ~~incluso~~ incluso hubo veces en que ~~se~~ se sacó la mierda con la mano!!!

Disculpe mi lenguaje pero no soy médico y por tanto mi comprensión de las cosas es muy limitada. Casi rozando el analfabetismo.

Le solicito interceda para conseguir la historia.

Walter H. Voronik

DM 28731778

15-2402-0854

0404

Note Copani

11-12

1

)

)

)

)

Buenos Aires, 04 de Marzo de 2020

A Dirección Hospital Piñero

Dr. Daniel Rivero

Asunto : Respuesta reclamo Paciente Kuchasky Margarita

En relación a la nota presentada por el hijo de la paciente , se informa que el mismo se presentó en forma agresiva el día 28 de Febrero en la Unidad 4 con improperios , me presento ante el preguntándole que era lo que necesitaba , respondiendo el mismo que la madre no era atendida y que solicitaba copia de la historia clínica , se le explico que la misma no podía ser entregada desde el servicio a el ya que la paciente se encontraba internada y a espera de derivación a III nivel por la Obra social Pami (NO INICIADA EL HIJO NO SE PRESENTO A FIRMAR EL PEDIDO) y que le ofrecía un resumen de la situación actual de la misma .

La paciente tiene diagnóstico de Deterioro cognitivo severo con un AVD 0/6 , postrada , antecedentes de gastritis crónica previa a la internación en tratamiento con Ranitidina (fármaco que recibía antes del ingreso) , TVP no controlada decidiéndose riego beneficio la suspensión de la misma además de no tener indicación dado el tiempo transcurrida de la misma , Ingresa al Servicio de Clínica Medica el 23/1 con Diagnostico de Neumonía de probable mecanismo espirativo , cumple tratamiento para tal fin , encontrándose de alta al día de la fecha , dado la imposibilidad de retorno al domicilio por Causa Social , permanece en la Unidad 4 Cama 4 con aislamiento de contacto por KPC en día 42 de internación . En relación al dolor anal que manifiesta, la paciente se encuentra postrada con medidas anti escaras, colchón de aire, rotación, no presentando UPP hasta el día de la fecha, actualmente con dermatitis del pañal tratada e Interconsultada a Dermatología en tratamiento con cremas con esteroides.

Por ultimo cabe mencionar que la paciente se encuentra la mayor parte del día sin compañía de su hijo, ni aun en los horarios alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena) cumplimentando muchas veces esa tarea el personal de salud de la sala, asimismo cuando concurre siempre con conductas agresivas hacia el personal, medicando a la paciente por su cuenta y exigiendo cosas como las que manifiesta en la nota presentada.

Sin más saludo atentamente y a disposición a lo que se solicita a dicha Unidad de Internación Clínica.

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUIROS P. PIÑERO

Daniel
Kuchasky
4/3/2020

THE

OF

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

Buenos Aires, 04 de Marzo de 2020

A Dirección Hospital Piñero

Dr. Daniel Rivero

Asunto : Respuesta reclamo Paciente Kuchasky Margarita

En relación a la nota presentada por el hijo de la paciente , se informa que el mismo se presentó en forma agresiva el día 28 de Febrero en la Unidad 4 con improperios , me presento ante el preguntándole que era lo que necesitaba , respondiendo el mismo que la madre no era atendida y que solicitaba copia de la historia clínica , se le explico que la misma no podía ser entregada desde el servicio a el ya que la paciente se encontraba internada y a espera de derivación a III nivel por la Obra social Pami (NO INICIADA EL HIJO NO SE PRESENTO A FIRMAR EL PEDIDO) y que le ofrecía un resumen de la situación actual de la misma .

La paciente tiene diagnóstico de Deterioro cognitivo severo con un AVD 0/6 , postrada , antecedentes de gastritis crónica previa a la internación en tratamiento con Ranitidina (fármaco que recibía antes del ingreso) , TVP no controlada decidiéndose riego beneficio la suspensión de la misma además de no tener indicación dado el tiempo transcurrido de la misma , Ingresa al Servicio de Clínica Medica el 23/1 con Diagnostico de Neumonía de probable mecanismo espirativo , cumple tratamiento para tal fin , encontrándose de alta al día de la fecha , dado la imposibilidad de retorno al domicilio por Causa Social , permanece en la Unidad 4 Cama 4 con aislamiento de contacto por KPC en día 42 de internación . En relación al dolor anal que manifiesta, la paciente se encuentra postrada con medidas anti escaras, colchón de aire, rotación, no presentando UPP hasta el día de la fecha, actualmente con dermatitis del pañal tratada e Interconsultada a Dermatología en tratamiento con cremas con esteroides.

Por ultimo cabe mencionar que la paciente se encuentra la mayor parte del día sin compañía de su hijo, ni aun en los horarios alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena) cumplimentando muchas veces esa tarea el personal de salud de la sala, asimismo cuando concurre siempre con conductas agresivas hacia el personal, medicando a la paciente por su cuenta y exigiendo cosas como las que manifiesta en la nota presentada.

Sin más saludo atentamente y a disposición a lo que se solicita a dicha Unidad de Internación Clínica.

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86874
HOSP. GRAL. AGUIRRE P. PIÑERO



287537

23

U. A. DR. CESAR MILSTEIN

~~CONFIDENTIAL~~

APELLIDO Y NOMBRES

KUCHASKY MARGARITA

PAMI - 150143040501-00

Datos Personales

Fecha de Nacimiento: 12/05/1943

Sexo: FEMENINO

Identificación

Estado Civil: CASADO

Documento: Libreta Cívica 04214110

Contactar

Nacionalidad: ARGENTINA

Domicilio: MOZART 610

(1407) CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

Teléfonos: 46827559

e-mail:

Impresión: 21/12/2016 13:18

Recuerde que toda Historia Clínica es un DOCUMENTO y por tal motivo NO DEBE ser retirado de esta Institución. Según Ley 26529 Art.18, este Instituto tiene a cargo su guarda y custodia.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The document also outlines the responsibilities of individuals involved in the process, including the need for transparency and accountability.

In the second part, the document provides a detailed overview of the procedures for conducting audits. It describes the steps involved in planning, executing, and reporting on an audit, as well as the role of the audit committee in overseeing the process. The document also discusses the importance of maintaining the confidentiality of audit findings and the need for a fair and impartial audit process.

The third part of the document focuses on the importance of internal controls in preventing fraud and ensuring the accuracy of financial statements. It discusses the various types of internal controls, such as segregation of duties, authorization, and reconciliation, and provides guidance on how to design and implement effective internal control systems.

Finally, the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the internal control system. It emphasizes that internal controls are not a one-time exercise but rather a continuous process that requires regular review and updates to ensure their effectiveness in the face of changing circumstances.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Identificación HC N° 416191 CAMA 04 INTERNACION 27
Apellido y nombre KUCHASKY, MARGARITA LEONOR
Sexo Femenino Edad años
Obra Social PAMI Documento Tipo y Nro DNI 04214110
Fecha de nacimiento 5/12/1943 Nacionalidad Argentina
Domicilio Teléfono
Estado Civil
Día de ingreso al hospital 20/1/2020

MOTIVO DE INGRESO
DETERIORO COGNITIVO

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE DE 75 AÑOS CON ANTECEDENTES DE GASTRITIS, ANTICOAGULADA, ESQUIZOFRENICA, DETERIORO COGNITIVO CRONICO, ARTROSIS, TVP, ANTICOAGULADA EN TTO CON PANTUS, CALMADOR, SINTRON, QUETIAPINA, QUE INGRESA A GUARDIA ACOMPAÑADA POR HIJO POR PRESENTAR CUADRO CONFUSIONAL. FAMILIAR REFIERE QUE NO LA PUEDE CUIDAR. SE LE SOLICITA LABORATORIO COMPLETO, RX TORAX, TAC DE CEREBRO. FAMILIAR SE RETIRA, SIN DEJAR DATOS.

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

TRATAMIENTO:
DRA. BEUNZA, GRETTEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

IDPACIENTE: 523073/IDG: 19303 20/1/2020 02:43:07

GRETTEL A. BEUNZA
MEDICA
M. N. 113.040



CC

CC

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

28

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	20/1/2020	Cama:	3 INTERNACIO Días Int.

DIAGNOSTICO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

03:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: SE RECIBE LABORATORIO HTO 30, GB 5.22, HB 10, PLAQ 219, GL 96, UR 30, CREAT 0.81, RESTO HEMOLIZADA
SEDIMENTO URINARIO CELULAS ESCASAS CANTIDAD, LEUCO 2-3, HEMATIES 6-10
RX TORAX NO IMORESIONA INFILTRADOS PATOLOGICOS
TAC D ECEREBRO LINEA MEDIA CENTRADA, NO IMPRESIONAN IMAGENES PATOLOGICAS
SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

08:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: PACIENTE CON ANTECEDENTES DE TVP, ANTICOAGULADA, GASTRITIS CRONICA, ARTROSIS EN TTO CRONICO CON OMEPRAZOL, SINTRON, TRAMADOL, PREGABALINA QUE INGRESA A GUARDIA POR PRESENTA PREOGRESION DE SU DETERIORO COGNITIVO. FAMILAIR REFIERE QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE BUSQUEDA DE GERITRICO POR PAMI.
SE HABLA TELEFONICAMENTE CON EL FAMILIAR QUIEN APORTA DATOS.
AL EXAMEN LA PACIENTE S ENCUENTRA VIGIL, ORIENTADA EN PERSONA, DESORIENTADA EN TIEMPO Y ESPACIO, NO COLABORA, SE QUIERE IR, SE LA ENCUENTRA INQUIETA, MOTIVO POR LOQ SE LA CONTIENE. BUENA MECANICA VENTILATORIA SIN RUIDOS
AGREGADOS, ABDOMEN DEPRESIBLE INDOLORO. DIURESIS CONSERVADA POR SV.
SE SOLICITA LABORATORIO CONTROL E IC CON NEUROLOGIA
SE AGRGEA HALOPIDOL 0.5 CADA 8 HS
TELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

13:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: SE REIBE LABORATORIO HB 10.5, HTO 33.5, GB 7.8, PLAQ 198, RIN 7.96, KPTT 52, GL 101, UR 19, CRAET 0.63, TGO 25, TGP 15, FAL 91, BT 0.24, BD 0.1, NA 143, K 4.1
PACIENTE ANTICOAGULADA, FUERA DE RANGO, SIN SIGNOS DE SANGRADO, SE AGREGA VIT K
SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

IDPTE506485IDG19303 IMPRESO EL 20/1/2020 15:57:34

GRETEL A. BEUNZA
MEDICA
M. N. 113.040

ANEXO V

Consentimiento Informado para uso de documentación de medios en el marco de la Ley 2908

Efector: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"

Nombre y apellido del paciente:

KUCHASKY, MARGARITA LEONOR

Exhibe documento acreditativo de identidad **SI - NO** (tachar lo que no corresponda)

Tipo:

DNI

N°:

04214110

Ente de Cobertura de Salud al que manifiesta afiliación:

PAMI

N° de afiliado:

Acompaña fotocopia credencial **SI - NO**

Quien suscribe

en su carácter de afiliado a

PAMI

manifiesta por medio de la presente su expresa conformidad con el uso de antecedentes médicos que obraren en el Efector, estudios realizados y toda otra documentación relacionada con las prestaciones realizadas a los únicos fines de obtener el reintegro de los gastos por parte del ente de cobertura de salud que corresponda.

SI - NO (Tachar lo que no corresponda)

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FECHA:

NOTA: Si el que suscribe es representante legal completar:

Nombre y apellido del que suscribe:

Tipo de representación (madre, padre, tutor, curador, etc.):

En caso de tratarse de tutores/curadores especificar carátula del expediente judicial donde se dirimió la tutela/curatela y juzgado actuante:

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

(10)

(11)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

30

Nombre y Apellido **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** HC N° **416191**
Fecha: **20/1/2020** Cama: **1 INTERNACIO** Días Int.

DIAGNOSTICO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

03:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA

EVOLUCION: SE RECIBE LABORATORIO HTO 30, GB 5.22, HB 10, PLAQ 219, GL 96, UR 30, CREAT 0.81, RESTO HEMOLIZADA

SEDIMENTO URINARIO CELULAS ESCASAS CANTIDAD, LEUCO 2-3, HEMATIES 6-10

RX TORAX NO IMORESIONA INFILTRADOS PATOLOGICOS

TAC D ECEREBRO LINEA MEDIA CENTRADA, NO IMPRESIONAN IMAGENES PATOLOGICAS

SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

: IDPTE523073IDG19303 IMPRESO EL 20/1/2020 02:42:08

GRETEL A. BEUNZA
MEDICA
M. N. 113.040



CC

CC

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

31

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	20/1/2020	Cama:	3 INTERNACIO Días Int.

DIAGNOSTICO:
MEG + deshidratación

21:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA

EVOLUCION: Paciente de sexo femenino de 75 años de edad con antecedentes de gastritis, TVP, anticoagulada (actualmente RIN 8), esquizofrenia, deterioro cognitivo crónico, artrosis; que cursa internación por MEG + deshidratación.

Al examen físico: CSV: TA: 140/70 mmHg, FC: 95 lpm, SatO2: 95% al 0.21, afebril. Alerta, poco colaboradora, obedece órdenes simples, pupilas isocóricas y reactivas, moviliza 4 miembros, foco neurológico inevaluable. Aceptable mecánica ventilatoria, hipoventilación bibasal, escasos roncus. R1 y R2 en 4 focos, sin edemas periféricos, sin signos de falla aguda de bomba. Abdomen blando, depresible e indoloro, RHA +. Sin signos de sangrado agudo. Pequeños hematomas en miembros. Diuresis parcial por sonda vesical: 500ml en 6 hrs. Continúa control evolutivo.

SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

IDPTE506485IDG19303 IMPRESO EL 21/1/2020 12:48:23


MEDICA - U.B.A.
M.N. 144.956

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

22

23

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

32

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	21/1/2020	Cama:	3 INTERNACIO Días Int.

DIAGNOSTICO:

DETERIORO COGNITIVO CRONICO

06:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA

EVOLUCION: Paciente evoluciona clínica y hemodinámicamente estable, sin interurrencias durante la noche.

Control evolutivo.

SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

IDPTE506485IDG19303 IMPRESO EL 21/1/2020 07:07:02

Samantha A. Paganelli
MEDICA - U.B.A.
M.B. 144.956

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO
1200 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

32

32

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	21/1/2020	Cama:	3 INTERNACIO Días Int.

DIAGNOSTICO:
MEG + deshidratación

09:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: Paciente de sexo femenino de 75 años de edad con antecedentes de gastritis, TVP, anticoagulada, esquizofrenia, deterioro cognitivo crónico, artrosis; que cursa internación por MEG.
Al examen físico: CSV: TA: 110/70 mmHg, FC: 75 lpm, SatO2: 92% al 0.21, 97% con máscara reservorio, afebril. Piel y mucosas secas. Alerta, poco colaboradora, obedece órdenes simples, pupilas isocóricas y reactivas, moviliza 4 miembros, foco neurológico inevaluable. Aceptable mecánica ventilatoria, hipoventilación bibasal, roncus generalizados. R1 y R2 en 4 focos, sin edemas periféricos, sin signos de falla aguda de bomba. Abdomen blando, depresible e indoloro, RHA +. Sin signos de sangrado agudo. Pequeños hematomas en miembros. Diuresis positiva por sonda vesical.
Se solicita laboratorio con EAB. Se realiza HMC x2. Se solicita TAC de torax.
Continúa control evolutivo.
SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

12:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: Se recibe EAB:
PH: 7.42, PCO2: 39.0, PO2: 72.2, CHCO3: 25, EB: 0.7, SO2: 94.7%, Ac. Láctico: 1.75
Se realiza TAC de tórax que evidencia escaso derrame pleural bilateral.
Se decide iniciar tto ATB empírico.
SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

IDPTE50648SIDG19303 IMPRESO EL 21/1/2020 12:49:56

Samantha Paganelli
MÉDICA - U.B.A.
M.N. 144.956

Samantha Paganelli
MÉDICA - U.B.A.
M.N. 144.956

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial data.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data, including the use of statistical models and the application of modern accounting techniques.

3. The third part of the document provides a detailed analysis of the financial performance of the company over the past year, highlighting the key areas of strength and the areas that require further attention.

4. The fourth part of the document concludes with a summary of the findings and a set of recommendations for the future, emphasizing the need for continued vigilance and the importance of maintaining high standards of financial reporting.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(34)

Página 1

Identificación	HC N° 402454	UNIDAD 4	CAMA 4
Apellido y nombre	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		
Sexo Femenino	Edad 62 años	Reingreso NO	
Obra Social PAMI		Documento Tipo y Nro	DNI 4214110
Fecha de nacimiento 5/12/1943		Nacionalidad	Argentina
Domicilio MOZART 610		Teléfono	46827559
Estado Civil			
Día de ingreso al hospital		Día de ingreso al servicio	22/01/2020

MOTIVO DE INGRESO:
síndrome confusional

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP anticoagulada con sintron, deterioro cognitivo, gastritis crónica, esquizofrenia. Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica. Ingresa a guardia externa el 20/01, traída desde su domicilio acompañada por familiar por presentar un síndrome confusional hipoactivo. Familiar refiere no poder hacerse cargo del cuidado de su madre, por lo que se encuentra en búsqueda de un geriátrico por PAMI para un tercer nivel. El cual se retira de la institución sin dejar datos de contacto. A su ingreso se la constata vigil con orientación solo en persona, no se encuentra en historia clínica signos vitales al ingreso a guardia. El resto del examen físico sin particularidades. Se realiza laboratorio que informa anemia sin criterios de transfusión (hto 33.2 y hb 10.5), alteración del coagulograma con rin 7.96 y kptt 52, por lo que se indica vitamina k, con un sedimento urinario no inflamatorio, se realiza rx de tórax sin infiltrados patológicos, tac de cerebro sin signos de sangrado agudo. No cuenta con ECG. Evolución hemodinámicamente estable y afebril, con hipoventilación generalizada a la auscultación acompañado de ronus, con ritmo diurético. El 21/01 evoluciona con ronus generalizados, desaturando al aire ambiente (92%) mejorando con máscara de reservorio (97%), se realiza EAB (se desconoce Fio): 7.42/39/ 72.2/25/0.7/94%/ láctico 1.74, se indica realización de TAC de tórax donde se observa infiltrados intersticiales bilaterales. Se interpreta el cuadro como una neumonía adquirida de la comunidad, se toman HMC x2 y se inicia tratamiento empírico con AMS.

OTROS:

Hematológicos/Reumatológicos/Psiquiátricos

ALERGIAS:

se desconoce

INTERNACIONES PREVIAS:

se desconoce

QUIRUGÍAS PREVIAS:

se desconoce

ALCOHOL Tipo: se desconoce - Cantidad: - Tiempo de evolución:
DROGAS Tipo: se desconoce - Cantidad: - Tiempo de evolución:
DROGAS Tipo: se desconoce - Cantidad: - Tiempo de evolución:

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

LUGAR DE NACIMIENTO: Argentina PROFESIÓN: se desconoce ESCOLARIDAD: se desconoce VIVIENDA: se desconoce

EXAMEN FÍSICO

PRIMERA IMPRESIÓN: regular estado general ACTITUD: compuesta DECÚBITO: preferencial ESTADO DE HIDRATACIÓN: deshidratada
ESTADO DE NUTRICIÓN: normonutrida PESO: TALLA: BMI: ACCESO VENOSO: periférico SONDA VESICAL: si

SIGNOS VITALES:

TA: 120-70 FC: 82 FR: 18 TC: 36.7 SAT: 92% (0.21) 98 %(cn) ORTATISMO: DIURESIS: conservada por sonda vesical PVC:

Página 2

SENSORIO:

vigil, orientada en persona, desorientada en tiempo y espacio

PIEL Y FANERAS:

COLOR: caucasica LESIONES CUTÁNEAS: cicatriz mediana en abdomen VELLO: lampiña ESCARAS: No

SISTEMA VENOSO:

TRAYECTOS VARICOSOS: No HOMANS: No

Unidad 4

KUCHASKY, MARGARITA LEONOR C

CABEZA:

TIPO: Normocéfalo CAVIDAD ORAL: mucosas secas DIENTES: Regular estado de conservación, uso de prótesis dentaria

CUELLO:

FORMA: Cilíndrico SIMETRÍA: No TIROIDES: No se palpa

SISTEMA CARDIOVASCULAR

INSPECCIÓN/PERFUSIÓN: Bien perfundida, dos ruidos en cuatro focos, silencios impresionantes libres, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decúbito y sin signos de falla aguda de bomba

PALPACIÓN:

PERCUSIÓN:

AUSCULTACIÓN:

SOPLOS:

AUSCULTACIÓN DE CARÓTIDAS:

CARACTERÍSTICAS DEL RADIAL:

PULSOS PERIFÉRICOS

BRAQUIAL DE BRAQUIAL IZ

RADIAL DE RADIAL IZ

FEMORAL DE FEMORAL IZ

POPLÍTEO DE POPLÍTEO IZ

TIBIAL POST DE TIBIAL POST IZ

PEDIO DE PEDIO IZ

MANEJO DE LÍQUIDOS: TOLERA DECÚBITO: YUGULARES: EDEMAS PERIFÉRICOS:

APARATO RESPIRATORIO

INSPECCIÓN: Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación generalizada por falta de colaboración de la paciente acompañada de escasos crepitantes bibasales y ruidos altos.

PALPACIÓN: EXPANSIÓN DE VÉRTICES: VIBRACIONES VOCALES:

PERCUSIÓN: TORAX: COLUMNA:

AUSCULTACIÓN: MURMULLO VESICULAR: RUIDOS AGREGADOS: PECTORILOQUIA:

MAMAS:

ABDOMEN

CATARSIS/RITMO EVACUATORIO:

FORMA: SIMETRÍA: CICATRICES: HERNIAS: CIRCULACIÓN COLATERAL:

PALPACIÓN: SUPERFICIAL: PROFUNDA: HÍGADO: Abdomen globoso, blando, depresible, indoloro a la palpación superficial y profunda, sin defensa ni reacción peritoneal, RHA conservados, catarsis positiva del día de la fecha BAZO

PERCUSIÓN: TRAUBE: ONDA ASCÍTICA: MATIDEZ DESPLAZABLE:

AUSCULTACIÓN DE RHA: TACTO RECTAL:

APARATO GENITOURINARIO

GENITO RENAL: No se palpan PUÑO PERCUSIÓN LUMBAR: Negativo PUNTOS URETRALES: Negativos GENITALES: Normales

SISTEMA LINFOGANGLIONAR

CERVICAL DERECHO: No CERVICAL IZQUIERDO: No

SUPRACLAVICULAR DERECHO: No SUPRACLAVICULAR IZQUIERDO: No

INFRACLAVICULAR DERECHO: No INFRACLAVICULAR IZQUIERDO: No

AXILAR DERECHO: No AXILAR IZQUIERDO: No

EPITOCLEAR DERECHO: No EPITOCLEAR IZQUIERDO: No

INGUINAL DERECHO: No INGUINAL IZQUIERDO: No

SISTEMA NERVIOSO

GLASGOW APERTURA OCULAR: Espontánea(4) RESPUESTA VERBAL: Orientado(5) RESPUESTA MOTORA: Orientado(5) PUNTAJE: 15/15

RESPUESTA A COMANDOS: Sí a los 3 comandos LENGUAJE: Conservado y coherente SISTEMA MOTOR: S/p SIGNOS MENÍNGEOS: No

MARCHA: Conservada PUPILAS: Normoiscóricas reactivas MOTILIDAD OCULAR: Extrínseca e intrínseca SENSIBILIDAD: Conservada

REFLEJOS: Conservado OTROS SIGNOS NEUROLÓGICOS: vigil, pupilas isocóricas reactivas, moviliza los cuatro miembros, sin signos de foco motor agudo ni meníngeo

SISTEMA OSTEOARTICULOMUSCULAR

MOTILIDAD: Conservada EXTREMIDADES: S/p COLUMNA: Normal ARTICULACIONES: S/p FUERZA Y TONO MUSCULAR: S/p TROFISMO: S/p

ESTUDIOS REALIZADOS

RX DE TORAX:

No rotulada.

De frente, incompleta, rotada, descentrada, índice cardiotorácico conservado con botón aórtico prominente, senos costal y cardiorrenales derechos e izquierdo velados, a nivel del parénquima pulmonar presenta infiltrado en base izquierda

OTROS ESTUDIOS:

TAC DE CEREBRO: de corte axial con integridad ósea, línea media centrada, glándula pineal y plexos coroideos clacificados, sin ventriculomegalia, sin signos de sangrado actico

TAC DE TORAX: presenta infartados intersticiales bilaterales

ECG:

Ritmo: regular sinusal Frecuencia: 80 Eje: +30 P: 0.08 PR: 0.12 QRS: 0.12 ST: isonivelado T: sin particularidades Q: QT: QTc: Extrasístoles: no Progresión: regular Conclusiones: ecg sin valor patológico

LABORATORIO:

Hto= 28.6 Hb= 9 GB= 8380 Plaquetas= 160.800 RIN= 1.51 KPTT= 30 Glucemia= 103 Urea= 18 Creatinina= 0.50 TGO= 23 TGP= 15 Fosfatasa alcalina= 73 Bilirrubina total= 0.41 Bilirrubina directa= 0.17 Na Sérico= 141 K Sérico= 3.8 Otros= cloro 104/ lactico 1.41 EAB: Ph = 7.39 PCO2= 41.2 PO2= 77 HCO3= 24.5 EB= -0.4 Sao2= 96

INTERPRETACION DIAGNÓSTICA:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

INDICACIONES:

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR SONTA VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°
- 5) CABECERA A 45°
- 6) OMEPRAZOL DE 20 MG CÀPSULA CADA 24 HORAS VÍA ORAL (8 HS)
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRÉ DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
- 9) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL
- 10) NEBULIZACION CADA 8 HORAS CON 3 CC DE SOLUCION FISIOLÓGICA MAS 20 GOTAS DEL SALBUTAMOL Y 40 GOTAS DE BROMURO DE IPATROPIO
- 11) AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 2
- 12) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

EVOLUCIÓN POR GUARDIA:

KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Ca 4 a Unidad 4

ágina 4

LEONOR Cama 4 de la Unidad 4

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

(X)

(X)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

36

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	23/01/2020	Cama:	4
		Días Int.	1

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

23/1/2020:

dia 1 de internacion en Clinica Medica

Dia 2 de ATB: AMS por NAC de probable mecanismo aspirativo

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015)

TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 130/70 mmHg, FC 71 FR 20 T° 36.5 SAT 99 (con canuma nasal) Diuresis 300 ml en 3 hs.

N: Vigil, atenta, orientada en persona, desorientada en tiempo y espacio, responde ordenes simples, moviliza 4 miembros en cama, sin foco motor ni meningeo.

A: Globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.

C: 2r en 4 focos, SS 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas ni otro signo de falla cardiaca.

R: Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, escasos crepitantes a predominio basal. Torax y columna sonoras.

OA: Pie en valgo con deformidad de tarso, onicomiosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.

COMENTARIOS:

1. Paciente que cursa internacion en clinica medica por NAC en contexto de síndrome demencial con elevado riesgo social.

2. Se realiza entrevista con hijo (Nicolas Horacio) quien aporta datos de antecedentes previos de la paciente y refiere que no cuenta con los recursos para el cuidado de su madre. Por lo antes descripto, se solicita Interconsulta con Servicio Social (PAMI) a fin de realizar tramites de derivacion a tercer nivel una vez resuelto el motivo clinico de internacion.

3. PLAN DE ESTUDIO:

* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo.

* TAC Torax (realizada, pendiente informe)

* Ecocardiograma

* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)

* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)

* Completar esquema antibiotico

* Seguimiento de cultivos (HMC X2, realizados por guardia el dia 20/1/2020)

DRA. SANDRA KRAUS MEDICA PLANTA C.MEDICA MN 110169

IDPTE506485IDCM7135IDCMED110654 IMPRESO EL 23/1/2020 11:50:21

Sandra Kraus
 Medica (U.S.A.)
 Especialista en Geriatria
 M.N. 110.169

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

37

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	24/1/2020	Cama:	4
		Días Int.	2

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION EN SALA DE CLINICA MEDICA: 2

DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01

*PTZ: 0

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

TVI: ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 120-70/ 83/20/37.6/ 95% (CN)

Diuresis 200 ml en 6 hs

N: Somnolenta, responde al llamado con apertura ocular, no impresiona foco motor ni meningeo.

C: regular perfusion por ritmo diuretico disminuido, 2r en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

R: Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, escasos crepitantes a predominio basal. Torax y columna

C: reforas.

abdomen: Globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.

OA: Pie en valgo con deformidad de tarso, onicomycosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y febril que cursa internacion en clinica medica por NAC en conetexto de síndrome demencial con elevado riesgo social.

*se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 23/01/2020

Hto= coagulada Hemo= coagulado Bcos= coagulado Pla= coagulado KPTT= 24 RIN= 1.15 Fibrin= 637 Gluc= 87 Urea= 14 Creat= 0.52 Colest= 153 LDH= 60 HDL= 66 Prot= 5.2 Albu= 2.9 Bili= 0.42 Bili.Di= 0.20 Bili.In= 0.22 F.Alca= 73 TGO= 20 TGP= 16 Calc= 8 Fosfat= 2.2 Magne= 1.86 Otros= Na= 146 Ka= 3.4 Cloro= 108 HbsAg= nr HCV= nr Chagas= nr VDRL= nr Toxo= nr VIH= nr T4= 1.20 TSH= 3.14 Observaciones= pcr: 148/ ferremia 40/ transferrina 157/ % transferrina 157/ vit b12: 465.10/ folico: 16.58

*Por presentar deterioro del sensorio se realiza HMG 138 y fiamazenil positivo registro subfebril, ritmo diuretico disminuido se inicia expansion con cristaloides con una respuesta de 500 ml 1 h con una diuresis parcial 700 ml en 8 hs con balance positivo, se decide realizar HMCx2, tomar urocultivo con recambio de sonda vesical y escalar esquema antibiotico con PTZ ajustado a funcion renal.

*Se repite laboratorio con EAB: LABORATORIO DEL DÍA: 24/01/2020

Hto= 24.5 Hemo= 8.2 Bcos= 6170 Pla= 76.300 Otros= Ph= 7.37 PCO2= 43 HCO3= 24.7 BE= -0.5 Observaciones= lactico 0.93

*Se deja laboratorio de central

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Continua control evolutivo por clinica medica

Maria Celeste Gramajo
MARIA CELESTE GRAMAJO
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(41)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC N°	402454
Fecha:	30/1/2020	Cama:	4	Días Int.	8

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

30/1/2020:

DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 3

DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (27/01): 4

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 140-80/ FC 78/FR 18/ T 36.6/ SAT 96% (0.21)

Diuresis 500 ml en 5 hs con balance positivo 200 ML

PVC= 5 cm

n:N:Atenta. Vigil con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

C: Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos. Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

R: Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.

Piel y ptes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.

Acceso venoso central, sin signos de flogosis

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por NAC de probable mecanismo aspirativo en contexto de síndrome demencial con elevado riesgo social, en tratamiento con PTZ (en día 3).

*Sin familiar presente al momento del parte medico

*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)

* TAC Torax (21/01) (realizada, pendiente informe)

*TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)

* Ecocardiograma (03/02)

* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)

* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)

SEGUIMIENTO DE CULTIVOS

HMC X2 (20/01): negativo a la fecha

HMC (24/01): negativo a la fecha

UC (24/01): fpm

DRA. SANDRA KRAUS MEDICA PLANTA C.MEDICA MN 110169

IDPTE506485IDCM7135IDCMED110964 IMPRESO EL 30/1/2020 12:46:42


Sandra Kraus
C.MEDICA MN 110169

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

42

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	31/1/2020	Cama:	4
		Días Int.	9

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 9
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 4
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (27/01): 4

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
 *VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
 ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
 ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patología psiquiátrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
 ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
 ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).
 *ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
 *SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.
 *ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
 CSV: TA: 120-70/ FC 83/FR 18/ T 37.3/ SAT 97% (0.21)
 Diuresis 400 ml en 3 hs con balance neutro
 PVC= 5 cm

n:N:Atenta. Vigil con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 C: Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin ruidos, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 A: Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.
 Piel y ptes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.
 Acceso venoso central, sin signos de flogosis

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por NAC de probable mecanismo aspirativo en contexto de síndrome demencial con elevado riesgo social, en tratamiento con PTZ (en día 4).
 *Por presentar registros subfebriles en forma aislada sin foco aparente con un urocultivo con FPM, se indica recambio de sonda con toma de urocultivo
 *Se espera resultado de laboratorio de central
 *Con familiar presente al momento del parte medico
 *Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
 *Laboratorio completo con urea, creatinina, VPH, perfil lipidico, Perfil tiroideo, hemograma

[Firma]
María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

43

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	03/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	12

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 12
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 0, por rescate en urocultivo de EVR
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (27/01): 6, se la autoretira el 01/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
 ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo rativo con elevado riesgo social, falta de red de contencion y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 120-70/ FC 80/FR 18/ T 37/ SAT 97% (0.21)
 Diuresis 200 ml en 3 hs con balance 200 positivo

Vigil, atenta con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.

Piel y ptes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre

COMENTARIOS:

Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por NAC de probable mecanismo rativo en contexto de síndrome demencial con elevado riesgo social, en tratamiento con PTZ (en día 7) ya finalizado.

En el día de la fecha, por continuar subfebril con tratamiento suboptimo por perdida de accesos y con rescate de urocultivo de EVR ingresado el día viernes 29/01, inicia tratamiento con linezolid (día 0), se ingresan HMC x2.

*Se solicita colocacion de acceso venoso central por parte de servicio de cirugía, se firma consentimiento informado y se adjunta en ultimo laboratorio y orden de placa de rx torax control.

*Se espera resultado de laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 31/01/2020

Hto= 26.6 Hemo= 8.5 Bcos= 6110 Pla= 341.000 KPTT= 25 RIN= 1.26 Fibrin= 717 Gluc= 99 Urea= 7 Creat= 0.41 Colest= 168 Prot= 5 Albu= 2.8 Bili= 0.36 Bili.Di= 0.21 Bili.In= 0.15 F.Alca= 85 TGO= 29 TGP= 32 Calc= 8 Fosfat= 2.3 Magne= 1.49 Otros= Na= 142 Ka= 3.1 Cloro= 103 Eritro= 86 Observaciones= PCR: 154

*Se recibe informe de TAC de torax: NO SE OBSERVAN ADENOMEGALIAS AXIALES. HILIARES NI MEDIASTINALES. MEDIASTINO-CENTRADO. DE CONFIGURACION VASCULAR HABITUAL. AREA CARDIACA CONSERVADA. NO SE OBSERVA DERRAME PERICARDICO. VOLUMINOS HERNIA HIATAL. ESCASO DERRAME PLEURAL IZQUIERDO LAMINAR. LOS CORTES CON VENTANA DE PULMON MUESTRAN OPACIDADES SUBPLEURALES Y ACENTUACION DE LA TRAMA INTERSTICIAL A NIVEL DE LOS SEGMENTOS POSTERIORES DE AMBOS LOBULOS INFERIORES. DE PROBABLE ORIGEN PASIVO CONGESTIVO. ABDOMEN SUPERIOR SIN PARTICULARIDADES

*Sinn familiar presente al momento del parte medico

*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

- * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
- * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)
- * TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)
- * Ecocardiograma (pendiente turno)
- * Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)
- * Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)

Maria Celeste Gramajo
MARIA CELESTE GRAMAJO
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(44)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	04/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	13

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 13

DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01

*PTZ: 7

*Linezolid: 1, por rescate en urocultivo de EVR

DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 1

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) y P(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia

clínica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 130-70/ FC 79/FR 18/ T 36/ SAT 95% (0.21)

Diuresis: 300 ml en 4 horas con balance positivo 100

Catarsis positiva del día de la fecha

PVC= 5

Consciente, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin

reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.

Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy día 1), con HMC negativos a la fecha

*Se coloca acceso venoso central (yugular posterior izquierdo) en quirófano por parte del servicio de cirugía. Se realiza en clinica medica, rx de torax control sin presencia de neumotorax.

*Sin familiar presente al momento del parte medico

*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

Maria Celeste Gramajo
MARIA CELESTE GRAMAJO
MÉDICA
M.N. 161508

1000

10

10

10

1000

1000

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

15

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	05/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	14

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DÍAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 14

DÍAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01

*PTZ: 7

*Linezolid: 2, por rescate en urocultivo de EVR

DÍAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 2

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) (2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FÍSICO:

CSV: TA: 120-70/ FC 70/FR 17/ T 35.7/ SAT 95% (0.21)

Diuresis: 200 ml en 3 horas con balance positivo 200

Catarsis positiva del día de la fecha

PVC= 4

paciente, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Pulso en perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello; sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy día 2), con HMC negativos a la fecha

*Sin familiar presente al momento del parte medico

*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:


 Maria Celeste Gramajo
 MÉDICA
 M.N. 161508

2

2

2

INTERCONSULTA

46

PACIENTE KUCHASKY, MARGARITA LEONOR

HC N°

402454

FECHA 06/02/2020

SERVICIO QUE SOLICITA UNIDAD 4 DE CLINICA MEDICA

SERVICIO QUE REALIZA Unidad de Geriatria (Cantale, Vicente, El Hage)

INTERCONSULTA

A pedido de medico tratante se evalua a la pte, quien se encuentra cursando internacion por NAC con multiples interurrencias infectologicas. Quien dado los antecedentes personales, situacion social y estado actual se considera la institucionalizacioon posterior al alta en residencia de larga estancia, solicitando dicha prestacion a PAMI.

Segun la valoracion geriatria integral se concluye en que se trata de un "Anciano Geriatrico", con Trastorno neurocognitivo mayor, con compromiso de todos los dominios cognitivos, mas dependencia total para las ABVD e Inst. Riesgo social elevado. Multiples sindromes geriaticos: Icompetencia intelectual, Inmovilidad, Incontinencia, malnutricion.

Se consensua con medico tratante en continuar con el pedido de tercer nivel a PAMI

Claudio El Hage
Médico UNLP
MN 126.905

DRA. VICENTE MASANES FRANCISCA
MÉDICA
MN 124347



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

47

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	6/2/2020	Cama:	4
		Días Int.	15

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 15

DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01

*PTZ: 7

*Linezolid: 3, por rescate en urocultivo de EVR

DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 3

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) *P(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia nica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 130-70/ FC 83/FR 17/ T 36.7/ SAT 95% (0.21)

Diuresis: 300 ml en 34 horas con balance positivo 200

Catarsis positiva del día de la fecha

PVC= 6

gil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. profunda, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin

reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy día 3), con HMC negativos a la fecha.

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)

* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

* TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)

* Ecocardiograma (pendiente turno)

* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)

* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)

* PPD (pendiente)

SEGUIMIENTO DE CULTIVOS


Maria Celeste Gramajo
 MÉDICA
 M.N. 161508

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME

BY
JOSEPH NEALE

NEW YORK: 1845.



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME
BY
JOSEPH NEALE

NEW YORK:
PUBLISHED BY
JOSEPH NEALE
1845.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

43

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		HC Nº	402454
Fecha:	07/02/2020	Cama:	4	Días Int: 16

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 16
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 6, por rescate en urocultivo de EVR
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 4

ANTECEDENTES PERSONALES:
 Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
 *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucionan con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
 *VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
 *SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA,
INFECCIONES:
 *ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
 CV: TA: 130-70/ FC 80/FR 17/ T 36.5/ SAT 96% (0.21)
 Diuresis: 400 ml en 4 horas con balance positivo 100
 Catarsis positiva del día de la fecha

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida. 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy día 4), con HMC negativos a la fecha.
 *Se solicita laboratorio de central
 *Pendiente programacion de turno para ecocardiograma.
 *Sin familiar presente al momento del parte medico
 *Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
 * Laboratorio completo con serologías, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
 * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

Maria Celeste Gramajo
Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

48

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	10/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	19

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DÍAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 19
 DÍAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR (hoy ultimo día de tratamiento)
 DÍAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 7

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

Interocurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucionan con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde rescata EVR sensible a linezolid.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 110-80/ FC 70/FR 17/ T 35.7/ SAT 96% (0.21)

Diuresis: 300 ml en 4 horas con balance positivo 100

arsis negativa de 24 hs

...gil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, Y 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:

- * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy día 7), con HMC negativos a la fecha, siendo hoy ultimo día de tratamiento.
- *Se espera resultado de laboratorio.
- *Sin familiar presente al momento del parte medico
- *Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

- * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
- * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

Maria Celeste Gramajo
MARIA CELESTE GRAMAJO
 MÉDICA
 M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

50

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	11/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	20

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 20
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 8

ANTECEDENTES PERSONALES:
 Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

TERCURRENCIAS:
 tuerce registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con tpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid.

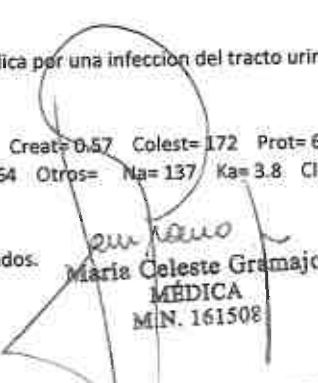
Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
 *VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
 ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
 ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
 ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
 ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).
 *ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
 *SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
 *ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
 T: 36.4/ FC 81/FR 17/ T 36.4/ SAT 96% (0.21)
 Diuresis: 400 ml en 4 horas con balance positivo 200
 Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid finalizado.
 *Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DIA: 10/02/2020
 Hto= 32.3 Hemo= 10.3 Bcos= 4450 Plaq= 213.000 KPTT= 31 RIN= 1.14 Fibrin= 441 Gluc= 157 Urea= 8 Creat= 0.57 Colest= 172 Prot= 6 Albu= 3.3 Bili= 0.31 Bil.DI= 0.16 Bil.In= 0.15 F.Alca= 84 TGO= 15 TGP= 22 Calc= 8.8 Fosfat= 2.7 Magne= 1.64 Otros= Na= 137 Ka= 3.8 Cloro= 102
 *Sin familiar presente al momento del parte medico
 *Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
 * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
 * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)


 Maria Celeste Gramajo
 MÉDICA
 M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

51

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	12/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	21

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 21
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 9, se retira el 12/02

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurrir registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucionar con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 120-60/ FC 74/FR 17/ T 35.8/ SAT 97% (0.21)
 Diuresis: 300 ml en 4 horas con balance positivo 200
 Catarsis negativa de 24 hs

atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, Y 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomiosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:

- * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid finalizado.
- *Se retira acceso venoso central (yugular posterior derecha), se indica continuar plan de hidratacion por via subcutanea.
- *Sin familiar presente al momento del parte medico
- *Continúa control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

- * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
- * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

Maria Celeste Gramajo
MARIA CELESTE GRAMAJO
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

52

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	13/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	22

DIAGNÓSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCIÓN:

DÍAS DE INTERNACION DE CLÍNICA MÉDICA: 22
 DÍAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DÍAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciono con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLÍNICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patología psiquiátrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FÍSICO:

CSV: TA: 110-60/ FC 74/FR 17/ T 35.8/ SAT 97% (0.21)
 Diuresis: 200 ml en 4 horas
 Catarsis negativa de 24 hs

, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Tórax: bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, Y 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:

- * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
- *Se hace entrega informe medico por parte del servicio de Geriatria a PAMI.
- *Sin familiar presente al momento del parte medico.
- *Se actualizan indicaciones medicas.
- *Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:

- * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)


María Celeste Gramajo
 MÉDICA
 M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

53

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	14/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	23

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 23
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
 Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
 Interocurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y cultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
 *VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).
 *ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
 *SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
 *ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
 CSV: TA: 120-60/ FC 75/FR 17/ T 35.9/ SAT 97% (0.21)
 esis conservada por sonda vesical
 arsis negativa de 24 hs

vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, Y 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomiosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.
 Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
 *Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal de piernas y en axila derecha , se aplica crema con corticoides y acido fusidico, mejorando cuadro.
 *Se solicita laboratorio de central.
 *Sin familiar presente al momento del parte medico.
 *Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
 * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
 * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)
 *TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)

Maria Celeste Gramajo
Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

22

23

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

54

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	17/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	26

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 26
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiótico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
 ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
 ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagiilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

TA: 130-60/ FC 81/FR 16/ T 36.3/ SAT 95% (0.21)
 Oliguria conservada
 Catarsis negativa de 24 hs

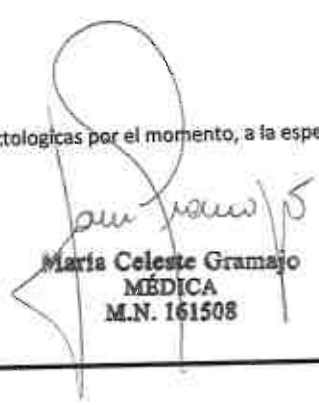
Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomiosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.
 Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:

- * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
- *Se espera resultado de laboratorio de central.
- *Sin familiar presente al momento del parte medico.
- *Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:

- * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
- * TAC Tercer (21/01) (realizada con informe adjunto)


Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1

2

3

4

5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

55

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	18/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	27

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DÍAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 27
 DÍAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DÍAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se reutiliza HMC y urocultivo donde escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

....errogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 120-70/ FC 83/FR 16/ T 36/ SAT 96% (0.21)
 Diuresis conservada
 Catarsis negativa de 24 hs

atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 profunda, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, Y 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
 Acceso venoso central sin signos de flogosis.
 Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se recibe laboratorio de central:

LABORATORIO DEL DÍA: 17/02/2020

Hto= 29 Hemo= 9.2 Bcos= 5570 Pla= 200.000 KPTT= 27 RIN= 1.17 Fibrin= 365 Gluc= 97 Urea= 21 Creat= 0.63 Colest= 161 Prot= 5.8 Albu= 3.3 Bili= 0.31 Bili.Di= 0.16 Bili.In= 0.15 F.Alca= 78 TGO= 18 TGP= 25 Calc= 8.7 Fosfat= 3.3 Magne= 1.83 Otros= Na= 146 Ka= 4.1 Cloro= 109 Eritro= 29 Observaciones= pcr 17

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:

- * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
- * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

Maria Celeste Gramajo
MARIA CELESTE GRAMAJO
 MÉDICA

M.N. 161508

2000

2000

2000

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

T6

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	19/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	28

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 28
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
 Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
 terurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion a cultivos negativos y cultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
 *VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contencion y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).
 *ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
 *SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.
 *ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
 V: TA: 120-70/ FC 92/FR 16/ T 36/ SAT 9% (0.21)
 esis consevada
 letarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
 *Sin familiar presente al momento del parte medico.
 *Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
 * Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
 * TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

Maria Celeste Gramajo
Maria Celeste Gramajo
 MÉDICA
 M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

57

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	20/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	29

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 29
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

Interocurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucionan con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
 ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

T: TA: 130-70/ FC 82/FR 16/ T 35.6/ SAT 97% (0.21)

Diuresis conservada por sonda vesical
 Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con leve mejoría
 Presenta conjuntivitis en ojo izquierdo con enrojecimiento y secrecion.

COMENTARIOS:

- * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
- *Presenta secrecion, enrojecimiento, prurito en ojo izquierdo, se realiza interconsulta con oftalmologia quienes refieren evaluar en sala por imposibilidad de colaboracion de paciente en contexto de su enfermedad de base, a si mismo se inicia tratamiento con gotas oftalmicas.
- *Por continuar con dermatitis de contacto, se deja indicado crema con corticoides.
- *Sin familiar presente al momento del parte medico.
- *Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED111796 IMPRESO EL 20/02/2020 14:10:15

Maria Celeste Gran
MARIA CELESTE GRAN
 MÉDICA
 M.N. 16150F

11

12

13

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

58

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		HC Nº	402454
Fecha:	21/2/2020	Cama:	4	Días Int. 30

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 30
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiótico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciono con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo de se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLÍNICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA.

INFECCIONES:

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 120-60/ FC 81/FR 16/ T 35.6/ SAT 97% (0.21)

Diuresis conservada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
 Buen perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con leve mejoría

Presenta conjuntivitis en ojo izquierdo con enrojecimiento y secrecion, en mejoría

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*se solicita laboratorio de central

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTE50648SIDCM713SIDCMED111837 IMPRESO EL 21/2/2020 11:37:17


Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

59

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	26/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	35

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 35
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

Interocurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucionan con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recruta HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

***VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO**

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
 ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

TA: 100-80/ FC 76/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)

Uriuresis consevada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se re solicita pedido de laboratorio por central.

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTE506485IDCM713IDCMED111901 IMPRESO EL 26/02/2020 13:10:01


Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

100
100
100

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

60

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	27/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	36

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, URGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FÍSICO:

CSV: TA: 100-80/ FC 76/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)

Diuresis consevada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se re solicita pedido de laboratorio por central.

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Continua control evolutivo por clinica medica.

DR. SEBASTIAN GERVASONI CLINICA MEDICA MN 152.092

SEBASTIAN GERVASONI
 ESP. MEDICINA INTERNA
 Mat. Nº152092

C.C.

C.C.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

61

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	28/02/2020	Cama:	4
		Días Int.	39

DIAGNÓSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCIÓN:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 37
 DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
 *PTZ: 7
 *Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
 DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

RECURRENCIAS:

Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol; Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para úlcers por presión

*SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FÍSICO:

TA: 110-70/ FC 78/FR 16/ T 36/ SAT 98% (0.21)

esís conservada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

vigil, atenta, reactiva con orientación en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/5 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoría.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se recibe laboratorio de central; LABORATORIO DEL DÍA: 27/02/2020

Hto= 32.4 Hemo= 10.1 Bcos= 5130 Pla= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 86 Urea= 27 Creat= 0.69 Otros= Na= 137 Ka= 4.6 Cloro= 101 Eritro= 49

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodicepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender

*Continúa control evolutivo por clinica medica.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112000 IMPRESO EL 01/03/2020 7:44:18

Maria Celeste
Maria Celeste (Firma)
 MÉDICA
 M.N. 15.411

(11)

(12)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(62)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	02/03/2020	Cama:	4
		Días Int.	40

DIAGNOSTICO:

NAC, DEMENCIA, KPC

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 40

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con ultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patología psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

CIANICA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 110-70/ FC 78/FR 16/ T 36/ SAT 98% (0.21)

Diuresis consevada por sonda vesical

Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
 Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 27/02/2020

Hto= 32.4 Hemo= 10.1 Bcos= 5130 Pla= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 86 Urea= 27 Creat= 0.69 Otros= Na= 137 Ka= 4.6 Cloro= 101 Eritro= 49

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodicepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender

*Continua control evolutivo por clinica medica.

[Firma]
 JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

63

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	03/03/2020	Cama:	4
		Días Int.	41

DIAGNOSTICO:

demencia , causa social

EVOLUCION:

03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 41

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 110-70/ FC 78/FR 16/ T 36/ SAT 98% (0.21)

Diuresis consevada por sonda vesical

Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin ruidos, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Respiracion mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoría.

Refiere dolor anal , al examen clinico sin particularidades

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020

Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Pla= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender

*Continua control evolutivo por clinica medica.

HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC , CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO

Dr. COPANI JORGE MARCELO
 MEDICO CLINICO - GERIATRIA

DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112115 IMPRESO EL 03/03/2020 10:06:44

✓

✓

✓

✓

✓

5/3/2020 Dermatología Kichay Margarita (64)
Paciente que cursa infección con lesiones
de demencia, prurito deméxico del páncreas
a menudo exantemático y otros
Análisis clínico o exantemático 2/día tener 4
2 días y Análisis clínico 2/día
Sugerir un poco de dolor.

PAULA L. NIETO
DERMATÓLOGA
M.P. 123.516 M.P. 335.787

55

56

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(6)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	04/03/2020	Cama:	4
		Días Int.	42

DIAGNOSTICO:
demencia

EVOLUCION:
03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 42

ANTECEDENTES PERSONALES:
 Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

INGRESO EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLÍNICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patología psiquiátrica (según consta en historia clínica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contención familiar. El hijo refiere que no está capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internación en Servicio de clínica médica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contención y la situación clínica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para úlcera por presión

*SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICIÓN, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y pérdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FÍSICO:
 CSV: TA: 110-70/ FC 82/FR 15/ T 36/ SAT 96% (0.21)
 Riñones conservados por sonda vesical
 artrosis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientación en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo crónico, reactiva, sin foco motor ni meníngeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin flujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecánica respiratoria, hiperventilación global por falta de colaboración, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha en tratamiento con buena evolución continua con igual tratamiento, interconsulta con dermatología

Refiere dolor anal, al examen clínico sin particularidades

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinámicamente estable y afebril, sin intercorrientes infectológicas por el momento, a la espera derivación a un tercer nivel por PAMI.
 *Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020
 Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Pla= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59
 *Sin familiar presente al momento del parte médico.
 *Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodicepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta.
 *Continua control evolutivo por clínica médica, a espera de derivación a tercer nivel.
 HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC, CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO

04/03/2020: Paciente de 75 años
 DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112156 IMPRESO EL 04/03/2020 9:36:44

DR. COPANI JORGE MARCELO
 JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
 M.N. 86674
 HOSP. GRAL. AGUDOS PARMENIO PIÑERO

—

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

66

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		HC Nº	402454
Fecha:	05/03/2020	Cama:	4	Días Int. 43

DIAGNOSTICO:
demencia

EVOLUCION:
03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 43

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 110-70/ FC 82/FR 15/ T 36/ SAT 96% (0.21)

Diuresis conservada por sonda vesical

Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin flujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Respiratoria: buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha en tratamiento con buena evolucion continua con igual tratamiento, interconsulta con dermatologia

Refiere dolor anal, al examen clinico local, dermatitis del pañal que se encuentra en tratamiento y a espera de Interconsulta con dermatologia

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020

Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Pla= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta.

*Continua control evolutivo por clinica medica, a espera de derivacion a tercer nivel. Se ajusta tratamiento por periodos de excitacion.

HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC, CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO

05/03/2020: Paciente de 76 años

DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112212 IMPRESO EL 05/03/2020 9:34:12

*Dr. COPANI JONES MARCELO
MEDICO CLINICO GERIATRIA
M.H. 86.674*

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

67

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	06/03/2020	Cama:	4
		Días Int.	44

DIAGNOSTICO:
 DEMENCIA

EVOLUCION:
 06/03/2020: 03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA: 43

ANTECEDENTES PERSONALES:
 Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
 Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
 *VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala mton Brody: cero)

ESFERA CLÍNICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SÍNDROMES GERIÁTRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.

*ANCIANA GERIÁTRICA con SÍNDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FÍSICO:
 CSV: TA: 110-70/ FC 82/FR 15/ T 36/ SAT 96% (0.21)
 Diuresis consevada por sonda vesical
 Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin flujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha en tratamiento con buena evoucion continua con igual tratamiento , interconsulta con dermatologia

Refiere dolor anal , al examen clinico local , dermatitis del pañal que se encuentra en tratamiento y a espera de interconsulta con dermatologia

COMENTARIOS:
 * Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
 *Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020
 Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 PlaQ= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59
 *Sin familiar presente al momento del parte medico.
 *Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta.
 *Continua control evolutivo por clinica medica , a espera de derivacion a tercer nivel . Se ajusta tratamiento por periodos de excitacion .
 HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC , CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO , A ESPERA DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA DERIVACION A III NIVEL PAMI
 DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM713SIDCMED112265 IMPRESO EL 06/03/2020 8:41:08

DR. COPANI JORGE MARCELO
 JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
 M.N. 86674
 HOSP. GRAL AGUDOS P. PIÑERO

11

12

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

68

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	09/03/2020	Cama:	4
		Días Int.	47

DIAGNOSTICO:

Neumonía de la comunidad

EVOLUCION:

09/03/2020: Paciente de 76 años ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 110-70/ FC 80/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)

Diuresis conservada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoría.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodicepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender.

Control evolutivo.

DR. GASTON NASTRI CLINICA MEDICA MN:100101

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112350 IMPRESO EL 09/03/2020 12:30:24 p.m.

GABRIELA PACE
MEDICINA INTERNA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

1445: Se presenta el hijo de la paciente agitada, no comprende lo que se le explica, "quiere" la Historia Clínica, se le explica que es un documento confidencial y se le entrega.

200

200

200

200

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA



Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	10/3/2020	Cama:	4
		Días Int.	48

DIAGNOSTICO:
demencia

EVOLUCION:

10/3/2020: 09/03/2020: ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.

¿GI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO

ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)

ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)

ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio) con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma. Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Síndrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.

ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por síndrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fragilidad Barthel: 5 (dependencia total).

*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión

*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA, INFECCIONES.

*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

MEN FISICO:

TA: 110-70/ FC 80/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)

uresis consevada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoría.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender. Conducta agresiva con el personal de salud

Control evolutivo. A espera de inicio de expediente de III nivel, se informa a servicio social.

DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112375 IMPRESO EL 10/3/2020 09:23:47

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

70

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	11/03/2020	Cama:	4
		Días Int.	49

DIAGNOSTICO:
DEMENCIA

EVOLUCION:

11/03/2020: ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

EXAMEN FISICO:

CSV: TA: 110-70/ FC 80/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)

Diuresis consevada por sonda vesical

Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo. Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoría.

COMENTARIOS:

* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin interurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.

*Sin familiar presente al momento del parte medico.

*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender. Conducta agresiva con el personal de salud

Control evolutivo. A espera de inicio de expediente de III nivel, se informa a servicio social.

DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112456 IMPRESO EL 11/03/2020 12:26:43 p.m.

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

1. The first part of the document is a title page.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

71

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	12/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	50

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DÍAS DE INTERNACION: 50

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

EXAMEN FISICO:

SIGNOS VITALES: TA: 100/60mmHg - FC 75 LPM - FR:16 RPM - T 36.1/ SAT 98% (0.21)
Diuresis conservada por sonda vesical

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona,, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:

- * Paciente que pasa de la sala 4 a sala 1 con motivo de requerimiento de camas en dicha unidad en el contexto epidemiologico actual.
- *Paciente con internacion prolongada de causa social, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.
- *Se mantienen indicaciones medicas.
- *Seguimiento por servicio social.
- *Sin acompañante al momento del examen.

DR. JULIO SERNA CONCURRENTE CLINICA MEDICA MN 169132

IDPTES06485IDCM713SIDCMED112535 IMPRESO EL 12/03/2020 02:07:26 p.m.

Julio Cesar Serna
Medico
M.N. 169132

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

72

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	13/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	51

DIAGNOSTICO:

Causa Social

EVOLUCION:

DIAS DE INTERNACION: Dia 51

ASLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:

SIGNOS VITALES: TA: 100/60mmHg - FC 95 LPM - FR:16 RPM - T 36.4c SAT 95% (0.21)

Diuresis: conservada por pañal

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Sopro Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:

*Al momento asintomatica, se encuentra estable clinicamente, afebril, hidratada, sin asistencia familiar durante la mañana para su hidratacion y alimentacion.

*Presenta orina turbia por sonda vesical, se indica retiro de sonda vesical y toma de urocultivo.

*Paciente con internacion prolongada de causa social, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social, con alto riesgo de complicaciones derivada de la misma.

*Seguimiento por servicio social.

*Sin acompañante al momento del informe medico.

DR. JULIO SERNA CONCURRENTE CLINICA MEDICA MN 169132

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED112595 IMPRESO EL 13/03/2020 04:43:22 p.m.

Julio Cesar Serna
Médico
M.N. 169132

16/03/2020 Kinesioología.

Paciente útil, poco colaboradora. Orientada principalmente en persona, disminuida en tiempo y espacio. Pobre audición perimetral y valoración de la deglución. No se obtienen signos macroscópicos de aspiración con Sml de semilíquidos y líquidos, presenta obstrucción con semilíquidos (residuos en cavidad oral) lo se evalúa con sólidos por la neuromotilidad anteriormente. Se sigue alimentación vía oral con cabeza a 45° o más y alimentos semilíquidos y líquidos en pequeñas cantidades con asistencia.



Lic. VETTESE ANDRES
Kinesiólogo Fisiatra - U.B.A.
M.N. 15216

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

73

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		HC N°	402454
Fecha:	16/03/2020	Cama:	18	Días Int. 54

DIAGNOSTICO:
Causa Social

EVOLUCION:
16/03/2020:
DIAS DE INTERNACION: Día 54

ASLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercede registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se reutiliza HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 102/55 mmHg - FC 95 LPM - FR:16 RPM - T 36.5° SAT 95% (0.21)
Diuresis: conservada por pañal

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.
Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
*Al momento asintomatica, se encuentra estable clinicamente, afebril, hidratada, sin asistencia familiar durante la mañana para su hidratacion y alimentacion.
*Presenta orina turbia por sonda vesical, se indica retiro de sonda vesical y toma de urocultivo.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social, con alto riesgo de complicaciones derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.
*Recibo laboratorio con anemia Hb 10.5, resto sp.
*Se habla con kinesióloga quien realiza prueba de deglución a dieta blanda y liquidos, con buena tolerancia. Sugiere no dar sólidos porque mantiene contenido en la boca luego de comer.
Continúa igual tratamiento.

DR. SEBASTIAN CHERNY MEDICO CLINICO MN 129911

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112629 IMPRESO EL 16/03/2020 01:14:30 p.m.


SEBASTIAN CHERNY
 ESP. EN MEDICINA INTERNA
 M.N. 129911

—

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

74

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	17/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	55

DIAGNOSTICO:

Causa Social

EVOLUCION:

DÍAS DE INTERNACION: DÍA 55

—AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:

SIGNOS VITALES: TA: 90/60 mmHg - FC 90 LPM - FR:16 RPM - T 36.0° SAT 93% (0.21)

Diuresis: 200 ml por sonda vesical

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, reactiva, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:

*Evolucion aa la fecha sin interurrencias clinicas a la fecha, no presencia conducta activa por clinica medica, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.

*Urocultivo del día 13/03 con FPM con sedimento urinario no inflamatorio, paciente asintomatica, se espera conducta antibiotica.

*Paciente con internacion prolongada de causa social, con alto riesgo de complicaciones derivada de la misma.

*Seguimiento por servicio social.

DR. JULIO SERNA CONCURRENTE CLINICA MEDICA MN 169132

IDPTE506485IDCM713SIDCMED112693 IMPRESO EL 17/03/2020 01:42:19 p.m.

Julio Cesar Serna
Médico
M.N. 169132

2024

21

22

23

75

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	18/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	56

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION: DÍA 56

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

TERCURRENCIAS:
intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se reactiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 90/60 mmHg - FC 92 LPM - FR:16 RPM - T 36.9° SAT 94% (0.21)
Diuresis: 300 ml por sonda vesical

Somnolienta, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecánica respiratoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril. Somnolienta en el día de hoy que se interpreta de origen farmacológico por excitación en la noche.
*Evolucion aa la fecha sin interurrencias clínicas a la fecha, no presencia conducta activa por clínica medica, en plan de derivación a tercer nivel por su obra social.
Urocultivo del día 13/03 con FPM con sedimento urinario no inflamatorio, paciente asintomática, se espera conducta antibiotica.
*Paciente con internación prolongada de causa social, con alto riesgo de complicaciones derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED112733 IMPRESO EL 18/03/2020 12:14:41 p.m.


Florencia Valenti
Médica U.B.A.
M.N. 157.163

Kinesología.

19-3-2020.

Parte medial, situada en posición de flexión y espacio. No colabora nada. Mobiliza 4 dedos, no reduce carhus de punta de punta medialmente. Percebe asistida la misma postura: movilizar artro-punta de extremidades, se distiende al borde de la cuna con máxima atención, buen control de tono y mala tolerancia, la parte interna del cubito por voluntad propia. Percebe cuando presionas.

Percebe la parte de cuando se oye.



Lic. VETTEZE ANDRES
Kinesiólogo Fisiatra - U.B.A.
M.N. 15216

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	19/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	57

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- CAUSA SOCIAL -

EVOLUCION:
19/03/2020:

DIAS DE INTERNACION: DÍA 57

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACIÓN: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion a cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO
Paciente vigil con buena respuesta a ordenes simples, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
SIGNOS VITALES: TA: 100/60 mmHg - FC 89 - FR:17 - T 36.4° SAT 97% (0.21)

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable, afebril. Al momento del examen.
*Evolucion a la fecha sin interurrencias clinicas a la fecha, no presencia conducta activa por clinica medica, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.
*Urocultivo del dia 13/03 con FPM con sedimento urinario no inflamatorio, paciente asintomatica, se expecta conducta antibiotica.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, con alto riesgo de complicaciones derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.

ALTA COMORBILIDAD POR INTRNACION PROLONGADA

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE ***
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112783 IMPRESO EL 19/03/2020 11:22:05 a.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.M. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(77)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	20/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	58

DIAGNOSTICO:

*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

DÍAS DE INTERNACION: DÍA 57

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ, por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO

TA 140/80 FC 78 FR 16 T° 36.2 SAT 96% (0.21)

Paciente vigil con buena respuesta a ordenes simples, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

Buena mecánica respiratoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:

Paciente clínicamente estable, afebril. Al momento del examen.

*Presenta piuria, por lo que se toma urocultivo. Conducta antibiotica expectante, según resultados.

* Sin familiares presentes.

ALTA COMORBILIDAD POR INTRNACION PROLONGADA

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE ***

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED112844 IMPRESO EL 20/03/2020 01:22:38 p.m.

20/03/20 Clinica Medica Guardis

22:04hs Audiencia al llanto de enfermería
refiriendo que el familiar le disculpó
con 12 denuncias de 12 Sds otros movimientos
> 12 pte con su casa por los patillos
del 1º piso para su traslado a algun otro
Sector del Hospital; previo a esto informo al
supervisor de enfermería que dicho familiar
afirmo verbalmente al personal de

Florencia Valenti
Médica - UBA
M.N. 157.163

enfermería de la Sds -

Pte vigil, despierto, TA 100/60 FC 60x'
SO₂ 93%. BEAB MV(T) sin ruidos
expirados, mucosidad en farces con
un manejo de secreciones con lipo purpura.
R.R en 4 focos sin pte de hawthorn

Abdomen s/p -

Presente flebitis en MSD.

Se indica aspiración de lipo purpura,
nota vis periférica, colocar medias
frías en antebrazo derecho. y

Control técnico.

Conducto espectral

Se informa el estado de la pte al hijo.
El mismo se recibe del Hospital sin
conflicto.


DANIELA PARERA
M.N. 101237
MEDICA


Andres P. Guerrero
M.N. 100632

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454
Fecha: 25/03/2020 Cama: 18 Días Int.: 63

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

ASLAMIENTO KPC

MEROPENEM DIA 4
VANCOMICINA DIA 4

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO

TA 130/70 FC 82 FR 22 T° 36,4 SAT 97% (0.21)

Paciente vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba

aceptable mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable, afebril. Ancia geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la reanimación, cubriéndose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Roto esquema a PTZ-Vancomicina.

Se realiza EAB (0.21): 7.42/26/103/17/-6.1/98% Lactico 0.73.

Se explica a familiar el cuadro clínico y el pronóstico reservado de la paciente como consecuencia de alta comorbilidad por internación prolongada en paciente añosa.

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE ***

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112896 IMPRESO EL 25/03/2020 11:50:55 a.m.


Florencia Valenti
Médica - U.B.A.
M.N.: 157163

11

12

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

79

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	25/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	63

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION DE GUARDIA:

12 y 20 hs

Dejamos constancia que quien refiere ser su hijo presenta conductas inapropiadas en la sala conducta querellante con el personal medico. En el día de la fecha retira de el recipiente de residuos patológicos de la habitación la comida de la internada distribuyendola por la habitación sobre camas y demas.

Ante esta situacion se llama a personal de seguridad quienes se presentan de inmediato y retiran al referido.

Me comunico con jefa de Departamento informando la situación para que tome conocimiento.

Enfermería presente en el momento de dicho acto. Por lo que vuelco en su report lo acontecido. Dada la conducta desadaptada se sugiere limitar el ingreso.

Se deja constancia de lo acontecido.

R. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED112896 IMPRESO EL 25/03/2020 01:10:14 p.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

A/C

— 100 —

100

100

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA



Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	26/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	64

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs. carencial)
- CASO SOCIAL

EVOLUCION:
26/03/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA:

ASLAMIENTO KPC

MEROPENEM DIA 5
VANCOMICINA DIA 5

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se reevalua HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO

Paciente en mal estado genral, vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
R1 / R2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, ronus y sibilancias bilaterales como ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
TA 120/65 FC 74 FR 21 T° 36.0 SAT 97% (0.21) AIRE AMBIENTE

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable, afebril.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internacion por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a TERAPIA, cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Roto esquema a PTZ-Vancomicina.

** Se explica a familiar el pronostico reservado de la paciente dado la intercurrency intrahospitalaria en contexto de paciente añosa **

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE, PRESENTA CONDUCTA NO ACORDE A LAS BUENAS COSTUMBRES, A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ***
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112935 IMPRESO EL 26/03/2020 12:02:15 p.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
MN. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

11

1

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

81

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	27/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	65

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA:

ASLAMIENTO KPC

PIPERACILINA TAZOBACTAM 6
VANCOMICINA DIA 6

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
 *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
 * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, en tratamiento con PTZ-Vancomicina

EXAMEN FISICO
 TA 130/80 FC 96 FR 20 T° 35.5 SAT 96% (0.21)
 Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
 Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
 Aceptable mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, rales de secreción alta.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Catarsis positiva.
 Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

COMENTARIOS:
 Paciente clínicamente estable, afebril.
 Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica, cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que indica suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizan HMC control.
 Pronóstico reservado de la paciente dado la intercurencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa

SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE50648SIDCM713SIDCMED112971 IMPRESO EL 27/03/2020 12:53:52 p.m.


 Valenti F
 17163

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

82

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	30/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	68

DIAGNOSTICO:

- * infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- * Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 9

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- * Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

TA 150/80 FC 62 FR 18 T° 37.3 SAT 96% (0.21)

D: 150 ml/3 hs B: +350

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.

Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba,

Buena mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva.

Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable, afebril.

Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica, cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.

Pronostico reservado de la paciente dado la intercurencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa

SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HUO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE50648SIDCM713SIDCMED113007 IMPRESO EL 30/03/2020 09:55:29 a.m.

Florencia Valenti
Médica UBA
M.N.: 157.163

100

100

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

83

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	31/03/2020	Cama:	18
		Días Int.	69

DIAGNOSTICO:

INFECCION URINARIA- CAUSA SOCIAL -

EVOLUCION:

31/03/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AJSLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 10

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina dia 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.

Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos. Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva.

Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

TA 130/80 FC 65 FR 17 T° 36.7 SAT 96% (0.21)

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable, afebril, normotensa.

Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.

Pronóstico reservado de la paciente dado la intercurrency intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continue esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia.

Su familiar se hace presente en le dia de ayer en servicio social, este servicio se comunica con quien suscribe en horas de la tarde informandome la posibilidad de vacante de la paciente en tercer nivel ,, solo se aguarda que se de aviso a serv social de pami , que la paciente a cumplido esquema antibiotico.

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
 actualizo indicaciones

DR. NESTOR SCHINOCCA-MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE50648SIDCM713SIDCMED113032 IMPRESO EL 31/03/2020 10:31:48 a.m.


Dr. NESTOR SCHINOCCA
 M.N. 104.860
 ESP. EN CLINICA MEDICA
 ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

 31/03/2020



CC

CC

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

84

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	01/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	70

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
 EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO XPC

VANCOMICINA DIA 11

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
 *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
 * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meníngeo al momento del examen.
 Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
 Aceptable mecánica ventilatoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Catarsis positiva.
 Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
 TA 120/80 FC 72 FR 17 T° 36.7 SAT 96% (0.21)

COMENTARIOS:
 Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa.
 Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapéutica, cubriéndose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
 Pronóstico reservado de la paciente dado la intercurrentia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continúa esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetología.

****Su familiar se hace presente en le día de ayer en servicio social, este servicio se comunica con quien suscribe en horas de la tarde informandome la posibilidad de vacante de la paciente en tercer nivel,, solo se aguarda que se de aviso a serv social de pami, que la paciente a cumplido esquema antibiotico.******

*****ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL *****
 actaulizo indicaciones

DRA. GRETTEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MN 89051

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113061 IMPRESO EL 01/04/2020 11:25:05 a.m.

2/4/2020 Kinesología A.

Punto 1º, no colaboradora que no responde a orden simples. Puede realizar pases de pulso simples y de pulso intermedio. Pulso intermedio es el estado de pie a raíz de pulso. Puede hacer pases. Se comienza en pulso tratado.


Lic. VETTESE ANDRÉS
Kinesiólogo Fisioterapeuta - U.B.
M.N. 15216

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

85

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	02/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	71

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AI SLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 12

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con vitivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.

Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Aceptable mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva.

Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

TA 110/70 FC 72 FR 17 T° 36.7 SAT 96% (0.21)

COMENTARIOS:

Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa.

Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica, cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.

Pronostico reservado de la paciente dado la intercurencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continúa esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia.

Su familiar se hace presente en le dia de ayer en servicio social, este servicio se comunica con quien suscribe en horas de la tarde informamndome la posibilidad de vacante de la paciente en tercer nivel,, solo se aguarda que se de aviso a serv social de pami, que la paciente a cumplido esquema antibiotico.*

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***

actualizo indicaciones

DRA. GRETTEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MN 89051

GRETTEL BREVEDAN
CLINICA MEDICA
MN 89051 - M.P. 445280

20

20

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

86

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	06/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	75

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AIJSLAMIENTO KPC

VANCOMICINA ——— cumplio tto por 14 días

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FÍSICO

Vigil con tendencia al sueño, deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.

R1 /R2 en 4 focos; Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 3/6

Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva.

Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

TA 130/80 FC 78 FR 18 T° 36.2 SAT 96% (0.21) aire ambiente.

COMENTARIOS:

Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa.

Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.

Pronostico reservado de la paciente dado la intercurencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia día 13 finalizando el día domingo
 Se evaluara el día Lunes remitir a PAMI resumen de HC para tercer nivel.

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
 actualizo indicaciones

DRA. GRETIL BREVEDAN CLÍNICA MEDICA MN 89051

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113199 IMPRESO EL 06/04/2020 12:40:57 p.m.

06/04/2020 12:40:57 p.m.
 GRETIL BREVEDAN
 CLINICA MEDICA
 MN 89051



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(83)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC N°	402454
Fecha:	14/04/2020	Cama:	18	Días Int.	83

EVOLUCION:

Evolucion diaria

Días de Internación 83

KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

* Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ, por lo que se reactiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO:

SV= TA 100/60; FC 88; FR 18, T 36.2, SAT 95% (0.21)

Vigil, deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico. R1/R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba al momento del examen.

Aceptable mecanica ventiliatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

persiste fiebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapeutica, dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona-neomicina- antifungico), aplicar 2 veces por dia.

Continua en tramite lo enviado a servicio social, las interurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascendente en la medida que el paciente prolonga su estadía hospitalaria, por tal motivo se insiste que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable afebril, cursando iternacion prolongada, sin cambios al examen fisico respecto a la evolucion anterior al momento del examen.

Paciente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****

continua en seguimiento por la especialidad.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113454 IMPRESO EL 14/04/2020 08:35:14 a.m.

[Firma manuscrita]
 J. MARTIARENA
 14/04/2020

0

0

88

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	20/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	89

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de internación 89- KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- *21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ- Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.
- *16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae, pendiente tipificación, en tratamiento con meropenem.

EXAMEN FISICO

SV= TA 90/60, FC 90, FR 20, T 36.3, SAT 95% (0.21)

Diuresis 200 ml en 2 hs. Orina clara.

Vigil, no responde a ordenes simples, en contexto de deterioro cognitivo cronico e infeccion, sin foco motor ni meningeo.

Bien perfundida, R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible dolor a la palpacion en puntos ureterales bilaterales, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapeutica, dermatitis del pañal en tratamiento topico.

COMENTARIOS:

Paciente en mal estado general, vgi geriátrica con multiples síndromes geriátricos, comorbilidades, internacion prolongada con interurrencias de índole infecciosa por germenres resistentes. Al momento se encuentra cursando interurrencia infecciosa por itu bacterémica por Klebsiella pneumoniae en estudio, en tratamiento con meropenem, tambien presenta hmc 1 de 2 para samr. UC con Kpneumonia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Se realiza ic con infectologia, quien indica nueva tomo de hemocultivos e iniciar vancomicina.

Paciente que no se alimenta por sus propios medios, hipoalbuminémica, poliescarada, se decide colocar sonda nasogastrica.

Paciente con pronostico reservado. No se presentan familiares para comunicarlles el informe clinico de la paciente.

Se solicita laboratorio por central para el día lunes.

Se actualizan indicaciones medicas.

Continua control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113682 IMPRESO EL 20/04/2020 12:15:34 p.m.


AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

CC

CC



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2146478
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 30/03/20 09:05
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

Página 2 de 3

HEMOSTASIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

APTT 23 seg 21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana María Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA 81 mg/dl 70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE 26 mg/dl 10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE 0,86 mg/dl 0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico

HEPATOGRAMA
Método: Automatizado
Colesterol Total 116 mg/dl Deseable <200 mg/dl
Moderado 200 - 239
Alto >240

Bilirrubina Total 0,34 mg/dl 0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa 0,16 mg/dl 0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta 0,18 mg/dl

Fosfatasa Alcalina 101 UI/L 40 - 130 UI/L

TGO 27 UI/L 5 - 34 UI/L

TGP 18 UI/L 8 - 40 UI/L

Proteínas Totales 5,3 g/dl 6,0 - 8,7 g/dl

CALCIO, SANGRE 8,0 mg/dl 8,5 - 10,4 mg/dl
Método: Colorimétrico

FOSFORO, SANGRE 3,0 mg/dl 2,4 - 4,7 mg/dl
Método: UV

MAGNESIO 1,34 mg/dl 1,6 - 2,55 mg/dl
Método: Colorimétrico

IONOGRAMA
Método: Electrodo Ión Selectivo
Sodio 151 mmol/L 135 - 145 mmol/L



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2146478
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 30/03/20 09:05
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 3 de 3

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

	Resultados	Valores de Referencia
Potasio	3,0 mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	111 mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

Silvia Graciela Oliveto
Bioquímica - M.N. 6677

DROGAS TERAPEUTICAS

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

	Resultados	Valores de Referencia
VANCOMICINA	12 µg/ml	Valle: 5 - 10 µg/ml Pico: 20 - 40 µg/ml

Método: Inmunoturbidimetría

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2146478
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 30/03/20 09:05
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 3

HEMATOLOGIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,26	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	9,1	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	28,5	%	36,0 - 44,0 %

Índices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	87,5	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	27,8	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,8	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	15,8	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	267,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	8,5	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	16,3	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,226	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	6,65	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$		
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	74,30	%	4.94 $\times 10^9/L$	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	15,90	%	1.06 $\times 10^9/L$	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	7,42	%	0.49 $\times 10^9/L$	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	1,76	%	0.12 $\times 10^9/L$	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,55	%	0.04 $\times 10^9/L$	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION	51	mm	1 - 16 mm
---------------------	----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	2,41	0,90 - 1,20
-----	------	-------------

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

92

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	03/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	72

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- Infección urinaria- HC + a foco endovascular

EVOLUCION:

03/04/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

ASLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 13

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
 R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
 Aceptable mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Catarsis positiva.
 Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
 TA 120/75 FC 70 FR 17 T° 36.2 SAT 96% (0.21) aire ambiente.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable, afebril, normotensa.
 Anciana geriatrica, postrada, cursando internacion por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica, cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
 Pronostico reservado de la paciente dado la intercurencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia día 13 finalizando el día domingo
 Se evaluara el día Lunes remitir a PAMI resumen de HC para tercer nivel.

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
 actualizo indicaciones

DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113120 IMPRESO EL 03/04/2020 09:32:49 a.m.


 DR. NESTOR SCHINOCCA
 M.A. 104.860
 ESP. EN CLINICA MEDICA
 ESP. EN TERAPEUTICA

7/4/20 Kinesología: ~~respiración~~

Paciente vigil, desorientada globalmente, ruidos
incomprensibles. Sedista con cabeza a 60° en
cama. Se evalúa deflución, no presente
signos macroscópicos de aspiración con
resolidos pero si con ruidos tose repetidas
veces. No se evalúa con solidos por falta de
piezas dentarias. Darse cuidados
personales.

Lic. Luperón Prieto
Kinesióloga Fisióloga
M.N. 14408

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

93

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	07/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	76

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- Infección urinaria- deterioro cognitivo crónico- causa social

EVOLUCION:

07/04/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA ——— cumplio tto por 14 días

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil , deterioro cognitivo crónico, sin foco motor ni meníngeo al momento del examen semiológico.
 R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 2/6. al momento del examen.
 Aceptable mecánica ventilatoria , hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.
 Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Catarsis positiva.
 disminución de lesión edematosa por flebits en antebrazo
 TA 120/70 FC 88 FR 18 T° 36.1 SAT 96% (0.21) aire ambiente.

COMENTARIOS:

Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa. Con alta comorbilidad por estada prolongada en medio nosocomial
 Anciana geriátrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
 Continúa esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia día 13 finalizando el día domingo

****Se remite a PAMI resumen de HC para tercer nivel.****

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***

actaulizo indicaciones

DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113246 IMPRESO EL 07/04/2020 11:21:25 a.m.


 DR. NESTOR SCHINOCCA
 M.N. 104.860
 ESP. EN CLINICA MEDICA
 ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

CC

CC

84

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	08/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	77

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

Evolucion diaria
Dias de internacion 77

ASLAMIENTO KPC

VANCOMICINA ——— cumplio tto por 14 dias

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

tercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina dia 8.

EXAMEN FISICO

TA 120/80 Fc 82 Fr 20 T 36.2 SAt 985 0.21

Vigil, deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Sopio Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 2/6. al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
disminucion de lesion edematosa por flebits en antebrazo

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable afebril, cursando iternacion prolongada, sin cambios al examen fisico, presenta mimenro inferior izquierdo edematizado, lugar donde rpevio presento acceso venoso periferico, no HOMMAN no pai piente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel
continua en seugimiento por la especialidad.

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113320 IMPRESO EL 08/04/2020 01:45:51 p.m.

Gustavo A. Medina Soto
Médico
M.N. 158.673

100

100

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

95

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	09/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	78

DIAGNOSTICO:
 *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
 *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
 - Infección urinaria - causa social -

EVOLUCION:
 09/04/2020:
 Evolucion diaria
 Dias de internacion 78

AISLAMIENTO KPC

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

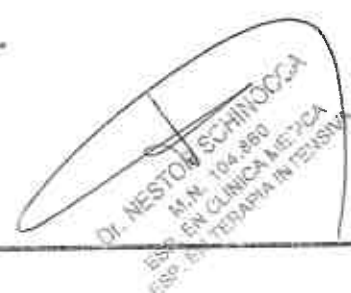
INTERCURRENCIAS:
 *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC-UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
 * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO:
 Vigli, deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
 R1/R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IV 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 2/6, al momento del examen.
 Aceptable mecanica ventiliatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
 Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
 Cataris positiva.
 disminucion de lesion edematosa por flebits en antebrazo
 TA 125/80 Fc 80 Fr 17 T 36.3 SaO2 98.5 O2 21

COMENTARIOS:
 Paciente clinicamente estable afebril, cursando internacion prolongada, sin cambios al examen fisico respecto a la evolucion anterior al momento del examen.
 Paciente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico
 en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ***
 continua en seguimiento por la especialidad.
 DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 304860

IDPYES06485IDCM7135IDEMED113941 IMPRESO EL 09/04/2020 10:00:51 a.m.


 DR. NESTOR SCHINOCCA
 M.N. 104.860
 ESP. EN CLINICA MEDICA
 ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

17

17

17

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

96

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	13/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	82

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- Infección urinaria - causa social -

EVOLUCION:

13/04/2020:

Evolucion diaria

Días de internación 82

KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- * Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil, deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico. R1/R2 en 4 focos. Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello. sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.

Aceptable mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra-umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

persiste flebitis en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapeutica, dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por día.

Continua en tramite lo enviado a servicio social, las interurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascedente en la medida que el paciente prolonga su estadía hospitalaria, por tal motivo se insiste que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable afebril, cursando iternacion prolongada, sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.

Paciente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****

continua en seugimiento por la especialidad.

ACTUALIZO INDICACIONES.

DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTES0648SIDCM713SIDCMED113425 IMPRESO EL 13/04/2020 10:34:39 a.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

94

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	15/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	84

EVOLUCION:

Evolucion diaria

Días de internación 84

KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

* Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.

EXAMEN FISICO

SV= TA 110/60, FC 80, FR 18, T 36.1, SAT 95% (0.21)

Vigil, deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico. R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.

Aceptable mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapeutica, dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por dia.

Continua en tramite lo enviado a servicio social, las interurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascendente en la medida que el paciente prolonga su estadia hospitalaria, por tal motivo se insiste que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable afebril, cursando iternacion prolongada, sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.

Paciente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****

continua en seugimiento por la especialidad.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113547 IMPRESO EL 15/04/2020 01:12:37 p.m.

Chent
Martíarena Ailen
MN 153107

3

3

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

88

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		HC N°	402454
Fecha:	16/04/2020	Cama:	18	Días Int. 85

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

16/04/2020: Paciente de 76 años

Días de internación 85

KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *Intercurre registros subfebriles en día 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evolucion con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- * Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.
- *Intercurre el día de hoy (16/04) con hipotension, mala perfusion distal y equivalentes febriles, taquicardia y taquipnea, a probable foco urinario por presencia de sedimento purulento por sv y puntos ureterales +.Salen HMC por dos, uro cultivo y labo de guardia.

EXAMEN FISICO

SV= TA 80/60, FC 100, FR 25, T 38, SAT 92% (0.21)

Vigil, deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico. R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.

Aceptable mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible dolor a la palpacion en puntos ureterales bilaterales, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Cetarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapeutica, dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por dia.

Continúa en tramite lo enviado a servicio social, las interurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascendente en la medida que el paciente prolonga su estadia hospitalaria, por tal motivo se insiste que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:

Paciente clinicamente estable afebril, cursando iternacion prolongada, sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.

Paciente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico

en plan de derivar a 3 nivel.

Debido a sepsis a foco urinario se inicia tratamiento con meropenem 1 gr cada 8 hs.

Pendiente:

- Seguimiento de cultivos y laboratorio de guardia.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113596 IMPRESO EL 16/04/2020 02:33:19 p.m.


 Patricia Perez
 16/04/2020

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

99

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	17/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	86

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de internacion: 86

KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.

*16/04: ITU bacteremica por BGN, pendiente tipificacion, en tratamiento con meropenem.

EXAMEN FISICO

SV= TA 90/60, FC 92, FR 20, T 36.1, SAT 95% (0.21)

Diuresis 100 ml en 2 hs. Orina clara.

Vigil, no responde a ordenes simples, en contexto de deterioro cognitivo crónico e infección, sin foco motor ni meníngeo.

Bien perfundida, R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, depresible dolor a la palpación en puntos ureterales bilaterales, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapéutica, dermatitis del pañal en tratamiento topico.

COMENTARIOS:

Paciente en mal estado general, vgi geriátrica con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades, internación prolongada con interurrencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes. Al momento se encuentra cursando interurrencia infecciosa por itu bacteremica, al momento por bgn, en estudio, en tratamiento con meropenem, pendiente tipificación para ajustar atb a germen.

Paciente con pronóstico reservado sin familiares al momento del parte médico.

Se solicita laboratorio por central para el día lunes.

Se actualizan indicaciones médicas.

Continúa control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113627 IMPRESO EL 17/04/2020 10:49:13 a.m.

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

✓

✓

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

102

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	21/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	90

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de internación 90- KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.

*16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajustado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina.

EXAMEN FISICO

SV= TA 100/60, FC 92, FR 20, T 36.2, SAT 96% (0.21)

Diuresis 500 ml en 3 hs. Orina clara.

Vigil, no responde a órdenes simples, en contexto de deterioro cognitivo crónico e infección, sin foco motor ni meníngeo.

Bien perfundida, R1/R2 en 4 focos, Sople Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diurético conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapéutica, dermatitis del pañal en tratamiento tópico.

COMENTARIOS:

Paciente en mal estado general, vgi geriátrica con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades, internación prolongada con intercurencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes. Al momento se encuentra cursando intercurencia infecciosa por ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Además HMC positivo para SAMR. Se realiza IC con infectología, quien indica nueva tomo de hemocultivos e iniciar vancomicina, asociado a piperacilina-tazobactam.

HEMOCULTIVOS CONTROL DEL DÍA 20/04: Negativos a la fecha.

Se recibe laboratorio de central:

Hto= 26.2 Hemo= 7.6 Bcos= 10600 Pla= npf KPTT= 28 RIN= 3.08 Gluc= 99 Urea= 165 Creat= 3.23 Clear crea: 20 Colest= 82 Prot= 4.7 Albu= 1.8 Bilir= 0.23 F.Alca= 82 TGO= 27 TGP= 13 Calc= 7.5 Fosfat= 3.9 Magne= 2.2 Otros= Na= 179 Ka= 3.6 Cloro= 139 Calcio.C= 9.26

Por hipernatremia se inicia agua libre por sonda nasogastrica. Por insuficiencia renal de probable etiología prerrenal, se aumenta aporte y se ajustan antibiotico a clearance. Pendiente resultado de laboratorio control para el día de la fecha.

Paciente con pronóstico reservado.

No se presentan familiares para comunicarle el informe clínico de la paciente.

Se actualizan indicaciones médicas.

Continúa control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM713SIDCMED113736 IMPRESO EL 21/04/2020 10:58:04 a.m.

Handwritten signature:
Martarena Ailen
MN 153107



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

101

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	22/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	91

DIAGNOSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de internacion 90- KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- *21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.
- *16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajustado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina.

EXAMEN FISICO

SV= FR 18, T 35.7

Diuresis 500 ml en 3 hs. Orina clara.

Apertura ocular espontanea, sin contenido de conciencia, posicion viciosa en flexion.

R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecanica ventilatoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, impresion no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapeutica, dermatitis del pañal en tratamiento topico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:

Paciente en mal estado general, vgi geriátrica con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades, internacion prolongada con interurrencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes, por lo cual presenta alta morbi-mortalidad, con pronóstico ominoso a corto plazo. Al momento se encuentra cursando interurrencia infecciosa por ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Además HMC positivo para SAMR. Se realiza IC con Infectología, quien indica nueva tomo de hemocultivos e iniciar vancomicina, asociado a piperacilina-tazobactam.

MOCUTIVOS CONTROL DEL DIA 20/04: positivo para cocos en racimo, pendiente tipificación.

Por hipernatremia se inicia agua libre por sonda nasogastrica. Por insuficiencia renal de probable etiología prerrenal, se aumenta aporte y se ajustan antibiotico a clearance. Pendiente resultado de laboratorio control para el día de la fecha.

Paciente con pronóstico reservado.

No se presentan familiares para comunicarle el informe clínico de la paciente. Se intenta comunicación telefónica en varias oportunidades con teléfono contacto (hijo) para dar aviso de la situación crítica de su madre. Ante antecedente conocido de trastorno psiquiátrico del hijo, con episodios de violencia hacia médicos y enfermeros en previas visitas e informe médicos, se da aviso a Directora de Departamento, Dra Gasset y se coordina con servicio de psiquiatría el manejo llegado el caso de tener que dar informe presencial del deceso de la paciente.

Se actualizan indicaciones medicas.

Continua control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113799 IMPRESO EL 22/04/2020 01:22:42 p.m.


MARTIARENA AILEN
GASSET

THE JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

102

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	23/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	92

DIAGNÓSTICO:

- *Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
- *Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCIÓN:

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de Internación: 92 - KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

- *ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
- *21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.
- *16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajustado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina.

EXAMEN FISICO

SV= FR 10 T 36.9

ECAF: 0

Apertura ocular espontánea, sin contenido de conciencia; posición viciosa en flexión.

R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapéutica, dermatitis del pañal en tratamiento tópico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:

Paciente cursando internación prolongada en clínica médica, de causa social, con múltiples interurrencias infectológicas, en el contexto de internación prolongada.

Paciente que el día 16/4 presenta otitis purulenta, motivo por el que se realizaron HCT por dos y urocultivo, con rescate de s. aureus y bacilo gram negativo.

se recibe llamado de bacteriología de presentar SAMR, por lo que continúa en tratamiento ATB con vancomicina se actualizan indicaciones.

Se intenta comunicación telefónica con el hijo para avisarle de forma telefónica,

se comunica a salud emtinal sobre el contexto del hijo quienes sugieren dar parte médico en forma conjunta.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113807 IMPRESO EL 23/04/2020 09:12:46 a.m.

Gustavo J. Martínez Suro
 Médico
 M.N. 159.673

24/04/2020 Infectología

Paciente curso uterino prolongado. Actualmente en
tratamiento por bacteriemia por SAMR / K pneumoniae.
con PTZ / VAN ajustado a función renal.

- Hemo (16/4) SAMR + K pneumoniae @ PTZ.

- Hemo (20/4) SAMR.

Se sugiere: { realizar hemocultivos control.
{ retirar vanco intrín
{ suspender PTZ.
{ ecocardiograma / Fo.

CABRERA M. CONSTANZA
MÉDICA INFECTOLOGA
M.N. 128126

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

103

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	24/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	93

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de Internación 93- KPC (+)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Mujer, 75 años de edad, síndrome demencial, esquizofrenia, VGI previo a internación: anciana geriátrica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiótico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.

*16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajustado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina. Finaliza en el día de la fecha PTZ, continúa con vancomicina.

EXAMEN FISICO

SV= FR 18, T 35.7

Diuresis 300 ml en 3 hs. Orina clara.

Apertura ocular espontánea, sin contenido de conciencia; posición viciosa en flexión.

R1/R2 en 4 focos, Sopló Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catársis positiva, ritmo diurético conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapéutica, dermatitis del pañal en tratamiento tópico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:

Paciente en mal estado general, VGI previa geriátrica con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades, internación prolongada con interurrencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes, por lo cual presenta alta morbi-mortalidad. Al momento se encuentra cursando interurrencia infecciosa por ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Además HMC positivo para SAMR que se jerarquizan por múltiples puertas de entrada a nivel de piel, presenta HMCX2 control del día 20/4 que continúan positivos para SAMR. Paciente con pronóstico ominoso a corto plazo, por lo cual se adecua la intención terapéutica a manejo de síntomas y confort, asociado a continuar con antibioticoterapia. No se realizará plan de estudio de bacteremia persistente.

-No se presentan familiares para comunicarle el informe clínico de la paciente.

-Se intenta comunicación telefónica en varias oportunidades con teléfono contacto (hijo) para dar aviso de la situación crítica de su madre.

Ante antecedente conocido de trastorno psiquiátrico del hijo, con episodios de violencia hacia médicos y enfermeros en previas visitas e informe médicos, se da aviso a Directora de Departamento, Dra Gasset y se coordina con servicio de psiquiatría el manejo llegado el caso de tener que dar informe presencial del descenso de la paciente.

Se actualizan indicaciones médicas.

Continúa control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113863 IMPRESO EL 24/04/2020 10:36:34 a.m.


AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
N.N. 153.107

104

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC N°	402454
Fecha:	27/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	96

EVOLUCION CLINICA MEDICA

Días de internación 96- KPC (+)

ANTECEDENTES PERSONALES:

Mujer, 75 años de edad, síndrome demencial, esquizofrenia, VGI previo a internación: anciana geriátrica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonía adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:

*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 días.

*16/04: ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajustado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina. Finaliza en el día de la fecha PTZ, continúa con vancomicina.

EXAMEN FISICO

SV= FR 18, T 35.2

Apertura ocular espontánea, sin contenido de conciencia, posición viciosa en flexión.

R1 /R2 en 4 focos; Sopro Sistólico 3/6 audibles en 4 focos con irradiación a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.

Buena mecánica ventilatoria, hipoventilación global por falta de colaboración, sin ruidos agregados.

Abdomen globoso, blando, impresión no dolorosa, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.

Persiste flebits en antebrazo con mejoría y respuesta a la terapéutica, dermatitis del pañal en tratamiento tópico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:

Paciente en mal estado general, VGI previa geriátrica con múltiples síndromes geriátricos, comorbilidades, internación prolongada con interurrencias de índole infecciosa por gérmenes resistentes, por lo cual presenta alta morbi-mortalidad. Al momento se encuentra cursando interurrencia infecciosa por ITU bacterémica por Klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Además HMC positivo para SAMR que se jerarquiza por múltiples puertas de entrada a nivel de piel, presenta HMCX2 control del día 20/4 que continúan positivos para SAMR. Paciente con pronóstico ominoso a corto plazo, por lo cual se adecua la intención terapéutica a manejo de síntomas y confort, asociado a continuar con antibioticoterapia. No se realizará plan de estudio de bacteremia persistente.

-No se presentan familiares para comunicarle el informe clínico de la paciente.

-Se intenta comunicación telefónica en varias oportunidades con teléfono contacto (hijo) para dar aviso de la situación crítica de su madre.

Ante antecedente conocido de trastorno psiquiátrico del hijo, con episodios de violencia hacia médicos y enfermeros en previas visitas e informe médicos, se da aviso a Directora de Departamento, Dra Gasset y se coordina con servicio de psiquiatría el manejo llegado el caso de tener que dar informe presencial del deceso de la paciente.

Se actualizan indicaciones médicas.

Continúa control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113910 IMPRESO EL 27/04/2020 10:41:15 a.m.


AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

105

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	28/04/2020	Cama:	18
		Días Int.	97

DIAGNÓSTICO:

*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION DE GUARDIA:

Siendo las 00:20 hs , se acude a llamado de enfermería por encontrarse a la paciente sin signos vitales.

Se constata paciente sin ruidos cardiacos, ni pulsos centrales por lo que siendo las 00:30 hs , se constata obito de la paciente KUCHASKY MARGARITA LEONOR , DNI 4214110 con HC 402454.

Se intenta comunicacion telefonica con familiar (hijo) sin exito, se deja mensaje en buzón de llamadas.

Se llenan formularios pertinentes

Se traslada obito a la morgue de este hospital.

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113945 IMPRESO EL 28/04/2020 01:24:33 a.m.


María Celeste Grams
MÉDICA
M.N. 161502

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1968

1

1968

1

1968

1968

1968



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



106
Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2150030
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/04/20 14:32
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 1

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528

HEMOCULTIVO, MUESTRA 1

Coloración de Gram
Cultivo
Identificación del Germen

Cocos Gram positivos
Se obtuvo desarrollo
Staphylococcus aureus

ANTIBIOGRAMA

Vancomicina
Observaciones

CIM	Interpretación
1,0 µg/ml	Sensible

Este microorganismo es METICILINO RESISTENTE, lo cual implica Resistencia a todos los B-lactámicos (excepto Ceftazolina) incluidos todas las combinaciones con inhibidores de B-lactamasas.

HEMOCULTIVO, MUESTRA 2

Coloración de Gram
Cultivo
Identificación del Germen

Cocos Gram positivos
Se obtuvo desarrollo
Staphylococcus coagulasa-negativo

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Amalfa
Bioquímica - M.N. 9641

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn Ave. Chicago, Ill. 60610
Tel: (312) 937-1234

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2150156
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 21/04/20 09:52
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,09	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	8,3	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	27,7	%	36,0 - 44,0 %

Indices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	89,8	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	26,8	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	29,8	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	17,5	%	11,6 - 13,9 %
Eritroblastos	1,00	%	
NRBC	0,125	$\times 10^9/L$	

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	AGLUTINACION PLAQUETARIA PLAQUETAS NORMALES EN FROTIS	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
-----------	---	-------------------------------

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	12,50	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria			
Metamielocitos	1,00	%	0%
Neutrófilos Segmentados	86,00	%	10,75 $\times 10^9/L$ 36,00 - 66,00 % 1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	11,00	%	1,38 $\times 10^9/L$ 22,00 - 40,00 % 1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	2,00	%	0,25 $\times 10^9/L$ 4,00 - 11,07 % 0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	0,00	%	0,00 $\times 10^9/L$ 0,15 - 5,07 % 0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,00	%	0,00 $\times 10^9/L$ 0,00 - 1,36 % 0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$
Relación Neutrófilos / Linfocitos	7,82		

Observaciones

HIPOCROMIA LEVE
ANISOCROMIA
ANISOCITOSIS LEVE
POIQUILOCITOSIS LEVE: ELIPTOCITOS
ROULEAUX
POLIMORFONUCLEARES CON GRANULACIONES GROSERAS
POLIMORFONUCLEARES HIPERSEGMENTADOS

ERITROSEDIMENTACION

99

mm

1 - 16 mm

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2150156
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 21/04/20 09:52
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 2 de 2

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA

Método: Hexoquinasa

128

mg/dl

70 - 110 mg/dl

UREA, SANGRE

Método: Cinético UV

184

mg/dl

10 - 50 mg/dl

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

3,08

mg/dl

0,50 - 0,90 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo ión Selectivo

Sodio

175

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,5

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

134

mmol/L

90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

1

2



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : LEONETI, NELIDA ESTER Edad: 74 Años F.N.: 25-04-1945 N° Orden: 2150157
DNI : 4873152 Médico: Sin médico asignado Fecha: 21/04/20 09:53
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 14 Página 1 de 1

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio	141	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	2,9	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	91	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2149829
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/04/20 09:17
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	2,91	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	7,6	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	26,2	%	36,0 - 44,0 %

Indices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	89,8	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	26,0	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	29,0	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	17,5	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	AGLUTINACION PLAQUETARIA PLAQUETAS NORMALES EN FROTIS	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
-----------	---	-------------------------------

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	10,60	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos Segmentados	80,80	%	8,56 $\times 10^9/L$ 36,00 - 66,00 % 1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	15,80	%	1,67 $\times 10^9/L$ 22,00 - 40,00 % 1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	1,60	%	0,17 $\times 10^9/L$ 4,00 - 11,07 % 0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	1,58	%	0,17 $\times 10^9/L$ 0,15 - 5,07 % 0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,23	%	0,02 $\times 10^9/L$ 0,00 - 1,36 % 0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$
Relación Neutrófilos / Linfocitos	5,11		

Observaciones

POLIMORFONUCLEARES CON GRANULACIONES GROSERAS
HIPOCROMIA LEVE
ANISOCROMIA
ANISOCITOSIS LEVE
POIQUILOCIOSIS REGULAR: ELIPTOCITOS
ROULEAUX

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA	99	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2149829
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/04/20 09:17
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 2 de 3

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6577

UREA, SANGRE

Método: Cinético UV

165

mg/dl

10 - 50 mg/dl

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

3,23

mg/dl

0,50 - 0,90 mg/dl

HEPATOGRAMA

Método: Automatizado

Colesterol Total

82

mg/dl

Deseable <200 mg/dl
Moderado 200 - 239
Alto >240

Bilirrubina Total

0,23

mg/dl

0,10 - 1,00 mg/dl

Bilirrubina Directa

0,17

mg/dl

0,01 - 0,25 mg/dl

Bilirrubina Indirecta

0,06

mg/dl

Fosfatasa Alcalina

82

UI/L

40 - 130 UI/L

TGO

27

UI/L

5 - 34 UI/L

TGP

13

UI/L

8 - 40 UI/L

Proteínas Totales

4,7

g/dl

6,0 - 8,7 g/dl

PROTEINAS TOTALES, SANGRE

Método: Colorimétrico

4,7

g/dl

6,0 - 8,7 g/dl

ALBUMINA

Método: Colorimétrico

1,8

g/dl

3,9 - 4,9 g/dl

CALCIO, SANGRE

Método: Colorimétrico

7,5

mg/dl

8,5 - 10,4 mg/dl

ca 9.26

FOSFORO, SANGRE

Método: UV

3,9

mg/dl

2,4 - 4,7 mg/dl

MAGNESIO

Método: Colorimétrico

2,28

mg/dl

1,6 - 2,55 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

179

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,6

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2149829
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/04/20 09:17
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 3 de 3

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

Cloro	139	mmol/L	90 - 110 mmol/L
-------	-----	--------	-----------------

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

))

((



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5030013
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTINEZ SUSO GUSTAVO Fecha: 20/04/20 14:33
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 11 Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito	26,0	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	7,6	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	88,7	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	10,69	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos	87,0	%	36 - 66 %
Linfocitos	10,6	%	22 - 40 %
Monocitos	1,1	%	4 - 11 %
Eosinófilos	0,9	%	1 - 5 %
Basófilos	0,4	%	0 - 1 %
Plaquetas	182,2	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RIN	3,08		0,90 - 1,20
APTT	28	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Analia Gonzalez
Bioquímica - M.N. 9052

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	109	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	172	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	3,11	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO) Método: Cinético UV	31	UI/L	5 - 34 UI/L
ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP) Método: Cinético UV	14	UI/L	8 - 40 UI/L

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905

11

12



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5030013
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTINEZ SUSO GUSTAVO Fecha: 20/04/20 14:33
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 11

Página 2 de 2

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

FOSFATASA ALCALINA

Método: Cinético Colorimétrico

87

UI/L

40 - 130 UI/L

BILIRRUBINA TOTAL

Método: Colorimétrico

0,37

mg/dl

0,10 - 1,00 mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA

Método: Colorimétrico

0,24

mg/dl

0,01 - 0,25 mg/dl

PROTEINAS TOTALES, SANGRE

Método: Colorimétrico

4,9

g/dl

6,0 - 8,7 g/dl

ALBUMINA

Método: Colorimétrico

2,0

g/dl

3,9 - 4,9 g/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

178

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,4

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

137

mmol/L

90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Analía Gonzalez
Bioquímica - M.N. 9052

Material remitido al Laboratorio

Fecha de Impresión: 20/04/2020 18:26

11

12



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2145724
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/03/20 13:47
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 1

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528

UROCULTIVO

Tipo de Muestra

Orina Recambio Sonda

Sedimento

/Escasa muestra

Examen Bacteriológico

Cultivo

Positivo

Recuento de colonias

Mayor a 100.000 U.F.C./ml

Identificación del Germen

Pseudomonas aeruginosa

ANTIBIOGRAMA

CIM Interpretación

Ceftazidima

2 µg/ml Sensible

Ciprofloxacina

0,25 µg/ml Sensible

Gentamicina

<=2 µg/ml Sensible

Piperacilina Tazobactam

<=4/4 µg/ml Sensible

Observaciones

//*Citrobacter koseri presenta Resistencia natural a las amino y carboxipenicilinas.

Identificación del Germen

Escherichia coli

ANTIBIOGRAMA

CIM Interpretación

Ampicilina

>16 µg/ml Resistente

Ampicilina Sulbactam

16/8 µg/ml Intermedio

Ceftazidima

<=1 µg/ml Sensible

Ciprofloxacina

>2 µg/ml Resistente

Gentamicina

<=2 µg/ml Sensible

Piperacilina Tazobactam

<=4/4 µg/ml Sensible

Trimetoprima Sulfametoxazol

>2/38 µg/ml Resistente

Identificación del Germen

Citrobacter koseri

ANTIBIOGRAMA

CIM Interpretación

Amoxicilina/Acido Clavulánico

<=4/2 µg/ml Sensible

Ceftazidima

<=1 µg/ml Sensible

Ciprofloxacina

<=0,125 µg/ml Sensible

Gentamicina

<=2 µg/ml Sensible

Piperacilina Tazobactam

<=4/4 µg/ml Sensible

Trimetoprima Sulfametoxazol

<=0,5/9,5 µg/ml Sensible

Resultados validados electrónicamente por:

Romina Daniela Volcovich
Bioquímica - M.N. 10140





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2146277
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/03/20 09:34
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,45	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	9,6	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	29,9	%	36,0 - 44,0 %

Índices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	86,5	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	27,8	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	32,1	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	16,2	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	270,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	7,4	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	15,6	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,200	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	5,30	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$		
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	69,60	%	3,69 $\times 10^9/L$	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	21,30	%	1,13 $\times 10^9/L$	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	6,11	%	0,32 $\times 10^9/L$	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	2,60	%	0,14 $\times 10^9/L$	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,44	%	0,02 $\times 10^9/L$	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION

25	mm	1 - 16 mm
----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	2,93	0,90 - 1,20
-----	------	-------------





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2146277
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/03/20 09:34
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

Página 2 de 3

HEMOSTASIA	Resultados		Valores de Referencia
Jefe de Sección: Luis Scigliano Bioquímico M.N. 2791			
APTT	38	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana Maria Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
Jefe de Sección: Silvia Oliveto Bioquímica M.N. 6677			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	81	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	25	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	0,81	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	108	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	0,25	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,16	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,09	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	110	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	20	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	17	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteínas Totales	5,1	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	147	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,7	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	111	mmol/L	90 - 110 mmol/L



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



119
Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943	N° Orden: 2146277
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha: 27/03/20 09:34
Origen	: INTERNADOS	CLINICA MEDICA Sala: 1 Cama: 18	Página 3 de 3

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

PROTEINA C REACTIVA (PCR)

65

mg/l

0 - 5 mg/l

Método: Inmunoturbidimetría

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

ANALISIS PENDIENTES

VANCOMICINA





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



**Buenos
Aires
Ciudad**

PACIENTE : MACHIEDO, FRANCO Edad: 25 Años F.N.: 22-11-1994 N° Orden: **5027707**
DNI : 38520300 Profesional Solicitante: VALENTI FLORENCIA Fecha: 28/03/20 13:48
Origen : GUARDIA CLINICA MEDICA Página 1 de 1

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO) Método: Cinético UV	264	UI/L	5 - 34 UI/L
ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP) Método: Cinético UV	561	UI/L	8 - 40 UI/L
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	73	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	0,38	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	0,10	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Maricel Alejandra Lugo
Bioquímica - M.N. 10466

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 28/03/2020 14:47





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CAEA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5027377
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: VALENTI FLORENCIA Fecha: 25/03/20 09:52
Origen : GUARDIA CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 1

MEDIO INTERNO

	Resultados	Valores de Referencia
--	------------	-----------------------

ESTADO ACIDO BASE

pH	7,427		7.350 a 7.450
Método: Automatizado			
pCO2	26,7	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	103	mmHg	83,0 - 108,0 mmHg
CHCO3	17,2	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-6,1	mmol/L	-3 / +3
sO2	98	%	94 - 98 %
O2Hb	96	%	80 - 97 %
Lactato	0,73	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L
Método: ISE Indirecto			

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Maricel Alejandra Lugo
Bioquímica - M.N. 10466

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 25/03/2020 10:18

CC

CC



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5027067
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTIARENA AILEN Fecha: 21/03/20 22:08
Origen : GUARDIA CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

Página 3 de 3

MEDIO INTERNO Resultados Valores de Referencia

ESTADO ACIDO BASE

pH	7,374		7.350 a 7.450
Método: Automatizado			
pCO2	14,3	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	114	mmHg	83,0 - 108,0 mmHg
cHCO3	8,1	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-13,8	mmol/L	-3 / +3
sO2	98	%	94 - 98 %
O2Hb	97	%	80 - 97 %
Lactato	1,90	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L
Método: ISE Indirecto			

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Juan Alberto Guzman
Bioquímico - M.N. 3651

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 21/03/2020 22:44



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



**Buenos
Aires
Ciudad**

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5027067
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTIARENA AILEN Fecha: 21/03/20 22:08
Origen : GUARDIA CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 2 de 3

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	85	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	0,23	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	0,14	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	2,2	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	7,8	mg/dl	8,5 - 10,4 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	124	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,9	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	89	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Juan Alberto Guzman
Bioquímico - M.N. 3651



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5027067
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTIARENA AILEN Fecha: 21/03/20 22:08
Origen : GUARDIA CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito	25,6	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	8,3	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	82,7	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	7,93	*10 ⁹ /L	3,90 - 11,10 *10 ⁹ /L
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos	87,2	%	36 - 66 %
Linfocitos	8,3	%	22 - 40 %
Monocitos	2,7	%	4 - 11 %
Eosinófilos	1,0	%	1 - 5 %
Basófilos	0,8	%	0 - 1 %
Plaquetas	181,6	*10 ⁹ /L	130,0 - 350,0 *10 ⁹ /L

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RIN	2,07		0,90 - 1,20
APTT	23	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Juan Alberto Guzman
Bioquímico - M.N. 3651

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA	247	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			
UREA, SANGRE	42	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			
CREATININA, SANGRE	1,05	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico			
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)	28	UI/L	5 - 34 UI/L
Método: Cinético UV			
ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)	16	UI/L	8 - 40 UI/L
Método: Cinético UV			



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2143847
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 13/03/20 08:46
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 1 de 3

HEMATOLOGIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos 3,76 $\cdot 10^{12}/L$ 3,88 - 4,99 $\cdot 10^{12}/L$
Hemoglobina 10,5 g/dl 11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito 33,2 % 36,0 - 44,0 %

Indices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio 88,3 fL 80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media 27,8 pg 26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media 31,5 g/dl 31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria 15,2 % 11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas 265,0 $\cdot 10^9/L$ 130,0 - 350,0 $\cdot 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio 7,7 fL 7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria 16,1 % 15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito 0,203 % 0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos 8,26 $\cdot 10^9/L$ 3,90 - 11,10 $\cdot 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria
Neutrófilos Segmentados 76,30 % 6,30 $\cdot 10^9/L$ 36,00 - 66,00 % 1,80 - 7,40 $\cdot 10^9/L$
Linfocitos 12,10 % 1,00 $\cdot 10^9/L$ 22,00 - 40,00 % 1,10 - 3,50 $\cdot 10^9/L$
Monocitos 9,57 % 0,79 $\cdot 10^9/L$ 4,00 - 11,07 % 0,21 - 0,92 $\cdot 10^9/L$
Eosinófilos 1,52 % 0,13 $\cdot 10^9/L$ 0,15 - 5,07 % 0,02 - 0,67 $\cdot 10^9/L$
Basófilos 0,42 % 0,03 $\cdot 10^9/L$ 0,00 - 1,36 % 0,00 - 0,13 $\cdot 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION 50 mm 1 - 16 mm

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN 1,22 0,90 - 1,20
Fibrinógeno 585 mg/dl 216 - 448 mg/dl



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2143847
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 13/03/20 08:46
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

Página 2 de 3

HEMOSTASIA

	Resultados	Valores de Referencia
--	------------	-----------------------

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

APTT	27 seg	21 - 34 seg
------	--------	-------------

Resultados validados electrónicamente por:

Ana María Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA

	Resultados	Valores de Referencia
--	------------	-----------------------

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	110 mg/dl	70 - 110 mg/dl
---------------------------------	-----------	----------------

UREA, SANGRE Método: Cinético UV	20 mg/dl	10 - 50 mg/dl
-------------------------------------	----------	---------------

CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	0,67 mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
--	------------	-------------------

HEPATOGRAMA
Método: Automatizado

Colesterol Total	152 mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
------------------	-----------	--

Bilirrubina Total	0,50 mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
-------------------	------------	-------------------

Bilirrubina Directa	0,21 mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
---------------------	------------	-------------------

Bilirrubina Indirecta	0,29 mg/dl	
-----------------------	------------	--

Fosfatasa Alcalina	88 UI/L	40 - 130 UI/L
--------------------	---------	---------------

TGO	15 UI/L	5 - 34 UI/L
-----	---------	-------------

TGP	10 UI/L	8 - 40 UI/L
-----	---------	-------------

Proteínas Totales	6,1 g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
-------------------	----------	----------------

PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	6,1 g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
--	----------	----------------

ALBUMINA Método: Colorimétrico	3,3 g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
-----------------------------------	----------	----------------

CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	9,0 mg/dl	8,5 - 10,4 mg/dl
---	-----------	------------------

FOSFORO, SANGRE Método: UV	4,3 mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl
-------------------------------	-----------	-----------------

1

2

3

4

5

6

7

8

9



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2143847
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 13/03/20 08:46
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18 Página 3 de 3

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

MAGNESIO

1,81

mg/dl

1,6 - 2,55 mg/dl

Método: Colorimétrico

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

141

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

4,1

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

101

mmol/L

90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2140258
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 02/03/20 09:11
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,74	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	10,3	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	33,1	%	36,0 - 44,0 %

Indices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	88,6	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	27,6	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,2	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	15,8	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	292,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	8,1	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	16,2	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,236	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	5,31	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos Segmentados	56,40	%	2,99 $\times 10^9/L$ 36,00 - 66,00 % 1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	30,40	%	1,61 $\times 10^9/L$ 22,00 - 40,00 % 1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	8,77	%	0,47 $\times 10^9/L$ 4,00 - 11,07 % 0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	3,76	%	0,20 $\times 10^9/L$ 0,15 - 5,07 % 0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,71	%	0,04 $\times 10^9/L$ 0,00 - 1,36 % 0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION

59	mm	1 - 16 mm
----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustín Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA	113	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			

UREA, SANGRE	24	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



128
**Buenos
Aires
Ciudad**

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2140258
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 02/03/20 09:11
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 2 de 2

QUIMICA CLINICA **Resultados** **Valores de Referencia**

Jefa de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

CREATININA, SANGRE 0,68 mg/dl 0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio 140 mmol/L 135 - 145 mmol/L
Potasio 4,4 mmol/L 3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro 102 mmol/L 90 - 110 mmol/L

PROTEINA C REACTIVA (PCR) 39 mg/l 0 - 5 mg/l
Método: Inmunoturbidimetría

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



129
Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943	N° Orden:	2139126
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	26/02/20 10:28
Origen	: INTERNADOS	CLINICA MEDICA	Sala: 4 Cama: 4	Página 1 de 1

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528

HISOPADO RECTAL

Cultivo:

Positivo

Observaciones

Con antecedentes previos de KPC (+)

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Amaña
Bioquímica - M.N. 9641

()

()



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2139618
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/02/20 10:23
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 1 de 2

HEMATOLOGIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,59	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	10,1	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	32,4	%	36,0 - 44,0 %

Índices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	90,3	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	28,1	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,1	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	15,8	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	292,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	8,0	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	16,1	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,233	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	5,13	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos Segmentados	59,20	% 3,04 $\times 10^9/L$	36,00 - 66,00 % 1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	25,30	% 1,30 $\times 10^9/L$	22,00 - 40,00 % 1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	10,00	% 0,51 $\times 10^9/L$	4,00 - 11,07 % 0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	4,86	% 0,25 $\times 10^9/L$	0,15 - 5,07 % 0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,56	% 0,03 $\times 10^9/L$	0,00 - 1,36 % 0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION	49	mm	1 - 16 mm
---------------------	----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustín Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

HEMOSTASIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	1,01	0,90 - 1,20
-----	------	-------------

...
...
...
...
...

...
...

...

...

...

)

)

)

)



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2139618
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/02/20 10:23
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 2 de 2

HEMOSTASIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

APTT 28 seg 21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana Maria Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA 86 mg/dl 70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE 27 mg/dl 10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE 0,69 mg/dl 0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio 137 mmol/L 135 - 145 mmol/L

Potasio 4,6 mmol/L 3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro 101 mmol/L 90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

()

()



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2137074
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 17/02/20 09:23
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,27	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	9,2	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	29,0	%	36,0 - 44,0 %

Indices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	88,7	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	28,2	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,8	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	15,9	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	200,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	7,8	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	15,5	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,156	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	5,57	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
------------	------	-----------------	------------------------------

Fórmula Leucocitaria

Neutrófilos Segmentados	59,00	%	3,29 $\times 10^9/L$	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	24,40	%	1,36 $\times 10^9/L$	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	11,00	%	0,61 $\times 10^9/L$	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	4,95	%	0,28 $\times 10^9/L$	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,64	%	0,04 $\times 10^9/L$	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION

29	mm	1 - 16 mm
----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	1,17		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	365	mg/dl	216 - 448 mg/dl

1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2137074
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 17/02/20 09:23
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 2 de 3

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

APTT 27 seg 21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustín Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA 97 mg/dl 70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE 21 mg/dl 10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE 0,63 mg/dl 0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico

HEPATOGRAMA

Método: Automatizado

Colesterol Total 161 mg/dl Deseable <200 mg/dl
Moderado 200 - 239
Alto >240

Bilirrubina Total 0,31 mg/dl 0,10 - 1,00 mg/dl

Bilirrubina Directa 0,16 mg/dl 0,01 - 0,25 mg/dl

Bilirrubina Indirecta 0,15 mg/dl

Fosfatasa Alcalina 78 UI/L 40 - 130 UI/L

TGO 18 UI/L 5 - 34 UI/L

TGP 25 UI/L 8 - 40 UI/L

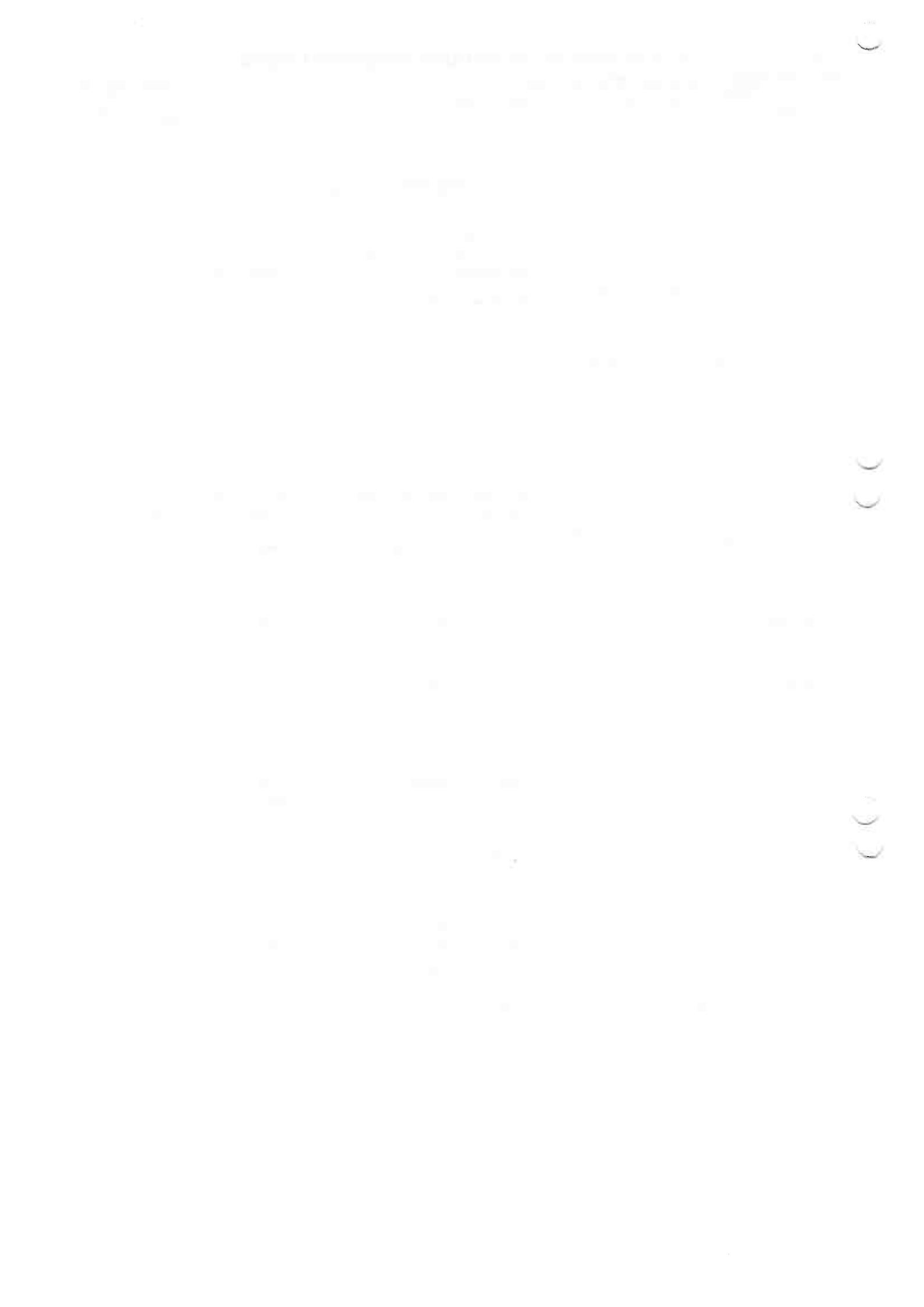
Proteínas Totales 5,8 g/dl 6,0 - 8,7 g/dl

PROTEINAS TOTALES, SANGRE 5,8 g/dl 6,0 - 8,7 g/dl
Método: Colorimétrica

ALBUMINA 3,3 g/dl 3,9 - 4,9 g/dl
Método: Colorimétrica

CALCIO, SANGRE 8,7 mg/dl 8,5 - 10,4 mg/dl
Método: Colorimétrica

FOSFORO, SANGRE 3,3 mg/dl 2,4 - 4,7 mg/dl
Método: UV





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2137074
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 17/02/20 09:23
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 3 de 3

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

MAGNESIO

Método: Colorimétrico

1,83

mg/dl

1,6 - 2,55 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

146

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

4,1

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

109

mmol/L

90 - 110 mmol/L

PROTEINA C REACTIVA (PCR)

Método: Inmunoturbidimetría

17

mg/l

0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

)

((

((



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2135161
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 10/02/20 10:29
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	3,59	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	10,3	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	32,3	%	36,0 - 44,0 %

Indices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	90,0	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	28,8	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	32,0	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	16,4	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	213,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	7,1	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	16,6	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,152	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	4,45	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos Segmentados	69,60	%	3,10 $\times 10^9/L$ 36,00 - 66,00 % 1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	19,60	%	0,87 $\times 10^9/L$ 22,00 - 40,00 % 1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	5,30	%	0,24 $\times 10^9/L$ 4,00 - 11,07 % 0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	4,58	%	0,20 $\times 10^9/L$ 0,15 - 5,07 % 0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,88	%	0,04 $\times 10^9/L$ 0,00 - 1,36 % 0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION	34	mm	1 - 16 mm
---------------------	----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	1,14		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	441	mg/dl	216 - 448 mg/dl



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2135161
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 10/02/20 10:29
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 2 de 3

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

APTT	31	seg	21 - 34 seg
------	----	-----	-------------

Resultados validados electrónicamente por:

Monica Viviana Zarfino
Bioquímica - M.N. 3402

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA

Método: Hexoquinasa

157	mg/dl	70 - 110 mg/dl
-----	-------	----------------

UREA, SANGRE

Método: Cinético UV

8	mg/dl	10 - 50 mg/dl
---	-------	---------------

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

0,57	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
------	-------	-------------------

HEPATOGRAMA

Método: Automatizado

Colesterol Total

172	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
-----	-------	--

Bilirrubina Total

0,31	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
------	-------	-------------------

Bilirrubina Directa

0,16	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
------	-------	-------------------

Bilirrubina Indirecta

0,15	mg/dl	
------	-------	--

Fosfatasa Alcalina

84	UI/L	40 - 130 UI/L
----	------	---------------

TGO

15	UI/L	5 - 34 UI/L
----	------	-------------

TGP

22	UI/L	8 - 40 UI/L
----	------	-------------

Proteínas Totales

6,0	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
-----	------	----------------

PROTEINAS TOTALES, SANGRE

Método: Colorimétrico

6,0	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
-----	------	----------------

ALBUMINA

Método: Colorimétrico

3,3	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
-----	------	----------------

CALCIO, SANGRE

Método: Colorimétrico

8,8	mg/dl	8,5 - 10,4 mg/dl
-----	-------	------------------

FOSFORO, SANGRE

Método: UV

2,7	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl
-----	-------	-----------------





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2133427
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 04/02/20 08:08
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4
Página 1 de 1

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528

HISOPADO RECTAL

Cultivo Positivo
Identificación del Germen *klebsiella pneumoniae*
Enterobacteria productora de Carbapenemasa (KPC) Positivo
Enterobacteria productora de Carbapenemasa (MBL) Negativo

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Amalfa
Bioquímica - M.N. 9641



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2132752
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 31/01/20 10:07
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	2,97	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	8,5	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	26,6	%	36,0 - 44,0 %

Índices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	89,7	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	28,5	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,8	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	16,5	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	341,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	7,8	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	16,7	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,267	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	6,11	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$		
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	72,20	%	4.41 $\times 10^9/L$	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	15,30	%	0.93 $\times 10^9/L$	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	6,41	%	0.39 $\times 10^9/L$	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	5,44	%	0.33 $\times 10^9/L$	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
asófilos	0,68	%	0.04 $\times 10^9/L$	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION

86	mm	1 - 16 mm
----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	1,26		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	717	mg/dl	216 - 448 mg/dl

))

))



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2132752
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 31/01/20 10:07
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 2 de 3

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

Resultados

Valores de Referencia

APTT	25	seg	21 - 34 seg
------	----	-----	-------------

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	99	mg/dl	70 - 110 mg/dl
---------------------------------	----	-------	----------------

UREA, SANGRE Método: Cinético UV	7	mg/dl	10 - 50 mg/dl
-------------------------------------	---	-------	---------------

CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	0,41	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
--	------	-------	-------------------

HEPATOGRAMA

Método: Automatizado

Colesterol Total	168	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	0,36	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,21	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,15	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	85	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	29	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	32	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteínas Totales	5,0	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl

PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	5,0	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
--	-----	------	----------------

ALBUMINA Método: Colorimétrico	2,8	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
-----------------------------------	-----	------	----------------

CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	8,0	mg/dl	8,5 - 10,4 mg/dl
---	-----	-------	------------------

FOSFORO, SANGRE Método: UV	2,3	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl
-------------------------------	-----	-------	-----------------

(11)

(12)



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



**Buenos
Aires
Ciudad**

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2132752
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 31/01/20 10:07
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 3 de 3

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

Resultados

Valores de Referencia

MAGNESIO

Método: Colorimétrico

1,49

mg/dl

1,6 - 2,55 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

142

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,1

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

103

mmol/L

90 - 110 mmol/L

PROTEINA C REACTIVA (PCR)

Método: Inmunoturbidimetría

154

mg/l

0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Orbes CLK

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

))

))



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2131257
DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/01/20 10:23
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado; Abbott CD Sapphire

SERIE ERITROCITARIA

Eritrocitos	2,92	$\times 10^{12}/L$	3,88 - 4,99 $\times 10^{12}/L$
Hemoglobina	8,4	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
Hematocrito	26,5	%	36,0 - 44,0 %

Índices Hematimétricos

Volumen Corpuscular Medio	90,6	fL	80,5 - 100,0 fL
Hemoglobina Corpuscular Media	28,8	pg	26,0 - 34,0 pg
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,8	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl
Amplitud de Distribución eritrocitaria	16,2	%	11,6 - 13,9 %

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas	216,0	$\times 10^9/L$	130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$
Volumen Plaquetario Medio	8,4	fL	7,6 - 11,0 fL
Amplitud de distribución plaquetaria	16,4	%	15,0 - 17,2 %
Plaquetocrito	0,181	%	0,100 - 0,600 %

SERIE LEUCOCITARIA

Leucocitos	8,65	$\times 10^9/L$	3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$
------------	------	-----------------	------------------------------

Fórmula Leucocitaria

Neutrófilos Segmentados	78,80	%	6,82 $\times 10^9/L$	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 $\times 10^9/L$
Linfocitos	10,40	%	0,90 $\times 10^9/L$	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 $\times 10^9/L$
Monocitos	4,91	%	0,42 $\times 10^9/L$	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 $\times 10^9/L$
Eosinófilos	5,27	%	0,46 $\times 10^9/L$	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 $\times 10^9/L$
Basófilos	0,57	%	0,05 $\times 10^9/L$	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 $\times 10^9/L$

ERITROSEDIMENTACION	105	mm	1 - 16 mm
---------------------	-----	----	-----------

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN	1,24	0,90 - 1,20
-----	------	-------------



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



**Buenos
Aires
Ciudad**

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** **N° Orden: 2131257**
DNI : 4214110 **Médico: Sin médico asignado** **Fecha: 27/01/20 10:23**
Origen : INTERNADOS **CLINICA MEDICA** **Sala: 4 | Cama: 4** **Página 2 de 2**

HEMOSTASIA **Resultados** **Valores de Referencia**

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

APTT **26** **seg** **21 - 34 seg**

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustín Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA **Resultados** **Valores de Referencia**

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA **83** **mg/dl** **70 - 110 mg/dl**
Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE **21** **mg/dl** **10 - 50 mg/dl**
Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE **0,44** **mg/dl** **0,50 - 0,90 mg/dl**
Método: Cinético Colorimétrico

IONOGRAMA
Método: Electrodo Ión Selectivo
Sodio **145** **mmol/L** **135 - 145 mmol/L**
Potasio **3,2** **mmol/L** **3,5 - 5,2 mmol/L**
Cloro **107** **mmol/L** **90 - 110 mmol/L**

PROTEINA C REACTIVA (PCR) **269** **mg/l** **0 - 5 mg/l**
Método: Inmunoturbidimetría

Resultados validados electrónicamente por:

Alejandro Esteban Burgos
Bioquímico - M.N. 11528

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607

1998

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607

1998

1998

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607

1998

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607

1998

1998

1998

1998



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020784
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 24/01/20 14:41
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 4 Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito

24,5

%

36,0 - 44,0 %

Hemoglobina

8,2

g/dl

11,8 - 14,8 g/dl

VCM

87,3

fL

80,5 - 100,0 fL

Leucocitos

6,17

*10⁹/L

3,90 - 11,10 *10⁹/L

Formula Leucocitaria

Neutrófilos

76,3

%

36 - 66 %

Linfocitos

12,8

%

22 - 40 %

Monocitos

9,2

%

4 - 11 %

Eosinófilos

1,3

%

1 - 5 %

Basófilos

0,4

%

0 - 1 %

Plaquetas

144,1

*10⁹/L

130,0 - 350,0 *10⁹/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020784
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 24/01/20 14:41
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 4 Página 2 de 2

MEDIO INTERNO

Resultados

Valores de Referencia

ESTADO ACIDO BASE

pH	7,377		7.350 a 7.450
Método: Automatizado			
pCO2	43,0	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	54	mmHg	83,0 - 108,0 mmHg
CHCO3	24,7	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-0,5	mmol/L	-3 / +3
sO2	86	%	94 - 98 %
O2Hb	85	%	80 - 97 %
Lactato	0,93	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L
Método: ISE Indirecto			

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136

Material remitido al Laboratorio

Fecha de Impresión: 24/01/2020 14:43



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2130509
DNI : 4214110 Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE Fecha: 23/01/20 09:57
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 1 de 5

HEMATOLOGIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

HEMOGRAMA

Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire

Observaciones

HEMOGRAMA COAGULADO

ERITROSEDIMENTACION 61 mm 1 - 16 mm

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791

COAGULOGRAMA

Método: Coagulométrico | ACL Top 300

RIN 1,15 0,90 - 1,20
Fibrinógeno 637 mg/dl 216 - 448 mg/dl
APTT 24 seg 21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana Maria Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA Resultados Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

GLUCEMIA 87 mg/dl 70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE 14 mg/dl 10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE 0,52 mg/dl 0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico

HEPATOGRAMA

Método: Automatizado

Colesterol Total 153 mg/dl Deseable <200 mg/dl
Moderado 200 - 239
Alto >240



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



146
Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2130509
DNI : 4214110 Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE Fecha: 23/01/20 09:57
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

Página 2 de 5

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

Bilirrubina Total	0,42	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,20	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,22	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	73	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	20	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	16	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteínas Totales	5,2	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ACIDO URICO, SANGRE	3,9	mg/dl	2,4 - 7,0 mg/dl
Método: Colorimétrico			
COLESTEROL TOTAL	153	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Método: Colorimétrico			
COLESTEROL HDL	66	mg/dl	40 - 100 mg/dl
Método: Directo - Colorimétrico			
COLESTEROL LDL	60	mg/dl	Deseable: Menor a 100 mg/dl Límite: 100 - 130 mg/dl Moderado: 130 - 160 mg/dl Alto: mayor a 160 mg/dl
Método: Directo - Colorimétrico			
COLESTEROL NO HDL	87	mg/dl	Deseable: Menor a 130 mg/dl Límite: 130 - 160 mg/dl Moderado: 160 - 190 mg/dl Alto: Mayor a 190 mg/dl
Método: Cálculo			
ÍNDICE DE CASTELLI (RIESGO ATEROGÉNICO)	2,3		Valor deseable: menor a 4,5
Método: Cálculo			
TRIGLICERIDOS	90	mg/dl	10 - 150 mg/dl
Método: Colorimétrico			
PROTEINAS TOTALES, SANGRE	5,2	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
Método: Colorimétrico			
FERREMIA	40	µg/dl	50 - 156 µg/dl
Método: Colorimétrico			
TRANSFERRINA	157	mg/dl	200 - 400 mg/dl
Método: Inmunoturbidimetría			
% DE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA	20	%	15 - 45 %
Método: Inmunoturbidimetría			

CC

CC



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2130509
DNI : 4214110 Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE Fecha: 23/01/20 09:57
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 3 de 5

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

ALBUMINA

Método: Colorimétrico

2,9

g/dl

3,9 - 4,9 g/dl

CALCIO, SANGRE

Método: Colorimétrico

8,0

mg/dl

8.5 - 10.4 mg/dl

FOSFORO, SANGRE

Método: UV

2,2

mg/dl

2,4 - 4,7 mg/dl

MAGNESIO

Método: Colorimétrico

1,86

mg/dl

1,6 - 2,55 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

146

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,5

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

108

mmol/L

90 - 110 mmol/L

PROTEINA C REACTIVA (PCR)

Método: Inmunoturbidimetría

148

mg/l

0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

HORMONAS TIROIDEAS

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

TIROTROFINA (TSH)

Método: ECLIA

3,14

µUI/ml

0,27 - 5,00 µUI/ml

TIROXINA LIBRE (T4L)

Método: ECLIA

1,20

ng/dl

0,9 - 1,7 ng/dl

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607



Vol. 52



1

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1935

CONTENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2130509
DNI : 4214110 Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE Fecha: 23/01/20 09:57
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 4 de 5

ENDOCRINOLOGÍA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

25-HIDROXICOLECALCIFEROL - VITAMINA D3

30,67 ng/mL

Valor deseable: 30 - 100 ng/ml

Hipovitaminosis : 20- 29 ng/mL

Insuficiencia: <20 ng/ml

Método: ECLIA

Resultados validados electrónicamente por:

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquímico - M.N. 10168

SEROLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

VDRL

No Reactivo

No reactiva

Método: Floculación

CHAGAS

No Reactivo

Método: Hemoaglutinación Indirecta

CHAGAS

No Reactivo

Método: Electroquimioluminiscencia

Resultados validados electrónicamente por:

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquímico - M.N. 10168

MARCADORES VIRALES

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IgG

51,0 UI/mL

Reactivo: > 30,5 UI/ml

Indeterminado: 1,0 y <30,0 UI/ml

No Reactivo: <1,0 UI/ml

Método: ECLIA

TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IgM

No Reactivo

Reactivo: >1,0

Método: ECLIA

HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBs Ag)

No Reactivo

Interpretación:
Mayor a 1 REACTIVO

Método: ECLIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST 57TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10022



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



149
Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 2130509
DNI : 4214110 Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE Fecha: 23/01/20 09:57
Origen : INTERNADOS CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4 Página 5 de 5

MARCADORES VIRALES

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

HEPATITIS C, ANTICUERPOS

No Reactivo

Interpretación:
Mayor a 1 REACTIVO

Método: ECLIA

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquímico - M.N. 10168

VITAMINAS

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

VITAMINA B12

465,10 pg/ml

197 - 771 pg/mL

Método: ECLIA

ACIDO FOLICO

16,58 ng/ml

3,89 - 26,80 ng/mL

Método: ECLIA

Resultados validados electrónicamente por:

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquímico - M.N. 10168



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



180
Buenos
Aires
Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	: FMAKU12051943	Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943	N° Orden:	2130509
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE	Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: INTERNADOS	CLINICA MEDICA	Sala: 4 Cama: 4	Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE HIV

Resultados

Valores de Referencia

Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677

ANTICUERPOS ANTI HIV

Método: ECLIA - Ensayo de 4ta generacion.

El ensayo detecta en forma conjunta Ac. contra el virus de HIV I/II y Antígeno P24.

Resultado:

No Reactivo

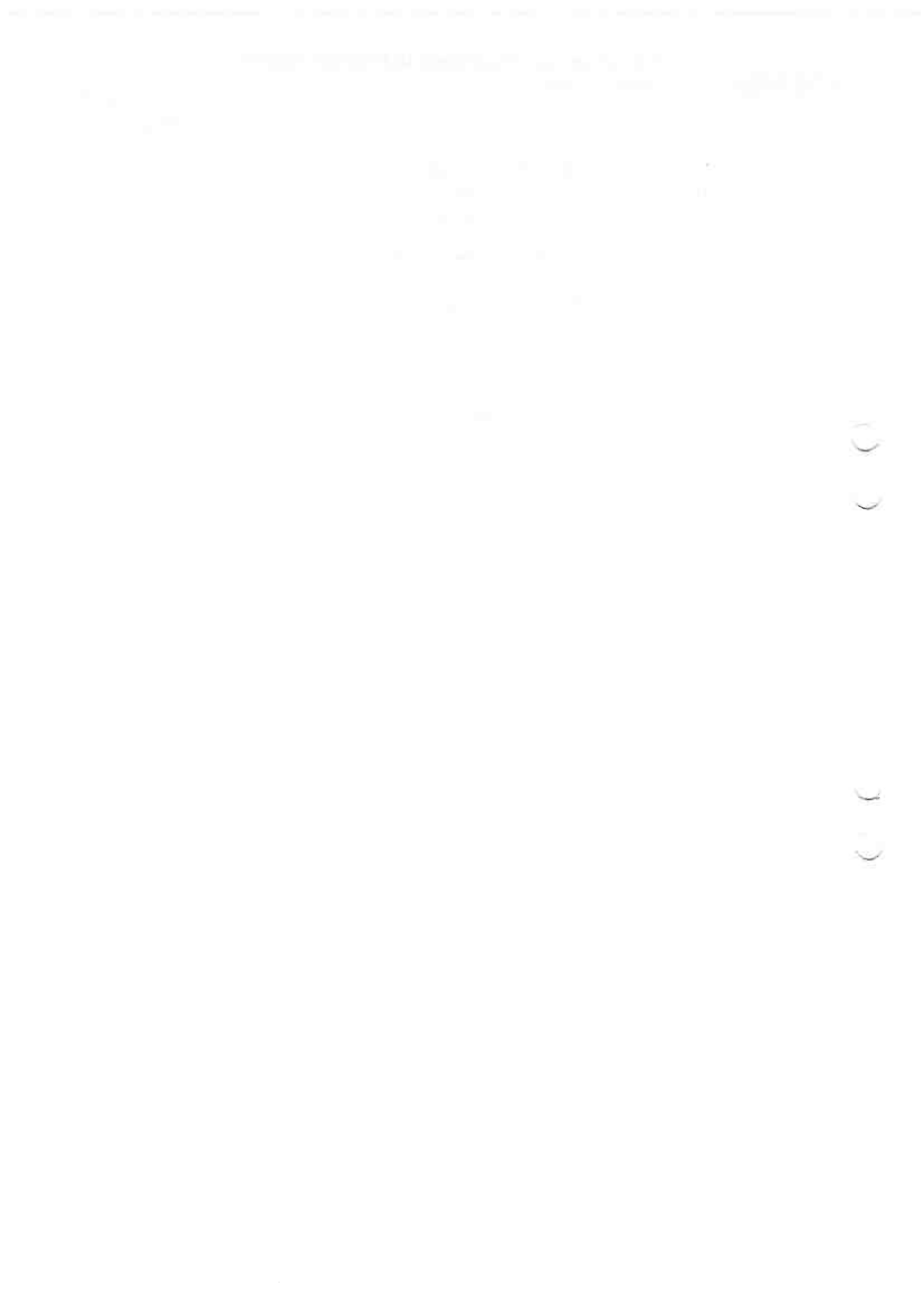
Interpretación:

Menor a 1: No Reactivo

Mayor o igual a 1: Reactivo

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020579
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 22/01/20 09:41
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito	28,6	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	9,0	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	89,1	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	8,38	*10 ⁹ /L	3,90 - 11,10 *10 ⁹ /L
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos	74,1	%	36 - 66 %
Infocitos	12,3	%	22 - 40 %
Monocitos	10,7	%	4 - 11 %
Eosinófilos	2,2	%	1 - 5 %
Basófilos	0,7	%	0 - 1 %
Plaquetas	160,8	*10 ⁹ /L	130,0 - 350,0 *10 ⁹ /L

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RIN	1,51		0,90 - 1,20
APTT	30	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lilian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA

Método: Hexoquinasa

103 mg/dl 70 - 110 mg/dl

UREA, SANGRE

Método: Cinético UV

18 mg/dl 10 - 50 mg/dl

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

0,50 mg/dl 0,50 - 0,90 mg/dl

ASPARTATO-AMINO-TRANSFERASA (TGO)

Método: Cinético UV

23 UI/L 5 - 34 UI/L

ALANINO-AMINO-TRANSFERASA (TGP)

Método: Cinético UV

15 UI/L 8 - 40 UI/L

UREA, SANGRE

Método: Cinético UV



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020579
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 22/01/20 09:41
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 2 de 3

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	73	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	0,41	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	0,17	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	141	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,8	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	104	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lilian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020579
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 22/01/20 09:41
Origen: GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 3 de 3

MEDIO INTERNO

Resultados

Valores de Referencia

ESTADO ACIDO BASE

pH	7,392		7,350 a 7,450
Método: Automatizado			
pCO ₂	41,2	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO ₂	77	mmHg	83,0 - 108,0 mmHg
CHCO ₃	24,5	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-0,4	mmol/L	-3 / +3
iO ₂	96	%	94 - 98 %
iO ₂ Hb	95	%	80 - 97 %
Lactato	1,41	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L
Método: ISE Indirecto			

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lillian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991

Material remitido al Laboratorio

Fecha de Impresión: 22/01/2020 11:31

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020498
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 21/01/20 10:31
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 1 de 3

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito

31,7 %

36,0 - 44,0 %

Hemoglobina

10,0 g/dl

11,8 - 14,8 g/dl

VCM

88,5 fL

80,5 - 100,0 fL

Leucocitos

14,10 $\times 10^9/L$

3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$

Fórmula Leucocitaria

Neutrófilos

83,7 %

36 - 66 %

Linfocitos

7,6 %

22 - 40 %

Monocitos

8,3 %

4 - 11 %

Eosinófilos

0,1 %

1 - 5 %

Basófilos

0,3 %

0 - 1 %

Plaquetas

198,0 $\times 10^9/L$

130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RIN

Muestra mal enrasada.

0,90 - 1,20

APTT

Muestra mal enrasada.

21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136

QUÍMICA CLÍNICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA

117 mg/dl

70 - 110 mg/dl

Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE

18 mg/dl

10 - 50 mg/dl

Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE

0,55 mg/dl

0,50 - 0,90 mg/dl

Método: Cinético Colorimétrico

ASPARTATO AMINO-TRANSFERASA (TGO)

31 UI/L

5 - 34 UI/L

Método: Cinético UV

ALANINO AMINO-TRANSFERASA (TGP)

17 UI/L

8 - 40 UI/L

Método: Cinético UV

FOSFATASA ALCALINA

79 UI/L

40 - 130 UI/L

Método: Cinético Colorimétrico

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020498
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 21/01/20 10:31
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS mmol/L Página 2 de 3

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

BILIRRUBINA TOTAL

Método: Colorimétrico

0,42

mg/dl

0,10 - 1,00 mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA

Método: Colorimétrico

0,19

mg/dl

0,01 - 0,25 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

140

mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,9

mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

102

mmol/L

90 - 110 mmol/L

CK TOTAL

Método: Cinético UV

542

UI/L

24 - 190 UI/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR

Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943

N° Orden: 5020498

DNI: 4214110

Profesional Solicitante: Sin médico asignado

Fecha: 21/01/20 10:31

Origen: GUARDIA

GUARDIA INTERNADOS

Página 3 de 3

MEDIO INTERNO

Resultados

Valores de Referencia

ESTADO ACIDO BASE

pH	7,425		7.350 a 7.450
Método: Automatizado			
pCO2	39,0	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	72	mmHg	83.0 - 108.0 mmHg
CHCO3	25,0	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	0,7	mmol/L	-3 / +3
CO2	96	%	94 - 98 %
O2Hb	95	%	80 - 97 %
Lactato	1,75	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L
Método: ISE Indirecto			

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 21/01/2020 11:22



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR

Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943

N° Orden: 5020396

DNI : 4214110

Profesional Solicitante: Sin médico asignado

Fecha: 20/01/20 10:28

Origen : GUARDIA

GUARDIA INTERNADOS

Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito

33,2 %

36,0 - 44,0 %

Hemoglobina

10,5 g/dl

11,8 - 14,8 g/dl

VCM

88,0 fL

80,5 - 100,0 fL

Leucocitos

7,80 *10⁹/L

3,90 - 11,10 *10⁹/L

Formula Leucocitaria

Neutrófilos

70,0 %

36 - 66 %

Linfocitos : GUARDIA

16,4 %

22 - 40 %

Monocitos

11,4 %

4 - 11 %

Eosinófilos

1,5 %

1 - 5 %

Basófilos

0,7 %

0 - 1 %

Plaquetas

198,1 *10⁹/L

130,0 - 350,0 *10⁹/L

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RIN

7,96

0,90 - 1,20

Leucocitos

remitir nueva muestra par
confirmar coagulograma

Formula Leucocitaria

Neutrófilos

52 seg

21 - 34 seg

Linfocitos : GUARDIA

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lilian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA

101

mg/dl

70 - 110 mg/dl

Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE

19

mg/dl

10 - 50 mg/dl

Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE

0,63

mg/dl

0,50 - 0,90 mg/dl

Método: Cinético Colorimétrico

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)

25

UI/L

5 - 34 UI/L

Método: Cinético UV

ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)

15

UI/L

8 - 40 UI/L

Método: Cinético UV

UREA, SANGRE



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020396
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 20/01/20 10:28
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 2 de 2

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	91	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	0,24	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	0,10	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	143	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	4,1	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	105	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lilian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 20/01/2020 17



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020350
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: DIEZ BELTRAN JUAN CRUZ Fecha: 19/01/20 21:44
Origen : GUARDIA GUARDIA EXTERNOS Página 2 de 2

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

BILIRRUBINA TOTAL

Método: Colorimétrico

Muestra Hemolizada

0,10 - 1,00 mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA

Método: Colorimétrico

Muestra Hemolizada

0,01 - 0,25 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

Muestra Hemolizada

135 - 145 mmol/L

Potasio

Muestra Hemolizada

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

Muestra Hemolizada

90 - 110 mmol/L

AMILASA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

Muestra Hemolizada

0 - 125 UI/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Marisa Rodríguez
Bioquímica - M.N. 8847

ANALISIS DE ORINA

Resultados

Valores de Referencia

SEDIMENTO URINARIO

Células

Escasa cantidad

Leucocitos

2-3 por campo

Hematíes

6-10 por campo

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Marisa Rodríguez
Bioquímica - M.N. 8847

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 19/01/2020 22:25



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5020350
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: DIEZ BELTRAN JUAN CRUZ Fecha: 19/01/20 21:44
Origen : GUARDIA GUARDIA EXTERNOS

Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito

30,1

%

36,0 - 44,0 %

Hemoglobina

10,0

g/dl

11,8 - 14,8 g/dl

VCM

86,8

fL

80,5 - 100,0 fL

Leucocitos

5,22

*10⁹/L

3,90 - 11,10 *10⁹/L

Paciente: KUCHASKY, I.

Formula Leucocitaria

Neutrófilos

53,5

%

36 - 66 %

Linfocitos

33,3

%

22 - 40 %

Monocitos

9,9

%

4 - 11 %

Eosinófilos

2,4

%

1 - 5 %

Basófilos

0,9

%

0 - 1 %

Plaquetas

219,7

*10⁹/L

130,0 - 350,0 *10⁹/L

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RIN

Muestra Hemolizada

0,90 - 1,20

APTT

Muestra Hemolizada

21 - 34 seg

Paciente: KUCHASKY, I.

Formula Leucocitaria

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Marisa Rodriguez
Bioquímica - M.N. 8847

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA

96

mg/dl

70 - 110 mg/dl

Método: Hexoquinasa

UREA, SANGRE

30

mg/dl

10 - 50 mg/dl

Método: Cinético UV

CREATININA, SANGRE

0,81

mg/dl

0,50 - 0,90 mg/dl

Método: Cinético Colorimétrico

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)

Muestra Hemolizada

5 - 34 UI/L

Método: Cinético UV

ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)

Muestra Hemolizada

8 - 40 UI/L

Método: Cinético UV

FOSFATASA ALCALINA

Muestra Hemolizada

40 - 130 UI/L

Método: Cinético Colorimétrico

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

Hospital General de Agudos Parmenio Piñero

Guardia Externa

Evaluación pre-hospitalaria:

Fecha de ingreso: 27/12/19 Hora de ingreso: _____
Traído de: domicilio / vía pública, _____

Nombre completo: CUCRAS KY MARCELA Nacionalidad: _____
Fecha de nac: _____ Edad: 76 DNI: _____
Obra social: SI NO, DAMI

Intervención policial: SI / NO, _____
Accidente de tránsito: SI / NO, _____
Accidente laboral: SI / NO, _____

Motivo de consulta: SIND ROMFUSIONAL AFU DO
Antecedentes de enfermedad actual: FIEBRE

Antecedentes patológicos: _____
GASTRITIS ESCULOPROM.
ARTROSIS TUP. ESPANA DE CAYENA

Examen físico:
TA: 110/50 FC: _____ FR: 16 SaO2%: 92 Temp: 40°
Cardio: 100 Respiratorio: normal
Abdomen: SI / NO Neuro: Confusion

Medicación habitual: PAINUS, CALMADOR.
ROASTINUS, CA, SERRON, PREEM.
QUEMINS

Médico tratante: _____ Firma y sello: _____


DEPARTAMENTO DE MEDICINA
M.N. 107543



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5017936
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: ESPINEL CESAR Fecha: 27/12/19 09:28
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 2 de 2

QUIMICA CLINICA

	Resultados		Valores de Referencia
--	------------	--	-----------------------

FOSFATASA ALCALINA
Método: Cinético Colorimétrico

97 UI/L

40 - 130 UI/L

BILIRRUBINA TOTAL
Método: Colorimétrico

0,31 mg/dl

0,10 - 1,00 mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA
Método: Colorimétrico

0,09 mg/dl

0,01 - 0,25 mg/dl

IONOGRAMA

Método: Electrodo Ión Selectivo

Sodio

143 mmol/L

135 - 145 mmol/L

Potasio

3,3 mmol/L

3,5 - 5,2 mmol/L

Cloro

103 mmol/L

90 - 110 mmol/L

AMILASA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

142 UI/L

0 - 125 UI/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bióquímico - M.N. 12136

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 27/12/2019 10:30

Serum 4g.

Lo y M^o 0
resto de los días 1/2



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Zallester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5017936
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: ESPINEL CESAR Fecha: 27/12/19 09:28
Origen : GUARDIA GUARDIA INTERNADOS Página 1 de 2

HEMATOLOGIA

Resultados

Valores de Referencia

HEMOGRAMA

Método: Automatizado

Hematocrito

34,8

%

36,0 - 44,0 %

Hemoglobina

10,9

g/dl

11,8 - 14,8 g/dl

VCM

90,3

fL

80,5 - 100,0 fL

Leucocitos

14,48

$\times 10^9/L$

3,90 - 11,10 $\times 10^9/L$

Fórmula Leucocitaria

Neutrófilos

90,7

%

36 - 66 %

Linfocitos

2,9

%

22 - 40 %

Monocitos

5,7

%

4 - 11 %

Eosinófilos

0,4

%

1 - 5 %

Basófilos

0,3

%

0 - 1 %

Plaquetas

191,1

$\times 10^9/L$

130,0 - 350,0 $\times 10^9/L$

COAGULOGRAMA

Método: Automatizado

RV

3,90

0,90 - 1,20

APTT

37

seg

21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136

QUIMICA CLINICA

Resultados

Valores de Referencia

GLUCEMIA

Método: Hexoquinasa

117

mg/dl

70 - 110 mg/dl

UREA, SANGRE

Método: Cinético UV

27

mg/dl

10 - 50 mg/dl

CREATININA, SANGRE

Método: Cinético Colorimétrico

0,79

mg/dl

0,50 - 0,90 mg/dl

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)

Método: Cinético UV

22

UI/L

5 - 34 UI/L

ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)

Método: Cinético UV

22

UI/L

8 - 40 UI/L



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695



Buenos
Aires
Ciudad

PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA LEONOR Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943 N° Orden: 5017963
DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 27/12/19 11:39
Origen : GUARDIA GUARDIA EXTERNOS Página 1 de 1

ANALISIS DE ORINA

Resultados

Valores de Referencia

SEDIMENTO URINARIO

Cellulas	regular
Leucocitos	2-3
Hematies	2-3

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Laura Rivera
Bioquímica - M.N. 7381

Materia remitiendo al Laboratorio

Fecha de impresión: 27/12/2019 14:39

BRONCOPNEUMOPATIA
IZQUIERDA

(()

(()

Hospital General de Agudos Parmenio Piñero

Guardia Externa

Evaluacion pre-hospitalaria:

Fecha de ingreso: 19 / 01 / 2020

Hora de ingreso:

Traido de: domicilio / via publica, Motel 610

Nombre completo: Kuchas Ky Margarita

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nac: 12/05/1943

Edad: 76

DNI:

Obra social: SI / NO, PAMI

4,214,110

Intervencion policial: SI / NO,

Accidente de transito: SI / NO,

Accidente laboral: SI / NO,

Motivo de consulta:

Dolor abdominal

Antecedentes de enfermedad actual:

Antecedencia ser

Cuadro clinico de 12 horas de evolucion
dolor abdominal a nivel de epigastrio
regurgitacion con irradiacion a region
do. 19

Antecedentes patológicos:

Antecedencia ser

Examen fisico:

TA: 120/70 FC: 90

FR: 22

SaO2%:

98%

Temp:

37

Cardio: Ruidos cardiacos nrm

Respiratorio:

Buen ventil

Abdomen: Doloroso

Neuro:

Regurgitacion

Medicacion habitual:

Medico tratante:

[Firma]

Firma y sello:

German Gonzalez
Medico
M.N. 165.371

HOSPITAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA

162

AV. VARELA 1307 TEL/ FAX: 4633 - 0224

TOMO IMAGO S.A.

Nº DE ESTUDIO :	163906	FECHA:	21/01/2020
PACIENTE :	KUCHASKY, MARGARITA	Nº AFILIADO :	
COBERTURA :	GCBA	SERVICIO:	GUARDIA
MEDICO SOLICITANTE :	DEGLIUMINI, CAROLINA		
HOSPITAL DERIVANTE :	PIÑERO		

Se ha realizado una Tomografía Computada Multicorte de Tórax sin contraste.

INFORME:

No se observan adenomegalias axilares, hiliares ni mediastinales.
Mediastino centrado, de configuración vascular habitual.
Área cardíaca conservada.
No se observa derrame pericárdico.
Voluminosa hernia hiatal.
Escaso derrame pleural izquierdo laminar.
Los cortes con ventana de pulmón muestran opacidades subpleurales y acentuación de la trama intersticial a nivel de los segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores, de probable origen pasivo congestivo.
Abdomen superior sin particularidades.

AP/RMR

Rafael Morey Rios
Especialista en
Diagnóstico por Imágenes
M.N. 122.644



163

HOSPITAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA

AV. VARELA 1307 TEL/ FAX: 4633 - 0224

TOMO IMAGO S.A.

Nº DE ESTUDIO : 163856
PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA
COBERTURA : GCBA
MEDICO SOLICITANTE : DIEZ BELTRAN, JUAN CRUZ
HOSPITAL DERIVANTE : PIÑERO

FECHA: 20/01/2020

Nº AFILIADO :
SERVICIO: GUARDIA

Se ha realizado una Tomografía Computada Multicorte de Cerebro sin contraste.

INFORME:

Signos involutivos a nivel central y cortical.
Línea media centrada.
Hipodensidad de la sustancia blanca periventricular y profunda. Lesiones de aspecto secuelar.
No se observan colecciones extra axiales.
Se sugiere control en tiempo diferido

JG/ AM

DR. JOSE ATILIO MENDEZ
MEDICO - M.N. 85.072
JEFE DE SERVICIO TCM

163 148

HOSPITAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA

AV. VARELA 1307 TEL/ FAX: 4633 - 0224

TOMO IMAGO S.A.

N° DE ESTUDIO : 163856
PACIENTE : KUCHASKY, MARGARITA
COBERTURA : GCBA
MEDICO SOLICITANTE : DIEZ BELTRAN, JUAN CRUZ
HOSPITAL DERIVANTE : PIÑERO

FECHA: 20/01/2020

N° AFILIADO :
SERVICIO: GUARDIA

Se ha realizado una Tomografía Computada Multicorte de Cerebro sin contraste.

INFORME:

Signos involutivos a nivel central y cortical.
Línea media centrada.
Hipodensidad de la sustancia blanca periventricular y profunda. Lesiones de aspecto secuear.
No se observan colecciones extra axiales.
Se sugiere control en tiempo diferido

JG/ AM


DR. JOSE ATILES
MEDICO - M.C.
JEFE DE SERVICIO

1691

ID 2001220000 10 mm/mv 0.05 sec-25Hz AC 50Hz 25mm/s 2020-01-12 02:51



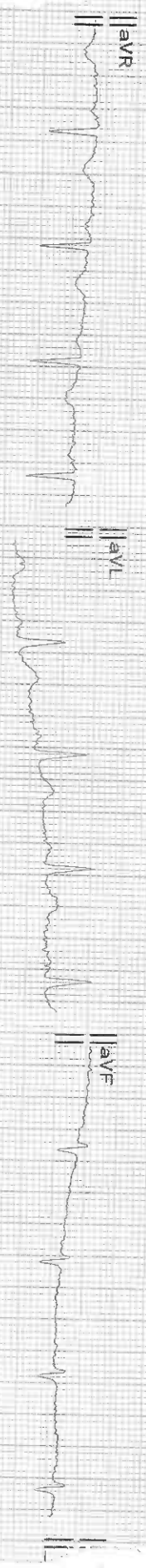
Margarita Kucharsky
UH CH

22/01/20

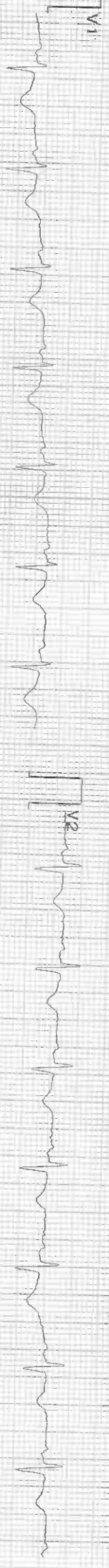
84 HOSPITAL

DOCTOR

Diagnóstico para la referencia Confirmed Bv:



2001220000 10 mm/mv 0.05Hz-25Hz AC 50Hz 25mm/s 2020-01-12 2001220000 10 mm/mv 0.05Hz-25Hz AC 50Hz 25mm/s 2020-01-12



81 HOSPITAL

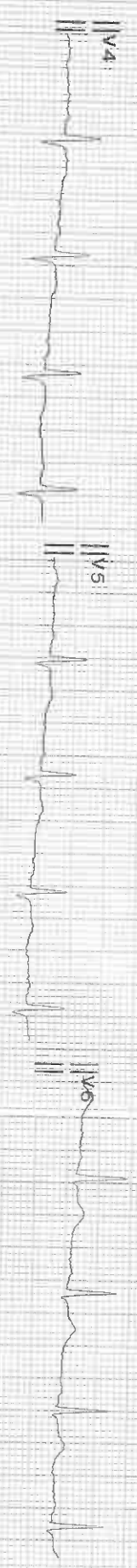
DOCTOR

Diagnóstico para

83 HOSPITAL

DOCTOR

Diagnóstico para la





HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA



**Buenos
Aires
Ciudad**

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	: CUENCA, LUIS RAMON	Edad: 49 Años F.N.: 15-09-1970	N° Orden: 2125603
DNI	: 21791445	Médico: Sin médico asignado	Fecha: 06/01/20 11:29
Origen	: INTERNADOS	CLINICA MEDICA	Sala: 4 Cama: 8

Página 1 de 1

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528

HISOPADO RECTAL

Cultivo **Negativo**

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Amalfa
Bioquímica - M.N. 9641

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Resolución 0356/MSGC/09 - Ley N° 153 - Decretos N° 208/01 y N° 2316/03

H. Clínica N°

165

D M A

3 2 20

HOSPITAL: GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"

Datos del paciente

A Nombre y apellido: MARGARITA LEONOR KUCHASKY

Documento de Identidad: DNI 4214110

LEER CON ATENCION

Este formulario contiene la información que suministra al médico sobre el estado de salud del paciente (el diagnóstico presunto o de certeza), el tratamiento que se aconseja o indica y los beneficios buscados; los riesgos que presenta este tratamiento, algún otro tratamiento o ningún tratamiento; finalmente la aceptación de la propuesta y su autorización para llevarlo a cabo o su rechazo. El presente formulario será firmado por el paciente, si no pudiera, el pariente más cercano o persona autorizada. En el reverso se encuentran las instrucciones para completar los espacios.

B Diagnóstico:

ITU

C Tratamiento y/o práctica propuestos:

ACCESO VENOSO CENTRAL: ES EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE COLOCA UN CATETER EN UNA VENA PARA MEDIR LA PRESION EN EL CORAZON

D Beneficios buscados:

BUENA EVOLUCION CLINICA DEL PACIENTE. PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

E Riesgos típicos del tratamiento o práctica propuestos:

HEMORRAGIAS, INFECCION, NEUMOTORAX (ENTRADA DE AIRE EN LA PLEURA DEL PULMON)

F Alternativas al tratamiento o práctica propuestos:

G Manifestación de aceptación o rechazo: HE COMPRENDIDO LA EXPLICACION Y ACEPTO-
RECHAZO EL TRATAMIENTO (tachar lo que no corresponde).

Firma y Aclaración:

H Observaciones y preguntas:

PACIENTE CON INTERCUB. JADA LA NECESIDAD
X EVR EN UC @ LINGUAGS Y SIN COMPLICACIONES, ES DE CARACTER
INTERMITENTE LA COAGULACION DE LA VENA CENTRAL DATA
OPTIMIZACION DE CVD.

I Firmas : (aclarando nombre y apellido):

Paciente o Familiar

Testigo-DNI

Médico del equipo Tratante
N° de Matricula

Jefe de Servicio
N° de Matricula

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS ESPACIOS DE ESTE FORMULARIO

La confección del presente formulario quedará cumplida con las firmas de los intervinientes

Para el médico tratante:

- 1 Deberá escribir con letra clara todos los espacios, consignando en B diagnóstico los datos patológicos relevantes disponibles relacionados con su diagnóstico y tratamiento.
Si Utiliza abreviaturas, deberá aclararlas; las enmiendas o raspaduras, deberán ser salvadas.
- 2 Indicará el procedimiento diagnóstico o terapéutico de elección.
- 3 Deberá ofrecer las alternativas diagnósticas o terapéuticas, a las afecciones que padece el paciente.
- 4 Describirá los riesgos típicos del procedimiento propuesto y las consecuencias seguras. Se autoriza a agregar anexo con las posibles complicaciones u otros riesgos, en cuyo caso se hará constar su inclusión en el punto E).
- 5 Contestará todas las preguntas que el paciente formule, en caso de no haber ninguna, escribirá NINGUNA.
- 6 Dejará asentado en la Historia Clínica que se firmó el Consentimiento Informado, y que se adjunta.
- 7 En caso de no confeccionarse el Consentimiento Informado por negativa del paciente, lo dejará asentado en la Historia Clínica (según indican los Decretos Nro. 208/2001 y Nro. 2316/2033).

Para el paciente o autorizante:

- 1 Tiene el derecho a preguntar todas las características de la afección y de los tratamientos que se consideran en esta ocasión. De no haber pedidos de aclaración, se considera que entiende completamente de que se trata.
- 2 Si ha comprendido toda la explicación de la práctica, los riesgos y sus tratamientos, se deberá tachar lo que no corresponda (ACEPTO o RECHAZO), firmando y aclarando firma.
- 3 Deberá firmar y aclarar su nombre, presentando su documento al médico, ante la manifestación de no poseerlo se le tomará impresión dígito pulgar.

Para el Jefe de Servicio:

- 1 Deberá observar que se cumpla con el procedimiento indicado para este formulario.
- 2 Constatará que el formulario haya sido adjuntado a la Historia Clínica correspondiente.

OBSERVACIONES FINALES (exclusivo para el Jefe de Servicio)

Fecha:

Jefe de Servicio:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO T. PIÑERO

QUIRÓFANO CENTRAL

FECHA: 27/01/20 H.C./DNI: 41691
PACIENTE: Kuchsky
UNIDAD: 4 CAMA: 4 LOCAL:
INTERVENCION QUIRURGICA: Colocacion de Vis Central

	PAQUETES	CANTIDAD	TOTAL
GASAS DOBLADILLADAS	/	/	/
GASAS CARTERITAS	1	x 30	30
COMPRESAS	/	/	/

CONTEO: AGUJAS

SI

NO

INSTRUMENTAL

SI

NO

OBSERVACIONES: Agujas (SI) Repas (Desconoce),
Instrumentos (revisados (Desconoce)), Medicacion
diaria (SI), Consentimiento (SI)

MARIA SOL KRANSKI

CIRUJANO

INSTRUMENTADOR/A

YANINA N. GOMEZ
INST. QUIRURGICA
MAY 06/08 M.P. 174720

CIRCULANTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Resolución 0356/MSGC/09 - Ley N° 153 - Decretos N° 208/01 y N° 2316/03

D M A

27 1 20

HOSPITAL: GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"

Datos del paciente

A Nombre y apellido: MARGARITA LEONOR KUCHASKY

Documento de Identidad: DNI 4214110

LEER CON ATENCION

Este formulario contiene la información que suministra al médico sobre el estado de salud del paciente (el diagnóstico presunto o de certeza), el tratamiento que se aconseja o indica y los beneficios buscados; los riesgos que presenta este tratamiento, algún otro tratamiento o ningún tratamiento; finalmente la aceptación de la propuesta y su autorización para llevarlo a cabo o su rechazo. El presente formulario será firmado por el paciente, si no pudiera, el pariente más cercano o persona autorizada. En el reverso se encuentran las instrucciones para completar los espacios.

B Diagnóstico:

Neumonía de mecanismo broncoaspirativo

C Tratamiento y/o práctica propuestos:

ACCESO VENOSO CENTRAL: ES EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE COLOCA UN CATETER EN UNA VENA PARA MEDIR LA PRESION EN EL CORAZON

D Beneficios buscados:

BUENA EVOLUCION CLINICA DEL PACIENTE. PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

E Riesgos típicos del tratamiento o práctica propuestos:

HEMORRAGIAS, INFECCION, NEUMOTORAX (ENTRADA DE AIRE EN LA PLEURA DEL PULMON)

F Alternativas al tratamiento o práctica propuestos:

ninguna.

G Manifestación de aceptación o rechazo: HE COMPRENDIDO LA EXPLICACION Y ACEPTO-RECHAZO EL TRATAMIENTO (tachar lo que no corresponde).

Firma y Aclaración:

H Observaciones y preguntas:

PACIENTE CON HISTORIA DE LA NEUMONIA Y RESPOSTA
A LOS TRATAMIENTOS, ES DE CARACTER INTERMITENTE LA COLECCION
DE AIRE EN EL ESPACIO CENTRAL PARA OPTIMIZACION DE GASTATIBEROS.

I Firmas : (aclarando nombre y apellido):

Paciente o Familiar

Testigo-DNI

Médico del equipo Tratante
N° de Matrícula

Jefe de Servicio
N° de Matrícula

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS ESPACIOS DE ESTE FORMULARIO

La confección del presente formulario quedará cumplida con las firmas de los intervinientes

Para el médico tratante:

- 1 Deberá escribir con letra clara todos los espacios, consignando en B diagnóstico los datos patológicos relevantes disponibles relacionados con su diagnóstico y tratamiento.
Si Utiliza abreviaturas, deberá aclararlas; las enmiendas o raspaduras, deberán ser salvadas.
- 2 Indicará el procedimiento diagnóstico o terapéutico de elección.
- 3 Deberá ofrecer las alternativas diagnósticas o terapéuticas, a las afecciones que padece el paciente.
- 4 Describirá los riesgos típicos del procedimiento propuesto y las consecuencias seguras. Se autoriza a agregar anexo con las posibles complicaciones u otros riesgos, en cuyo caso se hará constar su inclusión en el punto E).
- 5 Contestará todas las preguntas que el paciente formule, en caso de no haber ninguna, escribirá NINGUNA.
- 6 Dejará asentado en la Historia Clínica que se firmó el Consentimiento Informado, y que se adjunta.
- 7 En caso de no confeccionarse el Consentimiento Informado por negativa del paciente, lo dejará asentado en la Historia Clínica (según indican los Decretos Nro. 208/2001 y Nro. 2316/2033).

Para el paciente o autorizante:

- 1 Tiene el derecho a preguntar todas las características de la afección y de los tratamientos que se consideran en esta ocasión. Si no haber pedidos de aclaración, se considera que entiende completamente de que se trata.
- 2 Si ha comprendido toda la explicación de la práctica, los riesgos y sus tratamientos, se deberá tachar lo que no corresponda (ACEPTO o RECHAZO), firmando y aclarando firma.
- 3 Deberá firmar y aclarar su nombre, presentando su documento al médico, ante la manifestación de no poseerlo se le tomará impresión dígito pulgar.

Para el Jefe de Servicio:

- 1 Deberá observar que se cumpla con el procedimiento indicado para este formulario.
- 2 Constatará que el formulario haya sido adjuntado a la Historia Clínica correspondiente.

OBSERVACIONES FINALES (exclusivo para el Jefe de Servicio)

Fecha:

Jefe de Servicio:

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45°
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 11) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

(Dosis 22 hs - Quetiapina 37,5 mg)

(clobetasol)

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M. N. 86674
HOSP. GEN. AGUDOS P. PIÑERO

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45°
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 11) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS) *
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

13) x. fuehopino de las 22 horas 37,5 ref 1.000

DR. GONZALO GARCIA
Médico Clínico Generalista
Firma

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNAR FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45°
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA



DR. COPANI JORGE MARCELO
M. N. 8674
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

23hr
13) talofenidol 1 amp 5ml 1 vez


Florencia
M. N. 15713
U. B. A.

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45º
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

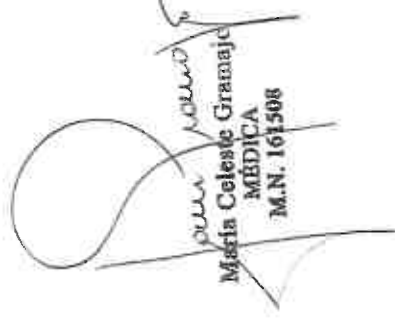

Dr. CORRAL JORGE MARCELO
Médico Clínico - Dermatología

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 454 CAMA: 4 FECHA: 02/03/2020 Y 03/ 2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45°
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
SERIE DE UNIDAD CLÍNICA MÉDICA
DR. CAROL TORRES MARTELLO
MAY 26 2020 16:21:13
MAY 26 2020 16:21:13

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR SONTA VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45°
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VÍA ORAL
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA


Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVI N CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A JERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA: 4 FECHA: 27/02/2020 Y 28/02/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 7) CABECERA A 45°
- 8) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VÍA ORAL
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

LORRAINE JINAY
Nº 402454
MARGARITA LEONOR KUCHASKY
27/02/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45°
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPROMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VÍA ORAL
- 11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA

13) Colocar vía periférica (26/02/20 17:15 Hs)


Maria Celeste Grisi
Médica
M.N. 161508

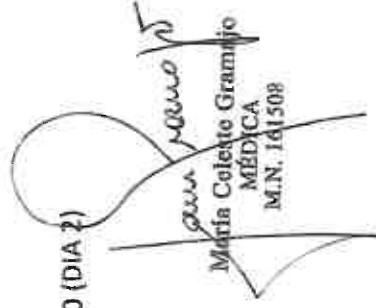
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR

HC Nº: 4

CAMA: 4

FECHA: 21/2/2020 y 22/2 '20

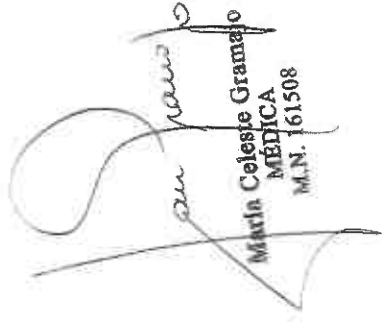
- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45°
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA
- 13) ADMINISTRAR UNA GOTÁ DE SOLUCION OFTÁLMICA (TROBAMICINA) CADA 4 HORAS EN OJO IZQUIERDOO (DIA 2)


María Coleto Gramajo
MÉDICA
M.N. 141508



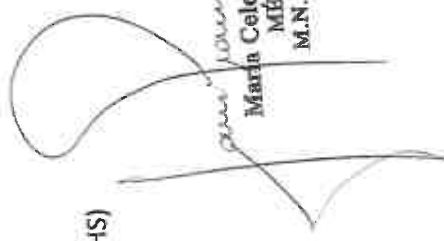
- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45°
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 22 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)
- 12) APLICAR CREMA CON CORTICOIDES EN ZONA DE DERMATITIS 1 VEZ AL DIA
- 13) ADMINISTRAR UNA GOTA DE SOLUCION OFTALMICA (TROBAMICINA) CADA 4 HORAS EN OJO IZQUIERDO (DIA 1)

14) Colocar via periferica (20/02 11:30 hs)


Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 7354 CAMA: 4 FECHA: 19/02/2020 Y 20/ 2020

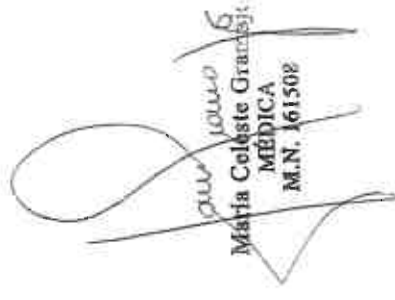
- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45°
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 25 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VÍA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)


Maria Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

178

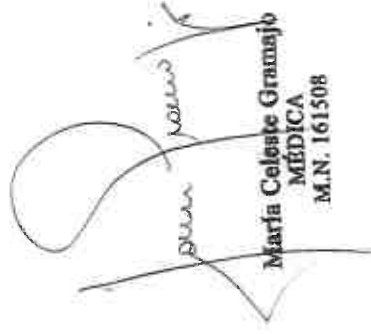
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 4754 CAMA: 4 FECHA: 18/02/2020 y 19/ 2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR SONTA VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45º
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 25 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
- 11) RANITIDINA CLORHIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO CADA 8 HORAS VIA ORAL (8 HS 16 HS 24 HS)


María Celeste Gracioso
MÉDICA
M.N. 161508

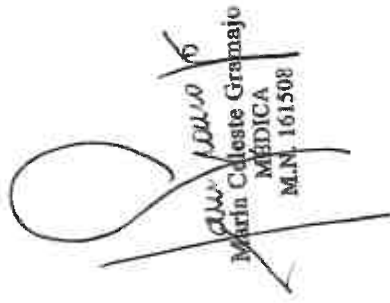
- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45º
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO CADA 24 HS VIA ORAL (22 HS)
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) OMEPRAZOL 20 MG CADA 24 HS AYUNAS 7 AM

11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL
12) Colocación de sonda vesical.


María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 4) 54 CAMA: 4 FECHA: 14/2/2020 y 15/2) 20

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45°
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL


María Caliste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

(1)

(2)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 4)54 CAMA:4 FECHA: 13/02/2020 y 14/ 2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR SONTA VESICAL
- 4) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNIO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 SF + 1 AMP DE DX EN EL BAXTER VIA SC
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45º
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 25 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

Sandra K. Kaus
Infermera C.A. (C)
Especialista en Geriatria
M.D. (C)

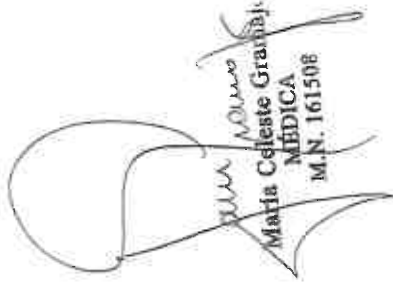


- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) AISLAMIENTO POR KPC
- 3) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 4) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNOS Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF42 AMPOLLAS CLK Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% 42 AMPOLLAS SOMIPOR VIA SUBCUTANEA
- 5) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 6) CABECERA A 45°
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 8) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL


Maria Celeste Gramajo
MEDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 154 CAMA: 4 FECHA: 11/02/2020 y 12/ 2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45º
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM
- 10) CONTENCION TERAPEUTICA
- 11) LEVOMEPRIMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL


Maria Celeste Granja
Médica
M.N. 161508

INDICACIONES A ENFERMERIA

FECCHA: 10/02/2020 y 11/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNATIVO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMIG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VIA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 7//// hoy ultimo dia de tratamiento///
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM
- 11) CONTENCIÓN TERAPEUTICA
- 12) LEVOMEPRIMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA: 4 FECHA: 6/2/2020 y 7/2/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45º
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 10 HS, 25 MG COMPRIMIDO A LAS 16 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 3
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

Sandra Kraus
Médica
Especialista en Medicina
Interna



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 154 CAMA: 4 FECHA: 6/2/2020 y 7/2/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS, 12.5 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VIA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 3
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM
- 11) CONTENCIÓN TERAPEUTICA
- 12) LEVOMEPRMAZINA 12.5 MG/DIA A LAS 22 HS VIA ORAL

2/2/2020: hoy día 4 Linezolid (ampollas 7 días),
K500, levamisol, repeticiones,


Sanja Kuchasky
Médico Jefe de Unidad A3
M.H. 110.150


Sanja Kuchasky
Médico Jefe de Unidad A3
M.H. 110.150

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNATIVO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CLK Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 10 HS, 25 MG COMPRIMIDO A LAS 16 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VIA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 2
- 10) OMEPRAZOL 20 MG/DIA V.O EN AYUNAS 7 AM

- 11) Confusion tropicative 75 mg (12 HS) y 12,5 mg (22 HS) via oral
- 12) Quetiapina 25 mg (12 HS) y 12,5 mg comprimido (22 HS) via oral
- 13) Omeprazol 20 mg

Sanja Kraus
Enfermera
M. 10.189

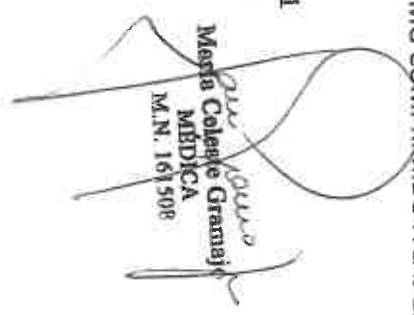
()

()

189

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR SONTA VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNIO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 10 HS, 25 MG COMPRIMIDO A LAS 16 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VIA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 1

10) Confusion propiiva


María Celeste Gramajo
Médica
M.N. 161508

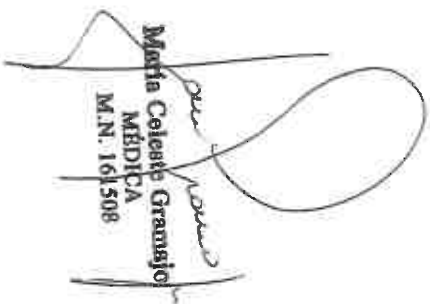
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P.PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 4024' CAMA: 4 FECHA: 4/2/2020 y 5/2/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45º
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLOID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VIA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 1

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 402454 CAMA: 4 FECHA: 3/2/2020 y 4/2/2020

08/1

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOM/G
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 9) LINEZOLID DE 600 MG SACHET CADA 12 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS 20 HS) DIA N° 0


Maria Celeste Grausio
Médica
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 402454 CAMA: 4 FECHA: 31/1/2020 y 1/2/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNIO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CLK Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO A LAS 12 HS Y 50 MG COMPRIMIDO A LAS 22 HS VIA ORAL
- 8) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4,5 GR CADA 6 HORAS VIA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS


Margarita Leonor Kuchasky
Enfermera
HC N° 402454

10/4 Ampouls de CLK en 200 ml SF en 145 (21 hrs)


Margarita Leonor Kuchasky
Enfermera
HC N° 402454

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 40241 CAMA: 4 FECHA: 31/1/2020 y 1/2/2020

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45º
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)
- 8) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VIA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS

182

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) 20 P.A. 2 L.GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTARIO FRASCO N° 1,3 CON ST + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTANEA (8 HS 20 HS)
- 7) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)
- 8) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VIA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 4
- 9) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS
- 10) *Reemplazo de Sonda Vesical con furosemida*

Marta Colesse Gramajo
MEDICA
M.N. 161508

Marta Colesse Gramajo
MEDICA
M.N. 161508

31/01/20 11 HS

183

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
- 8) QUETAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VÍA ORAL (22 HS)
- 9) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 3
- 10) COLCHON DE AIRE ANTESCARAS

Ata de vida por diuresis por vicio vcl

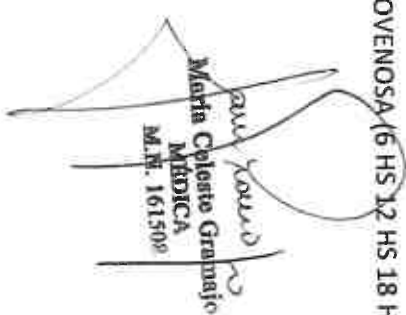
Maria Celeste Grimaldo
Médica
M.N. 161508

Maria Celeste Grimaldo
Médica
M.N. 161508



154

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°, SEGUN SENSORIO
- 5) CABECERA A 45°
- 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
- 8) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VÍA ORAL (22 HS)
- 9) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 3
- 10) COLCHON DE AIRE ANTIESCARAS


Marta Celeste Granado
Médica
M.N. 161509

1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO

2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL

3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG

4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90° : *según su estado*

5) CABECERA A 45°

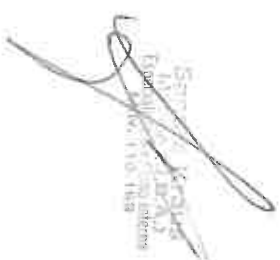
6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)

7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300

8) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

9) PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4.5 GR CADA 6 HORAS VIA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 2

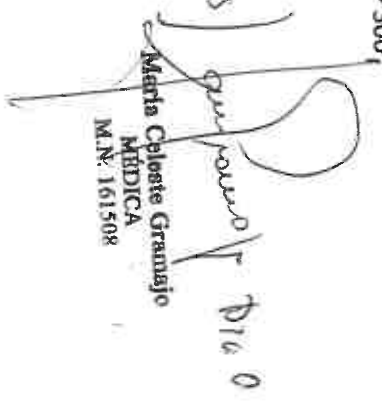
10) *colchon de aire*


SPT
L. KUCHASKY
Firma
11/01/2020

186

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
 - 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
 - 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
 - 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°
 - 5) CABECERA A 45°
 - 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VIA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
 - 7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
 - 8) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL
 - 9) ~~AMPIICILINA + SUBBACTAM 1.5 GR CADA 6 HORAS VIA ENDOVENOSA (6 HS-12 HS-18 HS-24 HS) DIA N° 4~~
 - 10) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)
- M) RTT 4.5 br cada 6 hs via endovenosa (6 hs 12 hs 18 hs 24 hs)


Maria Celeste Granajo
Médica
M.N. 161508


Maria Celeste Granajo
Médica
M.N. 161508



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO DIVISION CLÍNICA MÉDICA UNIDAD 4 INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC Nº: 402454 CAMA: 4 FECHA: 23/1/2020 y 24/1/2020

- 187
- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
 - 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
 - 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNATIVO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
 - 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°
 - 5) CABECERA A 45°
 - 6) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
 - 7) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
 - 8) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL
 - 9) AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 3
 - 10) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VÍA ORAL (22 HS)

SALVADOR VARGAS
Médico
Especialista
Médico

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CONTROL DE DIURESIS POR Sonda VESICAL
- 3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNADO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMIG
- 4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°
- 5) CABECERA A 45°
- 6) OMEPRAZOL DE 20 MG CÁPSULA CADA 24 HORAS VÍA ORAL (8 HS)
- 7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 8) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
- 9) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL
- 10) NEBULIZACIÓN CADA 8 HORAS CON 3 CC DE SOLUCION FISIOLÓGICA MAS 20 GOTAS DEL SALBUTAMOL Y 40 GOTAS DE BROMURO DE IPATROPIO
- 11) AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 2
- 12) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VÍA ORAL (22 HS)

13- Condicion de paciente


María Celeste Granati
Médica
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO GUÁRDIA INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 402454 CAMA: 03 INTERNACION FECHA: 21/1/2020 y 22/1/2020

INDICACIONES

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CABECERA A 45º
- 3) OMEPRAZOL DE 40 MG INYECTABLE LIOFILIZADO + AMPOLLA SOLVENTE CADA 24 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS)
- 4) CONTENCION FISICA
- 5) NADA VÍA ORAL
- 6) ADMINISTRAR HALOPERIDOL DE 0.5 MG COMPRIMIDO CADA 8 HS (DOSIS TOTAL: 1.5) Vía Oral 0.5 a las 8 horas 0.5 a las 16 horas 0.5 a las 22 horas
- 7) PHP A 35 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3,5 CON SF + 2 AMPOLLAS DE CLK Y FRASCO N° 2,4 CON DX AL 5%
- 8) OXIGENOTERAPIA: MÁSCARA

Samantha Paganelli
MÉDICA - U.B.A.
M.N. 144.956

12

6

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO GUARDIA INDICACIONES A ENFERMERIA
PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 402454 CAMA: 03 INTERNACION

FECHA: 20/1/2020 y 21/1/2020

INDICACIONES

- 1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
- 2) CABECERA A 45°
- 3) PHP A 14 GOTAS X MINUTO ALTERNO FRASCO N° 1 CON SF Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5%
- 4) OMEPRAZOL DE 40 MG INYECTABLE LIOFILIZADO + AMPOLLA SOLVENTE CADA 24 HORAS VÍA ENDOVENOSA (8 HS)
- 5) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
- 6) CONTENCIÓN FÍSICA
- 7) DIETA HIPOSÓDICA
- 8) ADMINISTRAR HALOPERIDOL DE 0.5 MG. COMPRIMIDO. CADA 8 HS (DOSIS TOTAL: 1.5) Vía Oral 0.5 a las 8 horas 0.5 a las 16 horas 0.5 a las 22 horas
- 9) VITAMINA K FITOMENADIONA : OBTENIDA POR SÍNTESIS (10 MG) INYECTABLE X 1 ML DILUIDO EN 100 ML A PASAR POR ÚNICA VEZ CADA 24 HORAS VÍA ENDOVENOSA

GRETAL A. BEUNZA
M. N. 113.040
MEDICA

KUCHASKY MARGARITA

CAMA 3

202

30/04/2020

1) Dato hipotética

2) Rta 14 g x alfu.

3) Guayol 20 g 1 d EV

4) Hipocin 5000 30 c/12h

5) Coleus 450

6) Contorno físico

7) Guayol 25 g/d

8) CV x fuo

GRETEL A. BEUNZA
M. N. 113060
MEDICA



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

HISTORIA CLINICA N°

203

Apellido y Nombre:

TUCHETSKY, Maripaz

Unidad I. N°:

Cama: 3

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
20/01	06	Se recibe paciente femenina Exitada con conticlos Fisica. Se retoloca a Uterero periferico y se extrae rutina de laboratorio Se cambia ropado conc. C.V. TA 150/90 FC 70x1 SpO2 95% T36.3 Diurisis por 500cc de Uterer DRL Paciente sin Indicaciones medicas Heparina 5000 UI omeprazol Puchadina 25mg	Jun Venap
20/01/20	1200	Se recibe lo guardado el Pte desorientado Exitado. C.V. TA 140/90 FC 72. S.O. 95% T36.4 C/Sondado Venacl o foto Colestora. S/familiares. C/Contension ferece.	J matich 42+320
135		C.V. TA 140/90 FC 72. S.O. 95% T36.4	
145		Se realiza baño en la cama el cuerpo Pateal y Solonon, (PARAISIS+++)	
155		Fer I 5H 14.	
165		DIURESIS. 1000cc	
175		Se ppo 1 cup Haloperidol x excitacion	
18		Pte hemerica desorientada C/V. Pte. S.V. contension 95% TD.	Depe
		TS 130/80 T36.4 FC 77 SpO2 96	
20		Heparina Sodica 5000 UI 8C Pte bene asistida por el familiar	Jal-e
22		Haloperidol 95mg. Vo	
24		Se descarta 500 ml diuresis Se realiza higiene personal	
00-00		Paciente adulta mayor, femenina, de momento desorientada, mpe.	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
		Presento oídos reumáticos fufuñar muerlar inferior agguendo chup. sf	
		TS 120/80 - W. FC 91 x ST95 y. T36,4	
		Se anota mediar unites repuestas	
		Ando venial cunetado o bho celdas	
		Se anota unites uno y fuciente -	
	03 ⁰⁰	Presente descanso	
	05 ⁰⁰	No presente medeamin en esta hora	
		PA. sf 110/80 T36,4	
	06	Paciente descaando	
		con pite T36,4 T36,4	
	08 ⁰⁰	03 caprol 4000	
		Heparina 5000 sc	
		Haloperidol 0,5 y	
		Vit K en biluiz	
		Con ta 106/67 FC 52 y	
		Diruente de sangra venal	
	09	Se extrae rutina de laboratorio	
	11	Se realiza H. pte. porical	
		Cateteris positiva	
		Se coloca s262	
	12	30/11/80 35 y	
21/01/20	12	Pte femenina vigil y AUP. PHD. sf. 02	
	13 ⁰⁰	TS 107/80 T36 FC 57 sp02 95	
		con contusion en MSD YI.	
	15 ⁰⁰	Se realiza Tegu y Corpit y Corho	
		de poid	
		Naz e/82	
	16 ⁰⁰	Catarsist de ruzo Corho Solona	
		y Poid.	
		Se reanota Haloperidol 0,5 y x anticon	
		Naz e/82	
	17 ⁰⁰	PHS 1,8 y	
21/01/20	18	Pte femenina desorientada y contusion	
		MSD YI. AUP. PHD	
		TS 110/80 T36,4 FC 67 sp02 96	
	20	Pte es asistida por familiar para la cura	
	22	Haloperidol 0,5 y	
	24	AMS 1,5 y EV	
		Se desclara 300 ml de urea	
		Se realiza higiene personal	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

HISTORIA CLINICA N°

Apellido y Nombre:

KUCHASKY MARGARITA

Unidad I. N°:

Cama: 3

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
22/01	24 ⁰⁰	CSU. Pte. Anemograma con conteo = Cmí con 9/2 medula ósea con AUP = 10.3 g/Hp = 35 pta Con penicil y Sonda Venosa (puntable)	Jos
	01 ⁰⁰	T.A. = 136/72 FC = 82x' T° = 37° SAT = 92%	Calme Juri.
	02 ⁰⁰	Neck x Base	
	03 ⁰⁰	Pte. de am mto	
	05 ⁰⁰	Neck x Base PHP 35 pta (elim.) AMS (ev) - Mun i - - - - - (reducido) Análisis y m. fin	
	07	Paciente despierta, con cabeza clara O ₂ por máscara PHP = 35 pta CSU	Ueizopz
	08	N32 + isopta de salbutamol Haloperidol 0.5 VA Omeprazol 40ev CSU TA = 130/70 T° = 36° SpO ₂ = 96% A/A F ₂ = 24x' Pulso = 86x'	
		Se nota UR perficida, en M sup derecho Se realiza rutina de laboratorio	
	11	AMS 1, 5 ev Se realiza Hipicor se cambian dental, catéters positive	
22/01/20	12 ⁰⁰	Se realiza lo fueran qph deuredo electrocardiograma, qph en 750 EPRP 35. EPO terapio. q/S. Venosa foto ecografía sus familiares	
	135	CSU T/A 100/70 Fc 82x	Montes Ueizopz

[illegible]

**HOJA DE ENFERMERIA**

Hospital:

$$P_i \bar{U}_{E_i}$$

HISTORIA CLINICA Nº

402454

Apellido y Nombre:

Kucharsky Hupzritz

Unidad I. N°:

4

Cama:

6

015/G/0019

[illegible]

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
9/03	21 ⁰⁰	PTE DEPENDIENTE, DEMANDANTE, COO SOMA USUAL; 20 ⁰⁰ A.C. ⁹ .	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
9/03	22	CSU.	
9/03	22	DDN 25 mg furosemida W.	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
9/03	22	DDN 25 mg clonazepam W.	
10/03	24	DDN 150 mg paritidina W	
10/3	01	PTE DESCONOCIDO	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
10/3	06	SE DIONIZOLINA	
10/3/20	08	PTE DEPENDIENTE, DEMANDANTE; COO SU. COO ⁹ A.C. ⁹ .	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
10/3	08	CSU.	
10/3	08	DDN 25 mg furosemida W	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
10/3	08	DDN 3000 mg ketorolac	
10/3	08	DDN 150 mg paritidina W.	
10/3/20	10	SE ASISTE A LA INGESTA DE DESAYUNO.	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
10/3/20	12	SE DIONIZOLINA	
10/3/20	14	ALB 13 CURAIDA	
	16	TAUHA 150 mg - SINOPUR 25 mg - 18 H2O Y CONFIN	STOCKDALE ALBERTO ENFERMERO M.N. 65.702
	20	ABRAMMA 500 mg	
10/3	21	se recibe guardia con pte acompañada	
	21	de familia, pte en Asil. de Contacto y su	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	21	permisible	
10/3	22	Control de signos vitales.	
	22	Adm levomepromazine 25 mg (W), Queto	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	22	rina 25 mg (W).	
10/3	24	Paritidina 150 mg (W) se Acondiciona	
	24	pte y unidad p/descuss.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
11/3	02	pte se observa desahogado	
11/3	06	se realiza Higiene y confort.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
11/3/20	8	Pte dependiente de estomatología, con Sonda nasal, se distanciamiento de control	SARAGUÉLLO Enfermero F.M. 438001
11/3/20	8	Waristo quitapm 25 mg W, Neprim Sooal se, Paritidina 150 mg W	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
11/3/20	10	Adm Control de SpO2 cutáneo	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
11/3/20	12	hiperperm, loba de codo, ce. Tuss + + +.	
11/3/20	14	rectal cut de tibia	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
11/3/20	16	Adm Control de SpO2 cutáneo	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: P. P. S. E. L. O.

HISTORIA CLINICA N°

402454

Apellido y Nombre:

KUCHASKY, MARGARITA

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
8/3	13	pte ocupado de familia quien	
	13	no asiste NO RESPONDE	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermera Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	13	asiste en ingesta oral de Alimentos	
8/3	14	pte satisfactorio	
8/3	16	Ranitidina 150mg, que tiene	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermera Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	16	25 mg	
	16	se asiste en ingesta de merienda	
8/3	18	se realiza Higiene y confort y	
	18	aplica crema / corticoides en zona	
	18	de dermatitis	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermera Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
8/3	20	Heparina 5000 UI (sc)	
		se asiste en ingesta de cena	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermera Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
8-3	21	CSU	
	22	Quetiapina 25 mg 1/2	
	22	Fransiprim 25 mg 1/2	
	24	Ranitidina 150 mg 1/2	
9-3	03	Pte Luanne	ABEL MANOZ Aux. de Enfermería M.N. 38022
	06	Pte control de heridas	
P-3	8	Paciente no se defende	
P-3	8	enfereir sobre el colapso	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
P-3	8	Se le administra Sulfato	
P-3	8	para 25 mg VO. Heparina	
P-3	8	5000 UI SC, Ranitidina 150	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
P-3	8	mg VO.	
P-3	10	Se acondiciona cuido	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
P-3	10	del paciente	
P-3	12	Realiza fricción de los	
P-3	12	miembros de contacto	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
08/03/20	14	Pte dependiente de enfermería se som	
		eten. a Asistencia de Control	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
08/03/20	16	Realiza control de SPA cuido	
08/03/20	16	Administración 150 mg, Quetiapina	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
		25 mg VO.	
08/03/20	18	Administración pte, Rotación de arbo, cuido	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
08/03/20	20	Administración Heparina 5000 UI SC	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
06/03/20	18	bño en Cama, lotión de u.b.t.	SAL. ARGÜELLO Enfermero E.M. 438001
06/03/20	20	Dorato Heparin 5000 u SC	
6-3	21	CSU.	
	22	Lenorepro majino 25 mg $\frac{1}{6}$	
	22	Quetiapino 25 mg $\frac{1}{6}$	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
	24	Rantidina 150 mg $\frac{1}{6}$	
7-3	03	Pte con desecurso irregular	
	06	Pte concilia el desecurso con mucho dificultad -	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
7/3.	07	pte descausado, en Anal. de contacto $\frac{1}{30}$	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	7	permeable	
7/3	08	Control de signos vitales.	
	8	Heparina 5000 u (SC), Rantidina 150 mg (w)	
	8	Quetiapino 25 mg (w) se existe en	
	8	ingesta de desayuno	
7/3	10	se realiza baño eucema, cambio de	
	10	pañal y ropa de cama, se aplica crema	
	10	protectora en zona de dermatitis	
7/3	12 ³⁰	pte recibe visita de familiares quien le	
	12 ³⁰	asiste en ingesta de oral de alimentos.	
7/3	14	pte permanece tranquila, con $\frac{1}{6}$ baranda	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	14	elaborada.	
7/3	16	Rantidina 150 mg (w), Quetiapino 25 mg (w)	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	16	se existe en ingesta de alimentos.	
7/3	17	se realiza Higiene perineal.	
7/3	20	Heparina 5000 u (SC)	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
7/3	20	se existe en ingesta de alimentos	
7-3	21	CSU.	
	22	Quetiapino 25 mg $\frac{1}{6}$	
	22	Lenorepro majino 25 mg $\frac{1}{6}$	
	24	Rantidina 150 mg $\frac{1}{6}$	
8-3	03	Pte duerme	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
	06	Pte acondicionado en cama.	
8-3	07	pte descausado, en Anal. de contacto.	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	7	c/ suemical permeable, baranda eleva	
	7	dora	
8/3	8	CSU -	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	8	Aon Heparina 5000 u (SC), Rantidina	
	8	150 mg (w), Quetiapino 25 mg (w)	
8/3.	8 ³⁰	se existe en ingesta de desayuno	CASTRO TAPIA GLADYS Enfermero Profesional M.N. 90816 M.P. 145076
	10 ³⁰	se realiza H.giene y confort.	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: Liniers

HISTORIA CLINICA N°

402459

Apellido y Nombre:

Wachoby Marguito

Unidad I. N°:

4Cama: 4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
4-3	23	Haloperidol 1 amp (1mg) por boca vez	
	24	Paralidina 150mg v/o	
5-3	03	Pte de curación	
	06	Pte continuo durmiendo, se le acondi- ciono en cama.	
5/3/20	8	Heparina 5000 u. sc.	
5/3/20	8	quetizipin 25 mg po.	
5/3/20	rm	pte dependiente de enferme- ria estable. + PEP + su ps.	
5/3/20	rm	modale.	
5/3	14	CSU, desluciendo, SUG BC.	
5/3	16	Paralidina 150mg v/o	
	16	Quetiapina 25mg v/o	
5/3	18	higiene y confort, aplicación crema	
	20	cambio postural, asistencia para la cacería.	
5/3	22	Oxígeno 37,5 u. (6)	
5/3	22	Leonepro 25mg (6)	
	24	Paralidina 150mg (6)	
6/3	03	Pte de curación.	
	04	Se ingresó.	
6/3	08	Paciente a todo tranquilo	
6/3	08	dependiente de enfermería.	
6/3	08	estado normal, tranquilo	
6/3	08	Se administró Quetiapina	
6/3	8	25mg v/o, heparina 5000 u. sc	
6/3	8	Paralidina 150mg v/o.	
6/3	8	Paciente a todo tranquilo	
6/3	10	estado de confort y KPC	
6/3	12	Paciente tranquilo	
6/3/20	14	Pte dependiente de enfermería, co- municación estable.	
6/3/20	16	Medio control de SPO2 al de- lirio control quetiapin 25mg po, Paralidina 150mg po.	

ABEL MUÑOZ
Aux. de Enfermería
M.N. 39.028

333467

333468

333469

Jhonny Yauri García
Enfermero Especialista
M.N. 40235FERNANDO RODRIGO M.
Aux. de Enfermería
M.N. 4925
FERNANDO RODRIGO M.
Aux. de Enfermería
M.N. 4925
FERNANDO RODRIGO M.
Aux. de Enfermería
M.N. 4925ANA V. PENZKOFER
Enfermera
M.N. 4925ANA V. PENZKOFER
Enfermera
M.N. 4925ANA V. PENZKOFER
Enfermera
M.N. 4925SALVARGUELLO
Enfermero
F.M. 438001SALVARGUELLO
Enfermero
F.M. 438001

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
2-3	22	Levomepromazina 25 mg $\frac{1}{2}$	del
	22	Quetiapina 25 mg $\frac{1}{2}$	del
	24	Levodopa 150 mg $\frac{1}{2}$	del
3-3	03	Pte duenne.	del
	06	Pte acondicionado en cama.	del
3/3	08	Control en signos vitales	del
3/3	08	Ranitidina clorhidrato 150 mg vo	del
	09	Heparina Sódica 5000 U/ml sc	del
	08	Quetiapina 25 mg vo.	del
	12	Se Redige Higiene y confort	del
	-	catarsis Positivo. Se Combica	del
3/3	12	painel y Ropa de cama.	del
	14	esv, su a BC, acompañado hijo	del
	14	asiste por ingesta alimentos	del
3/3	16	Ranitidina 150 mg vo	del
	16	Quetiapina 25 mg vo	del
3/3	18	Higiene y confort aplica crema	del
	20	cambo postural	del
3/3	20	Heparina Sódica 5000 en SC	del
3/3	22	Levodopa 150 mg 25 mg (6)	del
	22	Quetiapina 25 mg (6)	del
	24	Amantadina 150 mg (6)	del
4/3	08	Mn des. curm.	del
	04	Se hip. man.	del
4/3/20	8	amitilidina 150 mg vo.	del
4/3/20	8	Heparina Sódica sc.	del
4/3/20	8	quetiapina 25 mg vo.	del
4/3/20	tm	pt. supenante de unguento	del
4/3/20	tm	estado	del
04/03/20	14	Pte dependiente de enfermería, Ce pp, Suel. Cuesal, en Sislazeto de Control	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438061
04/03/20	16	Redigo Control de spa vital	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438061
04/03/20	16	Doanisto Quetiapina 25 mg vo, Ranitidina 150 mg vo.	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438061
04/03/20	18	Higiene perul, Rotuon de vito	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438061
04/03/20	20	Doanisto Heparina 5000 U/ml sc	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438061
4-3	21	esv.	del
	22	Quetiapina 25 mg $\frac{1}{2}$	del
	22	Levomepromazina 25 mg $\frac{1}{2}$	del
	23	Pte que se encuentra exitosa, es evaluado por médico de guardia e indicó	del

ABEL MUÑOZ
Aux. de Enfermería
M.N. 39.029

Johnny Yauri Garcia
Enfermero Profesional
M.N. 26585 M.P. 128235

Johnny Yauri Garcia
Enfermero Profesional
M.N. 26585 M.P. 128235

FERNANDEZ RODRIGO M.
Enfermero
F.M. 438061
FERNANDEZ RODRIGO M.
Enfermero
F.M. 438061
FERNANDEZ RODRIGO M.
Enfermero
F.M. 438061
FERNANDEZ RODRIGO M.
Enfermero
F.M. 438061
FERNANDEZ RODRIGO M.
Enfermero
F.M. 438061
FERNANDEZ RODRIGO M.
Enfermero
F.M. 438061

334468

334467

334469



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

HISTORIA CLINICA N°

G. C. B. A.

Hospital: Pirrama

402454

Apellido y Nombre:

Lochovsky. MARGOTAUnidad I. N°: 4Cama: 4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
1-3	06	Reordenando en cama.	<u>EL MURAZ</u> Enfermera M.N. 39.244
1/3/20	8	TAMAR 150 mg. Sodio 250 mg. HIDRALAZINA 500 mg.	
	11	HIG y confort	
		CUBRA CON COYORRO EN LA MANITA	
	16	TAMAR 150 mg. Sodio 250 mg.	
	20	HIDRALAZINA 500 mg.	
1/2	22	Carbamazepina 25 T. CA	
	22	Quetiapina 25 mg. CA	
	24	Paracetamol 150 mg. CA	
2/2	03	Al descubierto.	
	06	Se le hizo un.	
2-3	08	Medicinas (revisar) no corresponden.	
2-3	08	Definir bien color de la.	
2-3	8	liza extracción enfermera (color).	
2-3	8	revisar)	
2/3/20	08	Paracetamol 150 mg. v.o.	<u>AD 31624</u>
2/3/20	08	Heparina sodica 5000 u/l se	<u>AD</u>
2/3/20	08	Quetiapina 25 mg v.o.	<u>AD</u>
2/3/20	08	Dile genit.	<u>AD</u>
2/3/20	08	Higiene y confort. Se realiza Baño en ducha, cambio de pañal y ropa de cama.	<u>AD</u>
2/3/20	10	Colocación yogurt.	<u>AD</u>
2/3/20	12	Dile genit.	<u>AD</u>
2/3	15	Control de signos vitales	<u>AD 31624</u>
2/3/20	15	Atención de herida	<u>AD</u>
2/3	16	Quetiapina 25 mg v.o.	<u>AD</u>
2/3	16	Paracetamol clorhidrato 150 mg v.o.	<u>AD</u>
2/3	18	Higiene y confort.	<u>AD</u>
2/3	20	Heparina sodica 5000 u/l se	<u>AD</u>
2/3	20	visita del oficio p/la cama.	<u>AD</u>
2/3	20	Higiene y confort Baño en ducha catarsis positivas	<u>AD</u>
2-3	21	esv.	<u>AD</u>

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
27/02/20	15	Medico Control de SpA c/ de	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
27/02/20	16	Admisio Zolpidim 150 p/lo, Quetiapm 25 p/lo.	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
27/02/20	18	hiper perul, Rotron de wito	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
27/02/20	20	Admisio Mepum 5000 u/se	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
27-2	21	Cru.	
	22	Quetiapm 25 mg 1/0	
	22	Levomepromazine 25 mg 1/0	
	24	Dantidmo 150 mg 1/0	
28-2	03	Pte dueme.	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.023
	06	Pte control de duende.	
28/02/20	8	Admisio Zolpidim 150 p/lo, Mepum 5000 u/se, Quetiapm 25 p/lo	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	10	Medico Control de SpA c/ de	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	10	hiper perul, Rotron de wito	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	12	Pte perul de el Czm	SAUL ARGÜELLO Enfermero
28/02/20	14	Pte de perul de el Czm, Acompz. inde por triller	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	16	Medico Control de SpA c/ de	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	16	Admisio Quetiapm 25 p/lo, Zolpidim 150 p/lo.	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	18	Admisio pte, Rotron de wito	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
28/02/20	20	Admisio Mepum 5000 u/se	
28/02/20	21	Cru de perul de wito	
28/2	22	Quetiapm 25 mg 1/0	
	22	Levomepromazine 25 mg 1/0	
	24	Dantidmo 150 mg 1/0	
28/2	03	Me de duende.	
	06	Se hgi man.	
29/2/20	8.	Admisio de SpA, Senopm 25 mg, H8/LUNA 5000 mg	STOCKDALE ALBERTO ENFERMERO M.N. 65.702
	11.	SANO EN BUENA	
		APRUEBA CON CADA 24 HRS.	
	16.	Admisio de SpA, Senopm 25 mg	STOCKDALE ALBERTO ENFERMERO M.N. 65.702
	20	Admisio de SpA, Senopm 25 mg	
	22	Cru.	
	22	Quetiapm 25 mg 1/0	
	22	Levomepromazine 25 mg 1/0	
	24	Dantidmo 150 mg 1/0	
	03	Pte duende.	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.023



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

Hospital:

Disco

HISTORIA CLINICA N°

402454

Apellido y Nombre:

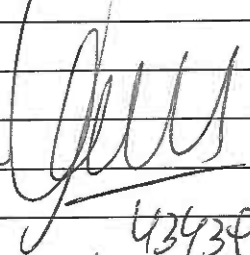
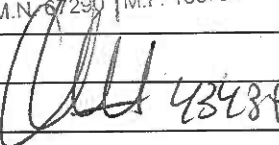
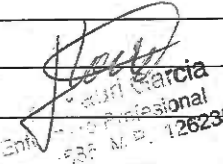
KUCHASKY, MARGALITA

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
26/2	7 ³⁰	de sangre para laboratorio	
26/2	08	Heparina Sódica 5000 UI SC	
	08	Quetiapina 25 mg VO	
	08	Ramitidina 150 mg VO	
	10	Pte dependiente, con HP, SV, continuo en AC	
26/2	12	Pte sin cambios	434398
26/2/20	14	Pte dependiente de exterioriz,Scope nro de trileta	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
26/2/20	16	Se cubre Saco Uro pericuo en MSD.	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
26/2/20	16	Realizo control de S.p.a. a Hb	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
26/2/20	16	Administro Ranitidina 150 mg VO, que lejan 25 mg VO	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
26/2/20	18	hipere pericuo, Raton de cub to	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
26/2/20	20	Administro Heparina Sódica 5000 UI SC	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
26/02/20	219	Pte dependiente, demorando, con dup MSD con Pte Hgk, SV, a 434398	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en enfermería M.N. 67290 M.P. 158 20
26/02	22	CSU	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en enfermería M.N. 67290 M.P. 158 20
26/02	22	DDT 25 mg guetropina VO.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en enfermería M.N. 67290 M.P. 158 20
26/02	22	DDT 25 mg guetropina VO.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en enfermería M.N. 67290 M.P. 158 20
27/02	01	Pte de SCSO SCSO	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en enfermería M.N. 67290 M.P. 158 20
27/02	06	SE de SCSO	
27/2	8	Personal extraccionalista leona	
		Muerto de sangre para laboratorio	
27/2	8	CSU, orientada persona.	García Profesional M.P. 126235
	8	Heparina Sódica 5000 UI SC	
27/2	8	Quetiapina 25 mg VO	
	8	Ramitidina 150 mg VO	
27/2	8	Cambio postural, asiste ingesta	
	10	higiene y confort, aplicación de curas	
27/2	12	Cambio postural	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
27/2/20	14	Pte dependiente de exterioriz, con Saco Uro, Saco Uro pericuo PUP, en distancio de control.	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
24/2	12:35	se aplica sol. oftálmica en ojo izquierdo pte recibe visita de familiar quien asiste en Ingesta de Alimentos	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
24/2	14	pte licencia acompañada de familiar	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
24/2	16	Paritidina 150mg(VO), Quetiapina 25mg(VO), se aplica sol. oftálmica	
24/2	18	se realiza Higiene personal	
24/2	20	Heparina 3000 UI(SC), aplica sol. oftálmica	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
24/02	21 ^{ra}	PTE DEPENDIENTE DEMONSTRAR C/O A/D C/O P/P; SV, 80 ⁶ DE	
24/02	22	CSU	Gutierrez J. Gina J. Eic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
24/02	22	ADN 25mg (PO) PARITIDINA	
24/02	22	ADN 25mg (PO) PARITIDINA	Gutierrez J. Gina J. Eic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
25/02	21	PTE DEPENDIENTE	
25/02	24	ADN 150g PARITIDINA	
25/02	06	SE J CARDIACA	Gutierrez J. Gina J. Eic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133 20
25/2	04	pte en Anal. telotactos / seces subcutaneos, se da verbal permisible. Resaca de / cabeza, 45° y constantes elevadas-	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
25/2	8	OSU	
	8	Paritidina 150mg(VO), Quetiapina 25mg(VO)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	8	Heparina 3000 UI(SC), aplica gotas	
	8	oftálmicas en ojo Izq.	
25/2	9	se Asiste en Ingesta oral de desayuno	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
25/2	10	se Asistencia moral de Pte.	
25/2	12	se aplica gotas oftálmicas	
25/2	12:30	pte recibe visita del familiar (Hijo) quien asiste en Ingesta de Alimentos	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
25/2	16	Quetiapina 25mg(VO), Paritidina 150mg(VO) se realiza Higiene y confort. se aplica crema / corticoide en zona termotiza	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
25/2	20	Heparina 3000 UI(SC), se aplica sol. oftálmica	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
25/2	22	Quetiapina 25mg(VO)	
	24	Paritidina 150mg(VO)	
26/2	03	In de curación.	
	04	se sacaron	
26/2	1:30	Extirpación tumor Muestra	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: *Dr. P. Martínez*

HISTORIA CLINICA N°

Apellido y Nombre:

Kuchinsky, Margarita.

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
<i>22/2</i>	<i>21</i>	<i>lactoparum 25 mg vo</i>	
	<i>21</i>	<i>penton 15 mg vo</i>	
<i>23/2</i>	<i>03</i>	<i>Mr. Lucman.</i>	
	<i>06</i>	<i>se zabranen.</i>	
<i>23/02</i>	<i>8</i>	<i>CSV. pentopon 25 mg vo</i>	
	<i>8</i>	<i>heparina 5000 UI s/c</i>	
	<i>8</i>	<i>Ranitidina 150 mg vo</i>	
	<i>12</i>	<i>Buenos días</i>	
	<i>14</i>	<i>recibidos. Familiar refiere administrado cada noche entre 3 y 6 mg de bromazepam por sus propios medios. Se le impone pues se le prohibe y pueros relacionados a los médicos de la familia.</i>	
<i>23/02</i>		<i>16</i>	
		<i>20</i>	
<i>23/02</i>	<i>20</i>	<i>se colocan gotas sublinguales</i>	
<i>23/02</i>	<i>21</i>	<i>Control en signos vitales</i>	
<i>23/02</i>	<i>22</i>	<i>quetiapina 25 mg vo.</i>	
<i>23/02</i>	<i>22</i>	<i>Levosimprazon 25 mg vo.</i>	
<i>23/02</i>	<i>24</i>	<i>Ranitidina clorhidrato 150 mg vo</i>	
<i>24/02</i>	<i>03</i>	<i>Paciente desahusada</i>	
<i>24/02</i>	<i>06</i>	<i>higiene y confort.</i>	
<i>24/02</i>	<i>4</i>	<i>Pte de la enf en Anal de contacto o/ acceso subcutaneo y se da un control de signos vitales</i>	
<i>24/02</i>	<i>8</i>	<i>C.S.O.</i>	
		<i>Adm Ranitidina 150 mg vo, Levosimprazon 25 mg vo, se la asiste en ingesta de desayuno, Heparina 5000 UI s/c</i>	
<i>24/2</i>	<i>10</i>	<i>se acordaron medidas y Pte</i>	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
20/02	21 ⁴⁵	PTE DEPENDIENTE DEMANDAS CBO DUPORD con RP. 14g.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67230 MAP 103 20
20/02	22	C8V -	
20/02	22	D27 LEVOTERONOL 25 mg W.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67230 MAP 103 20
20/02	22	D27 25 mg POCOTAPINOL	
21/02	21	ADN 150 mg CONTROLO W.	
21/02	01	PTE DESORDENADO -	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67230 MAP 103 20
21/02	06	SE DORADURA	
21/02	08	Control de signos vitales	HA 9/1624
21/02	08	Heparina Sódica 5000 u/l sc	AD
21/02	08	Quetiapina 25 mg vo	AD
21/02	08	Ramitidina clorhidrato 150 mg vo	AD
21/02	09	Se ducha a le paciente y se lea cambio de Ropa de Bueno. y Piel	AD
21/02	10	Crema en zonas glúteas	AD
21/02	12	Dieta general	AD
21/02	15	Control de signos vitales	AD
21/02	16	Quetiapina 25 mg vo	AD
21/02	16	Ramitidina clorhidrato 150 mg vo	AD
21/02	20	Heparina Sódica 5000 u/l sc	AD
21/02	20	Higiene y confort. Se aboca.	
21/02	20	Crema en zonas. Ramitidina	
21/02	22	Levoteronol 25 mg. (C)	
	24	Ramitidina 150 mg. (C)	
	24	Quetiapina 25 mg. (C)	
22/2	03	Alm. en enfermería.	
	04	Se lea en enfermería.	
22/2	04	pte depend. de enfermería, % acceso sub cutáneo, SIVISCAL en Acl. de Contacto.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
22/2	8	Control de signos vitales.	
	8	Heparina 5000 u/l (sc), Quetiapina 25 mg	
	8	(vo), Ramitidina 150 mg (vo)	
	8	se asiste en ingesta de alimentos.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
22/2	10 ³⁰	se realiza Higiene perineal.	
22/2	12 ³⁰	Ingesta oral asistida por familiar (Hijo)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
22/2	16	Alm. Quetiapina 25 mg (vo), Ramitidina 150 mg	
	16	(vo), se asiste AU subcutánea.	
22/2	18	Se Asist. unidad	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
22/2	20	Heparina 5000 u/l (sc)	
22/2	20	pte lea asistida por familiar (Hijo)	8/1302



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: PARTENIO RIVERA

HISTORIA CLINICA N°

Apellido y Nombre: KUCHASEY, MARGARITAUnidad I. N°: 4Cama: 04.

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
18/02	16	DOT. 50 mg PARACETAMOL 10	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 / M.P. 138.20
18/02	20	HEPARINA 5000 mg 8bc.	
18/02	21 ⁰⁰	PTE DEPENDIENTE DE ENFERMERIA	
18/02	22	CSU.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 / M.P. 138.20
18/02	22	DOT. 25 mg PARACETAMOL 10	
18/02	22	DOT. 25 mg PARACETAMOL 10	
18/02	01	PTE DE DESCANSO	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 / M.P. 138.20
19/02	00	SE DECONGIONA	
19/2	08	Hipocloruro 5000 mg (re)	
	08	Paritidino 150 mg (re)	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	10	Pte dependiente, CSU SV.	
19/2	12	Quetiapina 25 mg (re)	
19/2	15	Control de signos vitales	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
19/2	16	Paritidino 150 mg (re)	
19/2	20.	Heparina Sódica 5000 u/l sc	
19/2	20	Hipocloruro y confort	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
19/2/20	21 ⁰⁰	CSU.	
	22 ⁰⁰	Quetiapina 25 mg (re)	
	22 ⁰⁰	levomepromazina 25 mg (re)	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	24 ⁰⁰	Paritidino 150 mg (re)	
	1	Pte dependiente de enfermería.	
	1	SV, PHP, AISL-Contacto.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	03 ⁰⁰	Pte de descanso.	
	06 ⁰⁰	Hipocloruro y confort.	
20/2	08	Control de signos vitales	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
20/2	08	Hipocloruro Sódico 5000 u/l sc	
	08	Paritidino 150 mg (re)	
	12	Dieta genl.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	12	Hipocloruro y confort Control de signos vitales	
20/2	15	Control de signos vitales	
	16	Quetiapina 25 mg (re)	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	16	Paritidino 150 mg (re)	
	18	Hipocloruro y confort	
	20.	Heparina Sódica 5000 u/l sc	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
16-2	06	omeprazol 20mg $\frac{1}{2}$	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
16-2	06	Paciente en ayuno con cuerpo intacto.	ANA V. PENZACOTER ENFERMERA M.N. 43642
16/2/20	0800	CV	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	0800	Heparina 5000 UI SC.	
	1200	Quetiapina 25mg VO	
	1200	Pte al muerza en compañía de su hijo/se le realiza baño en cama.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	1600	Pte de cansa	
	1800	Higiene y confort.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
	2000	Heparina 5000 UI SC	
16/2	21	CV.-	
	22	Quetiapina 25mg $\frac{1}{2}$	
	22	Perampromazine 25mg $\frac{1}{2}$	
16/2	03	Pte duerme.-	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
	06	omeprazol 20mg $\frac{1}{2}$	
17/2	8	Personal extraccíon de tres muestras de sangre para laboratorio	
	08	Heparina 5000 UI SC	
	10	Pte dependiente, estable.	
	12	Quetiapina 25mg VO	
17/2	15	Control de signos vitales	91624
17/2	16	Dieta gélida, Higiene capít.	
17/2	18	Observación Sonda vesical	
17/2	20	Heparina sonda 5000 UI SC	
	21	CV.-	
	22	Perampromazine 25mg $\frac{1}{2}$	
	22	Quetiapina 25mg $\frac{1}{2}$	
	24	Pte duerme.-	
18-2	03	Pte continúa desuando.-	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
	07	omeprazol 20mg $\frac{1}{2}$	
18/2/2020	8hs	Pte dependiente de enf. en AC con su permeable.- Se administra heparina 8000 UI SC.-	436393
	9hs	Se asiste en el desayuno.-	
	12hs	Pte estable.-	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67280 M.P. 138.20
18/02	14hs	Pte dependiente, DEMANDANTE, con deca bloqueo; Sonda vesical. "A. 2"	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67280 M.P. 138.20
18/02	15hs	CV.	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: Paranaense P. N. 20

HISTORIA CLINICA N°

402454

Apellido y Nombre:

KUCHASKY MARCOS

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
14/2/20	0300	redundado para dormir	VALDEZANA B. Lic. Enfermería M.N. 67914
14/2/20	0600	Beato en cama, cambio de posición	VALDEZANA B. Lic. Enfermería M.N. 67914
	0600	grupo de cama, se demora de cama	
	0600	debe celebrarse	
14/2	08	Control de signos vitales	8/16/24.
14/2	08.	Heparina sodica 5000 u/ml se	AD
14/2	08.	Díete general	AD
14/2	09	Se realiza baño, cambio de posición	AD
		Ropa de cama.	
		Paciente con Subcutaneos	AD
	12	Quetiapina 25 mg VO.	
14/2	15	Control de signos vitales	8/16/24.
	16.	Díete general.	AD
	18.	Higiene y confort.	AD
14/2.	20.	Heparina sodica 5000 u/ml se	AD
14/2	21	PTE DEPENDIENTE, DEMANDANTE, CON SONDA URETERAL. "A.C.H"	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133-20
14/02	22	CSV.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133-20
14/02	22	ADN 25 mg LOROMEPROMAZINA W.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133-20
14/02	22	ADN 12,5 mg QUETIAPINA W.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 133-20
15/02	01	PTE DESCANSADO.	
15/02	06	ADN 20 mg QUETIAPINA W.	
15/2/20	0800	Cau	Alicia M. Stancheff Enfermera F.M. 434427
	0800	Heparina 5000 u/ml se.	
	1000	Higiene y confort, cambio de ropa de cama.	Alicia M. Stancheff Enfermera F.M. 434427
	1200	parte almuerzo en compañía de su hijo/Quetiapina 25mg VO.	Alicia M. Stancheff Enfermera F.M. 434427
	1600	Pte descanza.	
	1800	Higiene y confort.	Alicia M. Stancheff Enfermera F.M. 434427
	2000	Heparina 5000 u/ml se.	
15-2	21	cau.	
	22	Quetiapina 25 mg VO.	
	22	Loromepromazina 25 mg VO.	ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.023
16-2	03	Pte duerme.	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
12/2	8	CSU, orientada pasara a AUC, pte, su ABC, asiste a examen	Jony Yauri Garcia
12-2	8	Heparina 5000 UI SC	
	8	omeprazol 20 mg VO	
12-2	10	Bato en la cama; aplicacion en	
	12	Quetiapina 125 mg VO	
12-2	12	cambio postural	Jony Yauri Garcia Enfermero Profesional M.N. 86585 M.P. 128235
12/2	14 ⁰⁰	PTE DEPENDIENTE, DEMANDANTE, COO AUC Y DCOO PP AUGA, SV. ¹ ADN	
12/2	15 ⁰⁰	CSU.	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/2	18	SE ASISTE A LA INGESTA DE COMIDA	
12/2	20	ADN 5000 UI HEPARINA SC	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/2	20	SE REALIZA HIGIENE Y CUIDADO	
12/2	20 ³⁰	ESTUDIO ASISTE A LA INGESTA DE COMIDA	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/02	21 ⁰⁰	PTE DEPENDIENTE, DEMANDANTE, COO ADN 5000 UI HEPARINA SC, COO SIDA USUAL, DEPORTE DE FORTALEZA	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/02	22	CSU.	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/02	22	ADN 12,5 mg GLOMERULOPATIA	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/02	22	ADN 12,5 mg FORTALEZA	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
12/02	23	CUIDADO SE REALIZA HIGIENE Y CUIDADO	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
13/02	01	PTE DESCONOCIDO INTERMITENTE.	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
13/02	06	SE REALIZA HIGIENE Y CUIDADO	Gutierrez C. Gina J. Lic. en Enfermeria M.N. 67290 M.P. 138220
13/02	06	ADN 20 mg OMEPRAZOL VO.	
13/02	00	PTE COO EXAMENADO DURANTE VO.	VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
13/2/2020	8	Heparina 5000 UI SC	
13/2/2020	10	Higiene personal.	
13/2/2020	10	Pte que se encuentra desconocido	VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
13/2/2020	12	Continua con dia subinterna	
13/2/2020	12	dependiente de su totalidad, se admite desayuno y almuerzo.	VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
13/2/2020	15	Control de signos vitales	
13/2	16	Paciente con subinterna	
13/2	18	Higiene y confort	
13/4/2020	2200	Revisión en aislamiento de contacto	
	2200	acompañado por familiares, con cura	
	2200	personal, solo renal	
	2200	levamisole 25 mg VO	
	2200	prutina 125 mg VO	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

HISTORIA CLINICA N°

402454.

Apellido y Nombre:

Ruchas RY. MARGARITA.

Unidad I. N°:

Cama: 4.

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
10/2/20	15	Control de signos vitales	AA 91624.
10/2	16.	Dieta general	AA
10/2	18	Contención terapéutica	AA
10/2	20.	Heforina Sódica 5000 U/ml SC	AA
10/2	20.	Libetolol 600 mg IV	AA
10/2	21	pte descargando / ovc y sonda vesical permeable en Asl. de Contacto.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
10/2	21	ASV.	
	22	Adm Guetapine 12,5mg(VO), leonapromazi,	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	22	na 12,5mg(VO)	
10/2	24	pte continuos desechos.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
11/2	03	pte descarga	
11/2	06	se realiza h. gine y confort.	
11/2	07	emp mg 20mg(VO)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
11/2	8	locicet nro deparolizant en	
11/2	8	fermis Seadheristo 1mg	
11/2	8	lid 600mg EV, hipericub	ANA V. PENZKOTER ENFERMERA M.N. 42142
11/2	8	5000 u/s c.	
11/2	10	locicet nro de dep. ovc	ANA V. PENZKOTER ENFERMERA M.N. 42142
11/2	11	Grupo central -supurante	
11/2	12	Guetapine 12,5 mg(VO)	ANA V. PENZKOTER ENFERMERA M.N. 42142
11/2	12	locicet nro deparolizant	
11/2	12	de contacto por KKK.	
11/2/20	15	Control de signos vitales	AA 91624.
11/2	16	Dieta general sin entada	AA
11/2	18	Hipiente y confort	AA
11/2	20.	Heforina Sódica 5000 U/ml SC	AA
	20	catersos ++	
11/2/20	2000	Recinto en aislamiento de contacto	VALDEZ ANA B.
	2100	con as central, sonda vesical,	
	2200	linapromazi 12,5 mg VO, guetapine	VALDEZ ANA B.
	2200	12,5 mg VO	
12/2/20	0300	se da a la ginec. de urgencia	VALDEZ ANA B.
12/2/20	0600	Botado en casa, con el deparolizant	
	0600	no de casa, se da de urgencia	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
8/02	12	Quetiapina 12.5mg (VO)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
8/2	13	pte asistida de ingesta de Alimento	
8/2	14	pte ocupada de fono	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
8/2	16	pte menuda asistida	
8/2	18	H. ginec. perineal cateteris (+)	
8/2	20	Heparina 3000 UI (SC), Linezolid 600mg (IV)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
8/2	20	pte continuas q/contenenci terapéutica	
8/2	21 ⁰⁰	Control de Signos Vitales	AS 91624.
8/2	22	Quetiapina 25mg VO	
8/2	22	Levo mepromazino 12.5mg VO	
9/2/20	03	Paciente desahogado	
9/2/20	06	Higiene y Cuidado	
9/2/20	07	Omeprazol 20mg VO.	
9/2	07	pte depend. de Enfermería, C/AUC y	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	7	sonde Vesical permeable, en Asl. de	
	7	Contacto.	
9/2	8	control de Signos Vitales	
	8	Heparina 3000 UI (SC), Linezolid 600mg (IV)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
9/2	9	se Acondiciona unidad y Pte.	
	9	pte somnolenta, no desayuna, conti-	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	9	nua q/cebecera elevada y borbidos,	
	P	contenida terapéuticamente	
9/2	12	Quetiapina 12.5mg (VO)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
9/2	13	pte ocupada de fono (Hijo)	
9/2	16	Acondiciona unidad y Pte.	
9/2	20	Heparina 3000 UI (SC), Linezolid 600mg (IV)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
1-2	21	CSV.	
	22	Levo mepromazino 12.5mg VO	
	22	Quetiapina 25mg 1/2 comp VO	
	03	Pte con dificultades para dormir	
	06	Pte que duerme.	
10/2/20	08	extracrista Toma Tuestro de Sangre	
10/2/20	08	para laboratorio	
10/2/2020	8hs	Pte dependiente de enf, con AC,	VIVIANA DE FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 55.66
		SE y AVC central permeable.	
		Se administra heparina 3000 UI	
		SC, Linezolid 600mg EV.	436393
	9hs	Se asiste en la ingesta de	
		alimentos.	
	10hs	Se administra quetiapina 25	
		mg VO.	436393



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

HISTORIA CLINICA N°

402459

Apellido y Nombre:

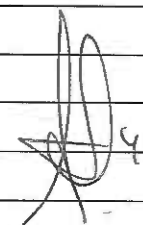
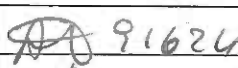
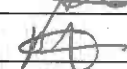
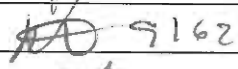
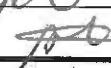
KUCHASKY MARGARITA

Unidad I. N°:

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
6/2/20	20	Hepomine 5000 u/l sc	Al 91624
6/2/20	20	Linezolid 600 mg vo.	Al
6/2/20	20	Contención Torácica	Al
6/2	21 ^{ra}	PTE dependiente, PARMONOS con Ate 40 con 88 mgd, 8u	G. Ginc. J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 158.20
6/2	22	OSU.	G. Ginc. J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 158.20
6/2	22	ADG 12.5 g. CROCHOMUS W,	G. Ginc. J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 158.20
6/2	22	ADG 12.5 g. CROCHOMUS W,	G. Ginc. J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 158.20
7/2	01	PTE DESCANSADO.	G. Ginc. J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 158.20
7/2	06	CAMUS (P) SE realiza 340 EN OSU.	G. Ginc. J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 158.20
7/2/2020	8	Hepomine 5000 u/l sc.	G. FIGUEROA LIC. EN ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
7/2/2020	8	Linezolid 600 mg vo.	G. FIGUEROA LIC. EN ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
7/2/2020	8	pte dependiente en se Toroidal	G. FIGUEROA LIC. EN ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
7/2/2020	12	Re Penele -	
7/2/20	15	Control de signos vitales	Al 91624
7/2/20	15	paciente desorientada	Al
7/2/20	16	Dieta genl Supr. Inhibio	Al
7/2/20	20	Hepomine 5000 u/l sc	Al
7/2/20	20	Linezolid 600 mg vo	Al
7/2/20	21:00	Recibe en círculo de contacto	
	21:00	con oxígeno perineal, con la nasal	
	21:00	Penicilina 12.5 mg vo	VALDEZ ANA B.
	22:00	penicilina 12.5 mg vo	VALDEZ ANA B.
8/2/2020	03:00	se da de pte de paciente desorientada	VALDEZ ANA B.
8/2/2020	06:00	Higiene de la cavidad perineal, se le da dieta genl, suero oral 20 mg vo	VALDEZ ANA B.
8/2	07	pte de pnd. de Enfermera, 1/ave y sonda vesical permeable, en Anal. de Contor to	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
8/2	8	Control de signos vitales.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	8	Hepomine 5000 u/l sc, Linezolid 600 mg (vo),	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
8/2	9	pte asistido en Ingesta de alimentos.	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
8/2	10	se realiza higiene perineal, cateterismo	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
4/2/20	13:30	Pte regreso al servicio.-	 436393
4/2/20	14.	PTE DEPENDIENTE DEMANDANTE.	
4/2	15	CSU.	
4/2	16	DDT. 25mg piroxicam VO.	Gutierrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138.20
4/2	18	SE realiza higiene y confort.	
4/2	20.	DDT. 600 mg linezolid VO.	Gutierrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138.20
4/2	20	DDT. 5000 UH heparina subc.	
4/2	21 ^{ra}	PTE DEPENDIENTE DEMANDANTE COO. AP 400mg PPI-72g; 8V6 COO COCTEO 200 PIRICA.	Gutierrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138.20
4/2	22	CSU.	Gutierrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138.20
4/2	27	DDT 50mg piroxicam VO.	Gutierrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138.20
4/2	23	PTE DESORDENADO	Gutierrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138.20
4/2	00	PTE SE realiza higiene y confort.	
5/2/2020	8hs	Pte dependiente de enf, con ADP permeable y su permeable.-	
		Se administra linezolid 1 sachet EV; heparina 5000 UH SC.	 436393
	10hs	Se administra gacitapina 25 mg VO.-	
	12hs	Pte recibe visita de flia.-	
5/2/20	15	Control de signos vitales	 91624.
5/2/20	16	Dato físico, bien estado	
5/2/20.	20	Hipovolemia 5000 UH SC	
5/2/20.	20	Linezolid 600 mg VO	
5/2/20	20	Control tripartito	
6/2/20	21 ⁰⁰	CSU.	
	22 ⁰⁰	Quetiapina 125mg VO.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
		levomepromazina 125mg VO.	
	24 ⁰⁰	Pte dependiente de enf.	
		AVC, su permeable.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
6/2/20	03 ⁰⁰	Pte de descanso.	
	06 ⁰⁰	Higiene y confort.	
	07 ⁰⁰	Omeprazol 20mg VO.	Alicia M. Stancheff Enfermera FM. 434427
6/2/2020	8	Hipovolemia 5000 UH SC	VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310/222 M.N. 63.663
6/2/2020	8	Linezolid 600mg VO	
6/2/2020	8	Pte dependiente en su totalidad.	
6/2/2020	12	sin confort	VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310/222 M.N. 63.663
6/2/2020	12	retardo de desarrollo.	
6/2/20	15	Control de signos vitales	 91624.
6/2/20	18	Higiene y confort	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

Pinar

HISTORIA CLINICA N°

402454

Apellido y Nombre:

KUCHASKY FRANCISCA

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
03/02	14	CSU. Desmontada, AP. su ABC	 GLADYS GARCIA Enfermera Profesional M.N. 28585 M.P. 126235
	14	posicionada a la cama.	
	16	asistencia personal.	
03/02	18	higiene y confort, aplica crema sobre pecho y gluteos.	 86585
	20	Leptanina Sodica 5000 UI SC	
03/02	20	Linezolid 600 mg EV.	
	20	Catagris 44	 CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
03/02	21	pte depend. de Enfermeras, semiconsciente	
03/2	22	pte c/ AP y salud. vesical permeable	
	22	Asm Quetiapina 25mg (10) / fr. buenda	 CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	22	bien sentada, se acord pte p/ personal	
03/2	24	pte descansando, come c/ bocado elev	
	24	meds	 CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
04/2	02	pte descansando	
04/12	06	se realiza higiene y confort.	
	07	Pte acondicionada en cama, se le da la higiene, se orinó por sus medios, el acceso venoso perfecto se intento reevaluación con resultado negativo.	 ABEL MUÑOZ Aux. de Enfermería M.N. 39.028
4/2/2020	8	Pte pierde orina, imposible	
4/2/2020	8	de colocación, se orina a TRB.	
4/2/2020	8	11 puntos foveales.	 VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
4/2/2020	8	Se expone para la colocación de	
4/2/2020	8	Linezolid 600mg EV.	
4/2/2020	10	Baño en cama, Catagris 44.	 VIVIANA G. FIGUEROA LIC. ENFERMERIA F.M. 310.222 M.N. 63.663
4/2/2020	10	Se coloca acceso venoso Abbocath N°22	
4/2/2020	10	y se pasa Linezolid.	
	11	Pte es trasladada a gr. para colocación de AV Central, con éxito queda permeable en vugular derecha.	 436393
	12:30	Regresa a Bto.	
	13hs	Pte trasladada para Rx.	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
1/2/2020	2300	2 intento colar en su nariz, pero	VALDEZ ANAB
	2300	no se consigue el mismo	
2/2/2020	0300	Recubi de feto, putando, lloro a	VALDEZ ANAB
	0300	fambien.	
2/2/2020	0600	Bombido en c. a, colar (m) 2. bruto	VALDEZ ANAB
	0600	diurno	
2/2/2	07	pte depend de enfermeras, tocando	
	7	flamadas abradas, suelta verbal	CASTRO TAPIA GLADYS
	7	permeable	ENFERMERA
02/02	8	Hoparino 8000 (sc) se coloca	M.N. 90816
	8	AUP en urebro sup Derecho, Abocat	
	8	Nº 22. C/PHP a 2.5g 20 f.o. + 20np	CASTRO TAPIA GLADYS
	8	ck	ENFERMERA
	8	se asiste en feto de desayunos	M.N. 90816
02/02	10	se realiza h. gine perineal, cateterista	
02/02	12	piperacilina + tazobactam 4, 5gr (EU)	CASTRO TAPIA GLADYS
02/02	13	Fuente de Alimento Asistido	ENFERMERA
02/02	16	pte feto coherente 45º. se acondiciona	M.N. 90816
02/02	18	piperacilina + tazobactam 4, 5gr (EU)	
02/02	20	Hoparino 8000 (sc)	CASTRO TAPIA GLADYS
02/02	21	PTE DEPENDIENTE DEMANDANTE, COO.	ENFERMERA
		AUTISD COO PP 2.5g, 8V.	M.N. 90816
02/02	22	CBV.	Gutierrez C. Gina J.
02/02	22	ADN 5000 de HIPERINA SOC.	Lic. en Enfermería
03/02	21	ADN PTE 4, 5 gr EU.	M.N. 67290 M.P. 133.20
03/02	21	PTE DESCONOCIDO	Gutierrez C. Gina J.
03/02	06	SE DESCONOCIDA	Lic. en Enfermería
03/02	06	ADN PTE 4, 5 gr EU.	M.N. 67290 M.P. 133.20
03/02	07	PTE DEPENDIENTE DEMANDANTE, COO	Gutierrez C. Gina J.
		AUTISD COO PP 2.5g, 8V.	Lic. en Enfermería
03/02	08	CBV.	M.N. 67290 M.P. 133.20
03/02	08	ADN 5000 de HIPERINA SOC.	Gutierrez C. Gina J.
03/02	09	RIBIDE EL DOSES CONOSCO, COO.	Lic. en Enfermería
03/02		DAPICES DOSES CONOSCO.	M.N. 67290 M.P. 133.20
03/02	10	SE DESISTE A LA IGESTION DE	Gutierrez C. Gina J.
03/02		DESAYUNO.	Lic. en Enfermería
03/02	12	ADN. PTE 4, 5 gr EU.	M.N. 67290 M.P. 133.20
	TM	Se recoloca AUP queda permea-	
		ble.	
	13hs	Con indicación nueva mática se	
		administra linezolid 600 mg EV	436393



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: H. DE CO.

HISTORIA CLINICA N°

402454.

Apellido y Nombre:

KUCHASKY TB. GARCIA.

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
30-1	11	del paciente.	ANA V. BENZKOPF ENFERMERA M.N. 67914
30-1	12	piperacilina 4,5 gr (EU)	
31-1	07	Se toma muestra de orina	
31-1	15	CSV.	
	18	PTZ 4,5 gr (EU)	
	20	Heparina 5000 UI (SC)	
31-01	21	Pte dependiente de sup. de AUC y sang.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67230 M.P. 133.20
		con AUC 4,5 gr RP 4,5 gr, 8U.	
31-01	22	CSV.	
31-01	22	Se toman cultivos de Kt.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67230 M.P. 133.20
31-01	22	Se toman cultivos de orina	
31-01	22	Donde se toman muestras de	
01-02	24	Donde se toman muestras de	
01-02	01	Pte dependiente de sup. de AUC y sang.	Gutiérrez C. Gina J. Lic. en Enfermería M.N. 67230 M.P. 133.20
01-02	06	Donde se toman muestras de	
01-02	07	pte dependiente de sup. de AUC y sang.	
	7	vernal permeable, descomposta	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	7	con AUC de bacteria clorada	
01-02	08	Control de signos vitales.	
	08	Heparina 5000 UI (SC)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
01-02	10 ⁴⁰	se realiza baño en cama, cambio de	
	10 ⁴⁵	ropa de cama	
01-02	12	piperacilina + tazobactam 4,5 gr (EU)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	12	quechua 2 gr (EU)	
01-02	14	pte tranquila	
01-02	18	piperacilina + tazobactam 4,5 gr (EU)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	18	se administran unidades y pte.	
01-02	20	Heparina 5000 UI (SC)	CASTRO TAPIA GLADYS ENFERMERA M.N. 90816
	20	pte es asistido en ingesta oral	
	20	de alimento durante el baño	
01-02	20	según sensorio.	
1/2/20	200	Paciente compensada por fíbriles, curre	VALDEZ ANA B. Lic. en Enfermería M.N. 67914
	200	micción	
1/2/20	2300	Bebe en cama, sedene no control	VALDEZ ANA B. Lic. en Enfermería M.N. 67914
	2300	alido, sin puna de fíbriles, solo refo	



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital: 11 DE 20

HISTORIA CLINICA N°

402 454

Apellido y Nombre:

Kuchas ky NAREBIRTO KAWOR

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
28/1/20	10	sonido vical puente	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1/20	12	HGT =	
28/1/20	12	Piprociclos 9, 10, 11	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
28/1/20	14	Dependiente de elexeriz con Acamp Urolo central, pup, Sonoz Cetol, Colcha de Ate.	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
28/1/20	16	Dependiente de Spie cetle	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
28/1/20	16	HGT. 121 mg/dl	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
28/1/20	18	Oxidacion pta. Nolin deus to	
28/1/20	18	Drinso ppeho 9, 10, 11	
28/1/20	20	Drinso Nipyn - Soro vi se	SAUL ARGUELLO Enfermero F.M. 438001
28/1/20	20	HGT. 139 mg/dl	
28/1	22	Paciente a todo dependiente	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1	22	Examen. ocu de elvoro curan	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1	22	Dep. puente. sonoz vical	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1	22	puente. sonoz vical	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1	22	a familia	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1	22	Se admitio a que fopu sonoz	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
28/1	24	Piprociclos 9, 10, 11	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	01	Paciente dependiente en el fopu	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	05	Paciente pto. por momentos	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	06	Paciente. Sano de la casa	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	06	ocurrencia central - su	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	06	puente. se. obsequio bien	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	06	en grupo de sonoz	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	8	Paciente a todo dependiente	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	8	Examen. ocurrencia	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	8	pup. - sonoz vical	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	8	puente. se. obsequio HGT. 103 mg/dl	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	8	Se admitio a que fopu sonoz	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	10	Se ocurrencia en el fopu	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	11	del paciente.	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	12	HGT. 94 mg/dl	ANA V. PENZKOFER ENFERMERA M.N. 49542
29/1	12	Piprociclos 9, 10, 11	

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
26/1/20	2	Realizo control de SpO ₂ a las 2	
26/1/20	0	Se reanuda suero 0.9% por excepción intestinal, no se logra recolarse.	SAUL ARGUELLO Enfermero M. 43800
26/1/20	0	Administración de oxígeno 5 l/min.	SAUL ARGUELLO Enfermero M. 43800
27/1/20	3	Pte despierta, tranquilo	SAUL ARGUELLO Enfermero M. 43800
27/1/20	5	hiperpequeño, Rota de pecho	
28/1/20	8	Se extrae sangre para labo	332108
28/1/20	0	no se logra extraer	
		Pte dependiente de enf, descan- sando. Sin AUP.-	
		Se administra heparina 5000 UI SC -	436393
		HGT: 116 mg/dl	
	9hs	Se re intenta colocación de AUP sin éxito.-	
	10:40	Pte es trasladada a qx para colocación de AUC.	436393
		Se realiza cambio de sábanas y colocación de colchón de aire.-	
	12hs	Pte regresa al servicio.-	
28/1/20	18	piropocelero tozobactam 4.5 SC	332108
28/1/20	18	HGT: 101 mg/dl	
28/1/20	20	Heparina 5000 UI SC	332108
28/1/20	5.5	pte dependiente de enfermería	
28/1/20	5.5	con PAP + su. + se co heparina	332108
28/1/20	5.5	se + cambio de sábanas	
28/1/20	5.5	colocación	332108
28/01	20	HGT 142 mg/dl, 3/c	
27/01	22	CFV	MARIELA DE CRISTOFARO ENFERMERA UNIVERSITARIA M.N. 71008
	22	hipertensión, gable. en opst de 2	
28/01	24	piropocelero - tozobactam 4.5 SC	MARIELA DE CRISTOFARO ENFERMERA UNIVERSITARIA M.N. 71008
28/01	06	piropocelero - tozobactam 4.5 SC	
28/1/20	8	lo que se le da de enfermería	
28/1/20	2	enfueria se admiten 20 hipoxia	
28/1/20	2	5000 de SC, se realiza HGT =	
28/1/20	2	118 mg/dl. Por se reanuda	
28/1/20	2	re colocación de AUP	
28/1/20	2	ocurrencias en el	ANITA FENZKOFER ENFERMERA M.N. 4442



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

PARRONIA PARRONIA

HISTORIA CLINICA N°

402454

Apellido y Nombre:

KUCHASKY MARGARITA

Unidad I. N°:

4

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
25/1/2016	0600	Pipracilina 450 mg IV	
	0600	Beber un vaso, cenar y dormir	
	0600	control de signos vitales, 2 de cada 4 días	
	0600	respirar	
25/01	8	CSU 15ml, 1 c. adm. 2 p. por EV	
	8	heparina 5000 UI S/C	
	8	HGT: 118 mg/dl	
	8	paciente bañado en cama	
25/01	12	HGT: 120 mg/dl	
	12	Piperacilina - tozobactam 4,5 gr EV	
	16	liposol 100 mg EV - HGT: 18 mg/dl	
	18	Piperacilina - tozobactam 4,5 gr EV	
25/01	20	heparina 5000 UI S/C	
	20	HGT: 13 mg/dl	
25/01	20	PTE dependiente, DEMASIADO	
		COO SUP O2 COO P4 2/8	
		SADA USION, COO P4 2/8	
		R2 COO 1/8	
25/01	22	CSU	
25/01	22	ADN 50 mg POETAPROL W	
26/01	24	ADN 124,5 mg EV	
26/01	01	PTE 1200 mg	
26/01	06	ADN 124,5 mg EV	
26/01	8	CSU	
	8	heparina 5000 UI S/C	
	8	HGT: 12 mg/dl	
	8	paciente bañado en cama	
		opon de O2 10 pnt fteca	
		permisible	
26/01	12	HGT: 76 mg/dl	
	12	Piperacilina - tozobactam 4,5 gr EV	
	16	HGT: 116 mg/dl	
	16	liposol 100 mg	
	18	Piperacilina - tozobactam 4,5 gr EV	
26/01	20	heparina 5000 UI S/C	
	20	HGT: 14 mg/dl	

JALDEZANA B.
Lic. Enfermería
M.N. 67914MARIELA DE CRISTOFARO
Enfermera Profesional
M.N. 71008MARIELA DE CRISTOFARO
Enfermera Profesional
M.N. 71008MARIELA DE CRISTOFARO
Enfermera Profesional
M.N. 71008Gutiérrez C. S.
Lic. en Enfermería
M.N. 61200 M.P. 100Gutiérrez C. S.
Lic. en Enfermería
M.N. 61200 M.P. 100Gutiérrez C. S.
Lic. en Enfermería
M.N. 61200 M.P. 100MARIELA DE CRISTOFARO
Enfermera Profesional
M.N. 71008MARIELA DE CRISTOFARO
Enfermera Profesional
M.N. 71008MARIELA DE CRISTOFARO
Enfermera Profesional
M.N. 71008

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
23/1/20	20	HGT: 141 mg/dl	 334168
23/1/20	20	pt. dependiente de enfermería	 /
23/1/20	21	no estable	 334168
23/01/20	21	PREDEPENDIENTE DEPENDIENTE; C/O APND C/O HP 148; SADA C/O C/O DROTE DE OXIGENO PR C/O MAGDA	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
23/01	22	CSU	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
23/01	22	ADD DE SO y JOSEFINA W, 4tu DADA	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	29	ADD ADS 1,5 y EU	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	01	PREDESCUJANDO	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	06	CATAPLASMA (4) ESTOMAGO; S. 1000g ONDO DE PANGS y 1000g de C/O	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	06	ADD ADS 1,5 y EU	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	08	PRE-DEPENDIENTE DEPENDIENTE; C/O APND C/O HP 148; SADA C/O C/O DROTE DE O2 POR C/O MAGDA	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	08	CSU	
24/01	08	HGT 152 mg/dl	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	08	ADD. 5000 de KAPALA 80c	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	10	PRE-DEPENDIENTE	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	12	SE ADD. ADS 1,5 y EU	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01	12	HGT 141 mg/dl	Gutiérrez C. Sina J. Lic. en Enfermería M.N. 67290 M.P. 138°20
24/01/20	14	Dependencia en C/O Ca C/O de C/O	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	16	Revisión control de pie w/te	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	16	HGT. 138 mg/dl	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	17	Revisión de S/O con + Tom de marcha por C/O	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	18	Revisión de S/O con + Tom de marcha por C/O	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	18	hipertensión, dolor de cabeza	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	20	Admisión de S/O con + Tom de marcha por C/O	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/01/20	20	HGT 153 mg/dl	SAUL ARGÜELLO Enfermero F.M. 438001
24/1/20	2000	Revisión de S/O con + Tom de marcha por C/O	VALDEZANA B. Lic. en Enfermería M.N. 67914
25/1/20	0300	Revisión de S/O con + Tom de marcha por C/O	VALDEZANA B. Lic. en Enfermería M.N. 67914



MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE ENFERMERIA

G. C. B. A.

Hospital:

HISTORIA CLINICA N°

402 454.

Apellido y Nombre:

Kuchaskey Margarita.

Unidad I. N°:

04.

Cama:

4

FECHA	HORA	REGISTRO DE MEDICACION Y TRATAMIENTOS	FIRMA DE LA ENFERMERA
22/1	1500	pt. de 45 años de edad que ingresa derivado al Servicio de lo geriatrico con P4P + su permanente. un diagnostico de deterioro cognitivo con antecedentes de esquizofre nia + TWP + gestitos	334468
22/01	16	pt. ingresado + cambio de pomos, cohorte +	334468
22/01/20	16	VAA ca 34 St + 15 pot. Subtotal	SAUL ARGÜELLO Enfermero N.º 43800
22/01/20	16	Darsto H2lepol 0,5 y 10.	SAUL ARGÜELLO Enfermero N.º 43800
22/01/20	18	Darsto Daptulbuta 4,5 pi. N.	SAUL ARGÜELLO Enfermero N.º 43800
22/01/20	20	Preparar el C2M ca C2deca decaol	
22/1	21	pt. se anuncia ocaso menor periférico, se recibe se cae la ropa de cama y se realiza contención terapeu tica	4343P8
	22	Quetiapina 50mg	
	23	Ampicilina-sulbactam 1,5 p/v	
	3	Stu dexauro	
23/1	6	Ampicilina-sulbactam 1,5 p/v	
23/1/20	8	se anota sangre para coagula	334468
23/1/20	8	se anota sangre para coagula	
23/1	8	Ureaprazol 2mg (p).	
	8	Heposine 500mg	
	8	HGT 115 mg/dl.	
	8	NBZ dSF + 2 p.v. Hlogiprotexi	4343P8
	10	pt. deprimido con P4P, 8v.	
	12	Ampicilina-sulbactam 1,5 p/v	
23/1	12	HGT 185 mg/dl.	
23/1/20	16	HGT 143 mg/dl	334468
23/1/20	18	ampi - sulbactam 1,5 mg 8v	
23/1/20	20	Heposine 500mg 8v	334468



G.C.B.A.

HOSPITAL:

CONTROLES Y BALANCES (A)

N°

DÍA MES AÑO

APELLIDO Y NOMBRES:

Kucbasak Hacıgözüte.

EDAD:

GRUPO SANGÜINEO:

CAMA:

HIST. CL. N° 402454

PESO:

DIAGNOSTICO:

CONTROLES

Fecha	Hora	Temperatura		Resp.	Pulso	P. Arterial		P. Ven.	Firma
		Axilar	Rectal			Máx.	Mín.		

OBSERVACIONES

INGRESOS				V. ORAL		EGRESOS			
V. PARENTERAL		V. ORAL		VIA					
Tipo Sol.	Cant. Colocó	Cant. Pasó	Tipo Sol.	Cant.	Dep.	Orina	Vóm.	Drenaj.	Otros

23/1	15	34.9			62	126	70												
22/1	22	36			75	110	70												
24/1	06																		
23/1	08	37.3			71	138	70												
23/1	14																		
23/1	18																		
23/1	18	35			70	128	89												
24/1	22	36.8			92	141	73	96%											
24/1	06																		
24/1	08	37.6			83	122	70												
24/1	16	31.4			74	124	80												
24/1	22	37			80	120	70												
25/1	06																		
25/1	08	38.2			92	175	69	79											
25/1	20																		
25/1	22	37.5			90	132	68	98%											
26/1	00	-																	
26/1	05	36			77	110	59	97%											

Rochinsky, Margaret

EDAD:

GRUPO SANGUINEO

CAMA: 9

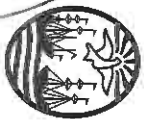
HIST. CL. N° 402934

PESO:

DIAGNOSTICO

CONTROLES

[illegible]



G.C.B.A.

HOSPITAL:

Parmenio Piñero

CONTROLES Y BALANCES (A)

Nº
DIA MES AÑO
10 2 20

APELLIDO Y NOMBRES:

Kuchasky, Margarita

EDAD:

GRUPO SANGUINEO:

CAMA:

4

HIST. CL. N° 402454

PESO:

DIAGNOSTICO:

CONTROLES

OBSERVACIONES

INGRESOS

EGRESOS

Fecha	Hora	Temperatura		Resp.	Pulso	P. Arterial		P. Ven.	Firma	OBSERVACIONES	V. PARENTERAL			V. ORAL		VIA				
		Axilar	Rectal			Max.	Min.				Tipo Sol.	Cant. Colocó	Cant. Pasó	Tipo Sol.	Cant.	Dep.	Orina	Vom.	Drenaj.	Otros
10/2	8hs	35.4			70	140	80													
10/2	22	35.8			71	110	79													
11/02	06																			
11/2	15	36.7			90	110	80													
11/2	20																			
11/11/2	22	36			80	120	70													
12/1	06																			
12/1	08	36.1			92	110	80													
12/2	22				102	116	78													
13/02	06																			
13/2	02	36.8			94	130	80													
13/2	15	36.			90	120	80													
13/2	22	36			80	110	78													
14/02	06																			
14/2	08	36.4			90	112	60													
14/2	15	36.5			70	110	80													
14/2	22				78	120	78													

EDAD: _____ GRUPO SANGUINEO: _____

DIAGNOSTICO:

RESO:

HIST. CL. N°

CAMA: 681.

CONTROLS

OBSERVACIONES

INGRESOS

EGRESOS

[illegible]



G.C.B.A.

HOSPITAL:

P. PISO

CONTROLES Y BALANCES (A)

N°

DÍA MES AÑO

APELLIDO Y NOMBRES:

Kucharsky Margarita

EDAD:

GRUPO SANGUINEO:

CAMA:

4

HIST. CL. N°

402454

PESO:

DIAGNOSTICO:

CONTROLES

Fecha	Hora	Temperatura		Resp.	Pulso	P. Arterial		P. Ven.	Firma
		Axilar	Rectal			Máx.	Mín.		
21/02/06	08	36.7			86	107	80		
21/02/06	15	36.7			70	110	80		
22/02/06	08	35.7			95	127	69	85/96	
23/02/06	08	36.2			49	105	85	96	
23/02/06	21	36.7			80	110	80		
24/02/06	08	35.7			76	106	62	85/91	
25/02/06	08	36.3			81	130	68	97/101	
26/02/06	08	36.1			80	100	70		
26/02/06	08	36.3			76	100	80		
26/02/06	16	36.0			95	111	78		
26/02/06	22				78	117	74	99/106	
27/02/06									

OBSERVACIONES

DROSA 14gr

KCOI 500

INGRESOS

V. PARENTERAL			V. ORAL		
Tipo Sol.	Cant.	Coloco	Tipo Sol.	Cant.	

EGRESOS

VIA		
Dep.	Orina	Vom.

(400) 700

1800

+ 4000 22/12/06 183045

(800) 700

+ (300) 500

KCOI 500

KCOI 500

- 500

(800) 700

EDAD: _____ GRUPO SANGUINEO: _____

DIAGNOSTICO:

POST

HIST. CL. N°

CAMA:

CONTROLS

INGRESOS

EGRESOS

[illegible]

2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

93, 103 72



HOSPITAL: PINEWOOD

Kuehlsky HANSEN

HIST. CL. N° 402454

PESO:

DIAGNOSTICO

EDAD:

GRUPO SANGUÍNEO:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CONTROLES Y BALANCES (A)

[illegible]